

心理危机干预与预防开卷考试速查版

2026-04-21

目录

第1讲：心理危机导论	13
一、课程导入：这门课为什么重要	13
二、任课教师背景与校外求助资源	13
【求助信息】	13
三、老师展示个人科普文章：大学生抑郁症要重在早识别、早预防	14
老师强调的背景判断	14
【学习建议】	14
四、政策背景：健康第一，尤其要重视“心理脆弱”	14
老师提到的“三小”问题	14
五、从“危机（crisis）”讲起：危机的广义概念	14
危机按来源大致可分三类	14
老师的引申	14
六、【考务】本课考试形式与平时成绩	14
【考务】	14
【考务】平时成绩	14
【备考建议】	15
老师说通常什么情况会不及格	15
【考点提示】	15
七、【考点】心理危机（psychological crisis）的定义	15
【考点】心理危机定义	15
【考点】心理危机成立的三条标准	15
1. 有一个“事儿”——即存在生活事件（life event）	15
2. 出现严重反应	15
3. 不能有效自我缓解	15
老师总结式表述	15
八、大学生常见心理危机的极端形式：以自杀为主	15
老师对本校与兄弟院校的比较性评论	15
老师的解释	15
九、【举例 / 临床关联】天津师范大学女大学生因乙肝“大三阳”被孤立后自杀案例	15
案例基本情况	16
事件经过	16
【医学相关】	16
被孤立后的变化	16
学校与辅导员的处理	16
学校后续安排	16
结局	16
遗书内容与心理状态	16
老师对其心理逻辑的概括	16
【易错 / 识别点】	16
引发的争议	16
老师的评价	16
【助人者视角】	17
十、【考点】危机干预（crisis intervention）的概念、目的与意义	17
【考点】危机干预的提出	17
【考点】危机干预的定义	17
【考点】危机干预的两个主要目的	17
【考点】危机干预成功的意义	17
十一、世界范围内的自杀情况：老师用于引入的流行病学比较	17
老师课堂中提到的比较	17
老师进一步讲的趋势	17
老师的口语化总结	17
十二、中国大学生自杀率：老师强调“总体不高，但趋势需警惕”	17

老师的解释	17
【复习/观点】	18
十三、天津市学生自杀的趋势：疫情后出现低龄化	18
趋势	18
老师结论	18
十四、北京某调查总结的大学生自杀规律	18
1) 自杀地点分布	18
解释	18
2) 跳楼楼层分布	18
3) 最主要原因：不适应 (maladjustment)	18
【举例】	18
4) 抑郁 (depression)	18
5) 危机发生时间	19
6) 自杀方式	19
7) 年龄与年级分布	19
老师对毕业年级高发的解释	19
8) 性别差异	19
十五、费立鹏关于中国人自杀原因的总结	19
八大原因	19
【考点理解】	19
十六、中国人与国外自杀模式的差异	19
1) 性别差异不同	19
2) 老师对农村女性高自杀率的解释	20
【举例】	20
3) 年龄差异不同	20
老师的解释	20
十七、精神障碍与躯体疾病也是自杀的重要原因	20
1) 抑郁症 (depression)	20
2) 精神分裂症 (schizophrenia)	20
3) 严重躯体疾病	20
十八、与危机事件相关的常见诱因	21
1) 持续压力 (chronic stress)	21
【举例】单亲家庭	21
2) 财产、健康、名誉、尊严丧失	21
【举例】网络诈骗	21
【学习建议】	21
3) 感情受挫	21
4) 环境改变 (environmental change)	21
5) 持续的人际关系紧张	21
老师的总结	21
十九、人格 (personality) 与心理危机的关系	21
人格的概念	21
容易出现心理危机者常见人格特点	22
另一项研究归纳的心理特点	22
二十、【举例】两个典型案例：一个杀人，一个自杀	22
二十一、【案例一】马加爵：从优秀贫困生到宿舍杀人案	22
基本情况	22
老师先强调的一点	22
入学前后的优秀经历	22
二十二、【案例二】杨元元：从优秀学生干部到研究生宿舍自杀	22
基本情况	22
自杀方式	22
入学前的优秀经历	22
二十三、两案共同基础之一：贫困 (poverty)	23
马加爵的贫困表现	23
杨元元的贫困表现	23
二十四、两案共同基础之二：学业受挫	23
马加爵的学业受挫	23
杨元元的学业受挫	23
二十五、两案共同基础之三：感情受挫	23
马加爵	23
杨元元	23
二十六、两案爆发前的关键人际冲突	23
马加爵的爆发点	23
1. 被最看重的朋友排除在外	23
2. 打牌时被指“作弊”，并被拿“人品差”羞辱	23

之后的发展	24
【举例中的老师提示】	24
二十七、杨元元案中的关键人际冲突：贫困、母亲、宿舍与羞辱感	24
事件背景	24
冲突升级	24
她的主观体验	24
二十八、老师对两案的心理学分析（一）：欲求的绝对性	24
欲求的绝对性是什么意思	24
在马加爵身上的表现	24
在杨元元身上的表现	24
老师结论	24
二十九、老师对两案的心理学分析（二）：感知的歪曲性	24
马加爵身上的例子	24
三十、老师对两案的心理学分析（三）：思维的消极性	25
表现	25
例子	25
三十一、老师对两案的心理学分析（四）：应对的非理性	25
马加爵	25
杨元元	25
三十二、老师总结两案共有的人格与心理特点	25
1. 高敏感	25
2. 高自尊	25
3. 执着、倔强	25
老师的概括性结论	25
三十三、【举例 / 本校案例】过度要强、宿舍关系差、学习方法僵化，最终精神失常边缘	25
基本情况	25
入学后的目标	26
短板一：看不起别人，宿舍关系恶化	26
短板二：学习方法僵化	26
结果	26
后续处理	26
【临床关联 / 风险提醒】	26
【举例】复旦投毒案	26
三十四、本段结尾处老师的未完提醒	26
本节英文术语索引	27
第2讲：心理危机的常见原因	28
主题：心理危机的常见原因（第2次课）	28
一、开场与本次课程主题	28
二、【复习】危机（crisis）的基本概念	28
1. 危机可以指“突发事件”本身	28
2. 危机也可以指“人所处的紧急失衡状态”	28
3. 危机的核心含义	28
4. 危机并不单由事件本身决定，而取决于个体的应对能力	28
三、【举例】以考试说明“危机感”的形成	28
1. 过去的生活中，很多“特别棘手的事”都可能让人感到危机	28
2. 【课堂提醒】执业医师考试对很多医学生来说会构成危机	28
四、心理危机的表现与潜伏性	29
1. 当事人不一定总能立刻察觉自己处于心理危机中	29
2. 表面看似“正常”的行为模式下，也可能潜伏危机	29
五、【重点】成瘾行为背后的心理危机	29
1. 【课堂提问】最常见的精神活性物质滥用是什么	29
2. 匿名戒酒者协会	29
3. 【核心观点】成瘾往往只是表面现象	29
4. 只“戒行为”往往治标不治本	29
六、【复习】心理危机原因的多元性：生物—心理—社会医学模式	30
七、生物生理层面：季节、光照与情绪变化	30
1. 冬天常见的身心变化	30
2. 原因：北半球冬季光照减少	30
3. 光照减少对脑内神经递质的影响	30
4. 【考点味很浓】季节性情感障碍 SAD	30
5. 高纬度地区患病率更高	30
八、【机制讲解】为什么情绪不好时容易想吃碳水	31
1. 情绪差时，很多人偏爱碳水食物	31
2. 生化机制	31
3. 结论	31
九、社会文化层面：人不仅是生物学的人，也是社会文化的人	31

1. 【举例】男女衬衫开襟方向不同	31
男装为什么左压右	31
女装为什么相反	31
2. 【举例】东京与大阪自动扶梯左右站位不同	31
东京（江户）为什么靠左	32
大阪为什么靠右	32
十、心理层面：人格、选择与“后悔”	32
1. 关于“后悔过去的决定”	32
2. 老师的观点：很多后悔是“事后诸葛亮视角”	32
3. 结论	32
十一、心理危机原因的呈现方式：两种典型模型	32
1. 左图：山上巨石突然滚落	32
2. 右图：鞋里不断进沙子	32
3. 【举例】中年人的日常“沙子”	32
十二、心理危机原因总分类：外部原因与内部原因	33
1. 外部原因	33
2. 内部原因	33
十三、生态环境导致的心理危机	33
1. 主要类型	33
2. 共同特点	33
十四、【临床关联】流行病高峰与儿科医疗系统压力	33
1. 【举例】老师路过天津老儿童医院的观察	33
2. 【临床观察】儿科急诊系统承压	33
3. 【临床关联】天津与深圳儿童医院分诊体系对比	33
天津常见情况	33
深圳儿童医院模式	33
十五、【举例】重大生态灾难与创伤反应	34
1. 唐山大地震（1976）	34
2. 切尔诺贝利核泄漏（Chernobyl disaster）	34
3. 【举例】SARS（2003）	34
4. 汶川地震（2008）	34
5. 东日本大地震（2011）与福岛核泄漏	34
十六、【举例】福岛核泄漏后的“抢盐”现象：群体性荒谬反应	34
1. 当年出现“抢盐潮”	34
2. 谣言的演变过程	34
3. 【课堂提醒】从医学角度看待“吃盐防辐射”	34
4. 【重点】心理危机可用荒谬形式爆发	35
十七、【举例】812 天津港爆炸事故	35
十八、【举例】新冠疫情及其后果	35
1. 放开后的群体性影响	35
2. 老师的社会观察	35
十九、社会环境导致的心理危机	35
二十、【课堂举例】恐怖袭击、人质事件与战争	35
1. 9·11 事件	35
2. 别斯兰人质事件（2004）	36
3. 【时事举例】伊朗局势与霍尔木兹海峡	36
二十一、【举例】恶性无差别伤害事件与社会安全感受损	36
1. 福建南平实验小学案（2010）	36
2. 老师的个人记忆	36
3. 近年的无差别袭击事件	36
二十二、学业与就业压力：多数人更常见的危机来源	36
1. 【课堂提醒】医学并不意味着“天然好就业”	36
2. 【学习建议】医学生在校期间就要完成从“学生”到“医生”的转换	36
二十三、【临床关联】医生职业的工作压力	37
1. 医生的工作节奏很辛苦	37
2. 【课堂提醒】汇报病例不是照着病历念	37
3. 医生常常下班不由自主	37
4. 老师的概括	37
二十四、【举例】996、007 与高压劳动	37
1. 996	37
2. 007	37
3. 老师观点	37
二十五、【举例】富士康事件与 EAP	37
1. EAP	37
2. 老师指出的问题	37
3. 结论	37

二十六、经济压力与现实生活困境	38
1. 收入与生活压力	38
2. 房地产问题	38
3. 【举例】真实“蜗居”	38
二十七、【举例】股市暴跌与金融压力	38
1. 杠杆风险	38
2. 【举例】2015 年股灾	38
二十八、婚恋压力与人际失败	38
1. 【举例】天津中心公园“婚恋市场”	38
2. 老师借出生率变化说明	38
3. 【举例】由单身羞辱引发的极端事件	38
二十九、家庭矛盾：最常见也最容易被忽视的危机来源	39
1. 【举例】辅导作业导致家长崩溃	39
2. 网络段子中的家庭情绪调节	39
3. 【学习建议/教育理念】不要总替孩子改作业	39
三十、健康状况与心理危机	39
1. 相关类型	39
2. 【举例】艾滋病防治宣传	39
3. 【举例】隐瞒精神病史引发的极端案件	39
三十一、人格与应对方式：心理危机的内部基础	39
1. 人格的定义	40
2. 人格的特征	40
(1) 社会性	40
(2) 独特性	40
(3) 稳定性	40
(4) 可塑性	40
三十二、人格的构成：气质、性格、能力	40
【比喻】	40
三十三、【复习】四种基本气质类型	40
1. 胆汁质 (choleric temperament)	40
2. 多血质 (sanguine temperament)	40
3. 黏液质 (phlegmatic temperament)	40
4. 抑郁质 (melancholic temperament)	40
三十四、性格与环境：后天塑造的重要性	41
三十五、人格发展的特点	41
1. 随年龄呈抛物线式变化	41
2. 变化速度慢	41
3. 受环境影响很大	41
三十六、人格素质、人格问题与人格障碍	41
1. 人格素质本身无绝对好坏	41
2. 【概念纠正】强迫特质 ≠ 强迫症	41
3. 健康人格的特点	41
4. 人格问题/人格障碍 (personality disorder)	41
三十七、【举例】超前消费、网贷与人格问题	42
【课堂提醒】	42
三十八、【举例】马加爵案：人格长期压抑与极端爆发	42
1. 事件概括	42
2. 老师借此强调	42
3. 【学习建议/做人提醒】	42
4. 【举例】“一饭之恩”救命	42
5. 【学习建议】	42
三十九、课末补充：当前教育要求	42
录音结尾情况	42
本节英文术语索引	42
第 3 讲：心理危机的表现、应激与自杀	44
一、课前说明与课堂安排	44
二、课程导入：什么是“危机 (crisis)”与“心理危机 (psychological crisis)”	44
1. 危机的两个含义	44
2. 心理危机的定义	44
三、心理危机干预 (crisis intervention) 的基本含义	44
1. 判断是否达到“心理危机”的三个标准	44
2. 心理危机干预的分类	45
四、按刺激来源划分的危机类型	45
1. 发展性危机 (developmental crisis)	45
2. 境遇性危机 (situational crisis)	45
3. 存在性危机 (existential crisis)	45

五、按发生过程划分危机；危机后的四个阶段	46
1. 危机按进程可分为	46
2. 危机发生后的四个阶段	46
(1) 冲击期 (impact phase)	46
(2) 防御期 (defensive phase)	46
(3) 解决期 (resolution phase)	46
(4) 成长期 (growth phase)	46
六、本节课聚焦的三个重点问题	46
七、精神科两套常见诊断系统	46
八、急性应激障碍 (Acute Stress Disorder, ASD)	47
1. 定义	47
2. 常见应激事件	47
3. 临床表现	47
(1) 意识范围狭窄、意识清晰度下降	47
(2) 闯入性再体验	47
(3) 精神运动性抑制或兴奋	47
(4) 警觉性增高 (hyperarousal)	47
(5) 回避与选择性遗忘	48
(6) 分离症状：人格解体与现实解体	48
4. 病程演变	48
5. 急性应激障碍的亚型	48
6. DSM-5 诊断标准 (课堂版梳理)	48
A 标准：暴露于创伤事件	48
B 标准：五大类症状中总计至少 9 条	48
C 标准：病程标准	49
D 标准：社会功能损害	49
E 标准：排除标准	49
7. 预防与治疗	49
(1) 预防	49
(2) 支持疗法 (supportive therapy)	49
(3) 心理治疗	49
(4) 药物治疗	49
九、创伤后应激障碍 (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD)	50
1. 定义	50
2. 核心症状	50
3. 流行病学与危险因素	50
4. 结合视频理解 PTSD	50
5. PTSD 的临床表现	50
(1) 创伤性再体验 (re-experiencing)	50
(2) 回避与麻木 (avoidance and numbing)	51
(3) 分离症状：人格解体/现实解体	51
(4) 警觉性增高	51
(5) 伴随问题	51
6. PTSD 的诊断标准 (课堂版)	51
A 标准	52
B 标准：侵入性症状至少 1 条	52
C 标准：回避	52
D 标准：认知和心境负性改变，至少 2 条	52
E 标准：警觉性和反应性改变，至少 2 条	52
F 标准：病程	52
G 标准	52
H 标准	52
7. PTSD 的治疗	52
(1) 药物治疗	52
(2) 心理治疗	53
(3) 焦虑处理训练	53
(4) 其他治疗	53
十、第一节课结尾：引入“自杀”话题与教学项目招募	53
十一、第二节课开始：AI 视频中的自杀未遂与抑郁症表现	53
1. 视频中展示的自杀未遂体验	53
2. 视频中呈现的抑郁症体验	54
(1) 兴趣丧失 / 快感缺失	54
(2) 意志活动减退	54
(3) 注意力与决策功能下降	54
(4) 精神运动性迟滞/僵住	54
(5) 睡眠紊乱	54
3. 课堂说明：视频并未囊括抑郁全部症状	54

十二、老师再次介绍 AI 教学视频项目	54
十三、自杀（suicide）话题正式开始：先纠正“觉得好笑”的态度	55
十四、自杀的流行病学：总体情况	55
1. 全球情况	55
2. 中国城乡差异	55
3. 性别差异	55
4. 家族聚集性	55
5. 全球青年死因排序	55
十五、大学生自杀：老师重点展开	55
1. 大学生自杀率并不一定高于同龄总体人群	55
2. 但仍绝不能掉以轻心	55
3. 大学生自杀的一些特点	56
4. 常见方式与“网约自杀”	56
5. 纪念日	56
十六、自杀相关概念辨析	56
1. 自杀意念（suicidal ideation）	56
2. 自杀计划（suicide plan）	56
3. 自伤行为（self-harm）	56
4. 自杀未遂（suicide attempt）	56
5. 自杀企图	56
6. 自杀死亡（completed suicide）	56
十七、两个特殊概念：扩大性自杀与间接自杀	57
1. 扩大性自杀	57
2. 间接自杀	57
十八、两个案例：扩大性自杀与间接自杀	57
1. 扩大性自杀案例	57
2. 间接自杀案例	57
十九、自杀方式的分布特点	58
1. 年龄差异	58
2. 性别差异	58
3. 城乡差异	58
二十、自杀的成因：生物—心理—社会多因素模型	58
1. 医学遗传学方面	58
2. 应激-易感模型（stress-diathesis model）	58
3. 神经生化方面	58
二十一、社会心理因素：哪些人更容易走向自杀	58
1. 社会支持不足	59
2. 负性生活事件	59
3. 儿童青少年早期经历	59
4. 家庭精神病理背景	59
二十二、自杀者的常见心理特征	59
1. 认知特点	59
2. 情感特点	59
3. 意志与行为特点	59
二十三、自杀的社会性因素	60
1. 年龄	60
2. 婚姻与家庭	60
3. 社会阶层	60
4. 宗教与文化	60
二十四、与自杀密切相关的精神障碍与躯体疾病	60
1. 精神障碍	60
（1）抑郁症（depression）	60
（2）双相障碍（bipolar disorder）	60
（3）PTSD	60
（4）精神分裂症（schizophrenia）	60
（5）焦虑障碍（anxiety disorders）	60
（6）老年期痴呆	61
2. 躯体疾病	61
二十五、关于自杀的常见误解，老师逐条纠正	61
1. “自杀不可预防”	61
2. “自杀没有预兆”	61
3. “自杀的人就是真的一心求死”	61
4. “谈自杀的人不会真的去死”	61
5. “有自杀想法的人就是精神病”	61
6. “不能和有自杀念头的人谈自杀”	61
7. “自杀危机缓解了就没事了”	61

二十六、自杀的先兆表现：老师反复强调要会识别	61
1. 高危线索	61
2. 言语线索	62
3. 行为线索	62
二十七、几个特别需要提高警惕的人群与时段	62
二十八、本节内容的结尾情况	62
本节英文术语索引	62
第4讲：预防、依恋与危机干预	64
一、课程导入：什么是心理危机，为什么要讲“预防”	64
二、心理危机的影响因素：先看哪些人风险更高	64
1. 生物学因素（biological factors）	64
三、心理因素：哪些人格与认知模式容易把人推向危机	64
1. 易损人格特质：完美主义（perfectionism）	64
（1）积极维度：高标准、高期待	65
（2）消极维度：高批评（self-criticism）	65
2. 冲动性（impulsivity）与情绪调节失调	65
（1）先天神经冲动性差异	65
（2）情绪调节功能失调	65
3. 失调的认知图式（cognitive schema）	65
（1）关于自我的图式	66
（2）关于他人的图式	66
（3）关于世界的图式	66
4. 问题解决不足（poor problem solving）	66
5. 对自身问题解决能力缺乏信心	67
四、应激事件：危机的“扳机点”（trigger）	67
五、应激事件的常见类型	67
1. 突发事件	67
2. 严重身体疾病	67
3. 环境适应不良	68
六、大学适应问题：宿舍、学习、人际、自律都可能成为危机来源	68
1. 第一次住校、过集体生活的适应	68
2. 私人边界与宿舍摩擦	68
3. 大学生活的自由与空虚	68
4. 学业压力与学习困难	68
5. 家庭贫困与经济负担	68
6. 人际关系失调、就业困难、考研失败	69
7. 同伴危机的“传染性”影响	69
七、创伤（trauma）：心理危机背后的深层因素	69
1. 创伤的基本含义	69
2. 创伤会动摇人的基本信念	69
八、依恋（attachment）与依恋创伤：危机的关键背景	69
1. 为什么要讲依恋创伤	69
2. 依恋的定义	69
3. 零到一岁的核心心理任务：建立信任感	70
九、依恋实验：小猴子更需要“情感抚慰”而不只是喂养	70
十、依恋的形成：生命早期“跟谁长大”非常重要	70
十一、依恋如何影响成人后的恋爱与人际关系	70
十二、四种依恋类型（attachment styles）	71
1. 安全型依恋（secure attachment）	71
2. 回避型依恋（avoidant attachment）	71
3. 焦虑型/抵抗型依恋（anxious/resistant attachment）	71
4. 紊乱型依恋（disorganized attachment）	71
十三、依恋创伤如何在危机中被激活	71
十四、创伤会让人更渴求关系，但又可能不信任关系	72
十五、强迫性重复（repetition compulsion）：为什么总是找“同一类人”	72
十六、依恋创伤的后果：基本信任被破坏，情绪与认同都会受影响	72
十七、创伤不一定只发生在童年，成年后的重大创伤同样深重	73
十八、创伤如何在后来事件中被重新唤醒	73
1. 童年羞耻创伤被研究生阶段激活	73
2. 失恋激活早年被抛弃经历	73
十九、如何预防心理危机：从可改变的部分入手	73
二十、【学习建议】调整完美主义：允许自己做不到“样样都好”	73
1. 人格会逐渐固化，但大学阶段仍很有可塑性	73
2. 不能要求自己所有维度都完美	74
3. 允许自己在“不重要的方面”不那么优秀	74
二十一、【学习建议】减少冲动性：先给自己一个“缓冲地带”	74

二十二、【学习建议】修正失调认知图式：重新看待自己、他人和世界	74
1. 重新看待自己	74
2. 重新看待别人	74
二十三、【学习建议】提高问题解决能力：不要只靠自己死扛	75
1. 要看到其他人的视角	75
二十四、【学习建议】理解创伤对自己的影响，并尝试疗愈	75
二十五、【学习建议】必要时寻求心理咨询（psychological counseling）	75
二十六、【学习建议】同辈互助：同学、室友、学长学姐都是重要资源	76
二十七、【考点/提醒】作为同伴，也要学会识别危险信号并及时转介	76
二十八、危机干预（crisis intervention）的基本技巧	76
1. 倾听（listening）	76
倾听包括两部分：	76
2. 共情（empathy）	77
3. 情感反应（emotional reflection）	77
4. 具体化（concretization）	77
5. 帮助寻找资源（resources）	77
6. 拓宽可能性（expand possibilities）	77
7. 灌注希望（instill hope）	78
二十九、什么时候做危机干预：不是越早越好	78
三十、危机/创伤干预的三个阶段	78
第一阶段：稳定化（stabilization）	78
第二阶段：创伤暴露与处理（trauma exposure / processing）	78
第三阶段：重建意义（meaning reconstruction）	79
本节英文术语索引	79
第5讲：法律伦理、系统视角、树理论与自杀识别	80
一、上节课回顾与本节课导入	80
二、心理危机干预中的法律与伦理问题	80
1. 保密原则不是绝对的	80
情境一：来访者明确表达自杀计划	80
情境二：来访者表达伤害他人的计划	80
情境三：涉及违法犯罪	80
情境四：未成年人正在遭受侵害	80
2. 心理咨询受哪些法律约束	80
3. 心理咨询还受到伦理守则约束	80
（1）信息保密	81
（2）披露最小化	81
（3）避免双重关系	81
三、危机干预的核心前提：生命安全第一	81
生命安全第一位	81
四、从系统视角理解心理危机	81
1. 个体因素只是其中一部分	81
2. 更大的社会与文化系统同样重要	81
（1）经济环境	81
（2）文化环境	82
（3）中国传统文化的影响	82
3. 家庭与成长环境的重要性	82
家庭和成长环境对人的影响极大	82
4. 成长环境塑造社交能力与人格	82
5. 每一代人所处的大时代不同，心理议题也不同	82
6. 人是“系统中的人”	83
7. 心理危机干预也必须是系统性的	83
五、心理危机的“树理论”	83
1. 根：家庭与依恋关系	83
2. 树干：信仰、价值观、社会支持	83
（1）信仰	83
（2）价值观	83
（3）社会支持	84
3. 枝叶与外部环境：社会环境也决定成长状态	84
4. 树理论与危机承受力	84
如果一个人拥有：	84
如果一个人缺乏：	84
六、危机干预的三个阶段	84
1. 第一阶段：危机评估（crisis assessment）	84
2. 第二阶段：行动干预（action intervention）	85
3. 第三阶段：心理干预与后续心理治疗	85
（1）心理干预	85

(2) 后续心理治疗 (psychotherapy)	85
七、什么是危机, 以及危机常见反应	85
1. 认知反应 (cognitive reactions)	85
认知变窄 (narrowed cognition)	85
2. 情感/情绪反应 (emotional reactions)	86
3. 行为反应 (behavioral reactions)	86
八、危机干预的基本原则	86
1. 保障安全	86
2. 聚焦问题	86
3. 激活资源 (resource activation)	86
九、后半节: 危机干预前的准备与工作状态	87
1. 干预前必须有充分准备	87
2. 危机干预必须依靠团队	87
心理危机干预不是一个人能完成的	87
3. 干预者要保持松弛而稳定的状态	87
4. 干预中的态度要求	87
十、人的基本需要与危机的关系	88
1. 关系的需要 (need for relationship)	88
2. 自尊的需要 (need for self-esteem)	88
3. 安全感的需要 (need for security)	88
4. 亲密关系的需要 (need for intimacy)	88
5. 成就感与自我认同 (achievement and self-identity)	89
6. 情绪与感受幸福的能力	89
十一、不同需要受挫后的心理表现	89
1. 关系受挫	89
2. 自尊受挫	89
3. 安全感不足	89
4. 亲密关系不足	89
5. 成就感受挫	89
6. 自我认同受挫	89
7. 针对不同受挫类型的干预方向	89
十二、危机干预的具体步骤	89
1. 明确问题和目标	90
2. 快速而准确地评估 (rapid and accurate assessment)	90
3. 给予希望与问题解决	90
十三、危机干预中的安全措施	90
十四、建立关系: 危机干预有效的前提	91
关系 (therapeutic relationship)	91
十五、学校心理健康资源与心理咨询的意义	91
1. 课程资源	91
2. 心理社团与活动资源	91
3. 心理咨询的作用: 像一根拐杖	91
4. 心理咨询不是“立竿见影”的药	91
十六、自杀识别: 课程最后的重要补充	91
1. 自杀的语言征兆 (verbal warning signs)	92
2. 自杀的行为征兆 (behavioral warning signs)	92
3. 自杀过程中的情绪变化	92
前期:	92
后期:	92
4. 社交媒体与失联信号	92
十七、关于自杀的几个常见误解	92
1. 误解一: 有过自杀尝试的人, 之后风险会降低	92
2. 误解二: 和有自杀风险的人谈论自杀, 会诱发他去做	93
3. 误解三: 说“我不想活了”的人只是说说而已	93
十八、普通同学遇到有自杀倾向的人时该怎么做	93
1. 不要承诺保密	93
2. 立刻调动身边资源	93
先救人, 先让他活下来	93
3. 后续可能的走向	94
十九、老师对“危机”的总体态度	94
1. 危机是危险	94
2. 危机也是机会	94
二十、课堂结尾与随堂任务	94
本节英文术语索引	94
第 6 讲: 学生心理危机三级预防	96
一、课前说明与本节导入	96

二、案例引入：胡鑫宇事件的基本经过	96
三、家属介入、学校搜索与网络舆情发酵	96
四、案件结果：警方结论与录音证据	96
五、案例的心理学分析：胡鑫宇身上的危险特征	97
1. 性格特征：典型内向、孤僻、压抑	97
2. 对新环境的不适应	97
3. 睡眠与节律问题	97
4. 对学习成就的高期待与现实落差	97
六、老师对其“重度抑郁”判断的六条依据	97
(1) 严重睡眠障碍	97
(2) 学习功能受损	97
(3) 明显社交障碍	97
(4) 负性认知与自我评价下降	98
(5) 心身症状	98
(6) 持续情绪低落与轻生念头	98
七、谁本可以帮助他：家长、老师、同学与本人	98
八、家长层面的责任与失误	98
九、老师层面的责任与失误	98
十、同学层面的责任与失误	99
十一、本人层面的因素：退避型应对与缺乏主动求助	99
十二、由案例引出的生命意义教育	99
十三、卡伦·霍尼与“被爱的渴求”	100
十四、第二节：学生心理危机的三级预防	100
1. 一级预防（primary prevention）	100
2. 二级预防（secondary prevention）	100
3. 三级预防（tertiary prevention）	100
十五、老师提到的社会层面防自杀共识	100
1. 减少获取自杀手段的机会	100
2. 积极治疗精神障碍患者	100
3. 对自杀未遂者进行随访	100
4. 负责任的媒体报道	101
5. 培训基层卫生保健人员	101
十六、学生心理危机重点人群：七类高风险对象	101
1. 有家族史者（family history）	101
2. 有既往史者（past history / previous psychiatric history）	101
3. 单亲家庭学生（single-parent family）	101
4. 经济困难学生（financial hardship）	101
5. 存在人格缺陷者（personality vulnerabilities）	101
6. 遭遇应激事件者（stressful life events）	101
7. 已出现精神症状者	101
十七、心理危机的高发时间、年级与场所	101
1. 高发时间	101
2. 高发年级	101
3. 高发场所	102
十八、学校层面的一级预防：课程与活动	102
1. 心理健康教育课程的重要性	102
2. 参与心理健康教育活动	102
十九、学校特色活动之一：内观认知疗法训练班	102
1. 基本情况	102
2. 理论来源与形式	102
3. 组织方式	102
4. 效果统计	102
5. 老师举的适用问题例子	102
6. 老师总结其核心作用	103
二十、学校特色活动之二：中国森田疗法研修班	103
1. 创立者与地位	103
2. 理论来源	103
3. 适应范围	103
4. 老师对森田疗法原理的解释	103
5. 老师的学术活动与案例	103
6. 学校近期活动安排	103
7. 老师概括的森田疗法最终目标	103
二十一、三级预防的落脚点：接纳困难，及时求助	104
本节英文术语索引	104
第7讲：心理问题的客观存在、主观加工与应对思路	106
一、课前说明：下次考试与本节课程安排	106

二、导入：心理问题“看不见、摸不着”，但客观存在	106
1. 每个人都在散发不同的“心理状态”	106
2. 心理问题的第一个核心认识	106
3. 每个人都不一样	106
三、为什么这个时代心理问题更多	107
1. 外部信息不断侵入精神世界	107
四、案例一：不会做题就崩溃——内在批评声音的发现	107
1. 表面表现	107
2. 崩溃后的反应链	107
3. 心理咨询中的分析路径	107
4. 找到“内在批评者”	107
5. 这个声音具体在说什么	107
6. 双椅技术（empty-chair / two-chair technique）	108
五、精神世界像“心田”：长什么，决定你活成什么样	108
1. 心田里如果是石头和杂草，就长不出好庄稼	108
2. 抱怨型人格的理解	108
3. “我必须……”带来的僵化	108
4. 一个颠覆性的观点：痛苦未必主要来自外在环境	108
六、案例二：强迫症的迁移——困扰会不断换对象	109
1. 小时候：担心脚卷入自行车后轮	109
2. 上高中：开始被物理“受力分析”困住	109
3. 上大学：又被马克思主义原理困住	109
4. 工作后：困扰再次换壳	109
七、情绪幸福感相对稳定：心理状态具有持续性	109
八、老师对心理问题的总结：主观性、必然性、主导性	110
（一）主观性（subjectivity）	110
1. 女生常见表现	110
2. 男生常见表现	110
3. 另一位社交焦虑来访者：上班像“上坟”	110
（二）必然性	110
老师借此说明“必然性”的意思：	111
另一个例子：收入问题并不是焦虑真正原因	111
（三）主导性	111
1. 诱发事件	111
2. 问题扩展	111
3. 症状迁移	111
4. 徒步时继续检查	111
九、痛苦与“增容”：老师对苦难的理解	111
1. 不要只盯着“我有多痛苦”	112
2. 历史上能成事的人，往往都经历过磨难	112
3. 心理健康与“包容力”	112
4. 换个角度看“难相处的人”	112
十、续讲：对心理问题的宏观理解与对自媒体的提醒	112
1. 少看自媒体	112
十一、对“原生家庭决定论”的批评	113
1. 网络上常见说法：所有心理问题都来自原生家庭	113
2. 老师的理由	113
3. 为什么这样说仍然不够	113
十二、案例三：同样一件事，不同的人加工完全不同	113
1. 关门声被体验成“暴力”	113
2. 同样的母亲行为，不同叙述方向完全相反	113
例子 A：负向加工	113
例子 B：正向加工	113
十三、再次总结：心理问题与原生家庭“有关”，但不能锁死成因果	113
十四、人与世界如何互动，世界就如何回应你	114
1. 你的方式，会塑造你得到的回应	114
2. 如果你总觉得自己忙、累，你就不容易快乐	114
十五、案例四：小熊一家——“心想事成”的负向验证模式	114
1. 故事背景	114
2. 一家人去野餐	114
3. 关键事件：让小熊回家拿起子	114
4. 结局	114
5. 老师要说明的核心	114
十六、恋爱中的“验证”会制造痛苦闭环	115
1. 验证方式：发消息看是否秒回	115
2. 反复验证	115

3. 结果	115
4. 老师给出的建议	115
十七、为什么人天然更容易往负面加工：老师所谓的“魔”	115
十八、借《西游记》谈“磨炼”与精神内核	115
1. 老师强调“精神内核”	116
2. 家庭为什么会过不好	116
十九、修身齐家：少责备，多承担	116
1. “齐家”不是要求别人，而是先承担自己那部分责任	116
2. “仁义礼智信”不是僵化教条	116
3. “礼崩乐坏”的理解	116
二十、识人之术：远离持续抱怨外界的人	116
1. 苏东坡与佛印的故事	117
故事一：八风吹不动，一屁打过江	117
故事二：心里有什么，就看别人像什么	117
二十一、关于目标、努力与放松	117
1. 太执着于目标，反而容易痛苦	117
二十二、临下课前的两道题提示	117
1. 第一题	117
2. 第二题	117
二十三、人生建议：千里马常有，而伯乐不常有	117
1. 大家都是“千里马”	117
2. 人生中三个“好”很重要	118
3. 因材施教（teaching students in accordance with their aptitude）	118
4. 良心拷问：你真的喜欢自己学的专业吗？	118
5. 如何判断什么是你真正适合的事	118
本节英文术语索引	118

说明：本 PDF 由心理危机干预与预防/Notes/ 下 7 份 Markdown 笔记合并生成。目录页码由 XeLaTeX 编译得到，适合打印后按页码查找。

第 1 讲：心理危机导论

说明：以下笔记严格按老师讲课推进顺序整理，只整理到你这次发来的转写片段末尾。个别专有名词在人名转写中前后写法不一致时，按同一案例处理；涉及新闻、统计或个案处，以下均按**老师课堂表述**记录。

一、课程导入：这门课为什么重要

老师开场说明：今天开始讲一门新课——**心理危机干预与预防（psychological crisis intervention and prevention）**。

老师先用很口语化、很直接的方式指出：大学生的心理危机在极端情况下，常表现为两类后果：

1. **自杀（suicide）**：伤害自己、结束生命。
2. **伤人/杀人（homicide / violence toward others）**：把危机转向他人。

虽然这类事件总体上并不常见，但一旦发生，社会影响非常恶劣。因此，这门课不只是完成一门课程，更重要的是：

- 学会**识别（identification）**
- 学会**调整（adjustment）**
- 学会**助人自助（help others and help oneself）**

核心目的还是“健康平安”。

二、任课教师背景与校内外求助资源

老师介绍：任课教师来自学校**精神卫生与心理学系**，其中一部分老师同时也是执业医师，在大学医院从事**心理诊疗（psychological counseling / clinical psychological service）**工作。

【求助信息】

老师特别提到毛老师的门诊时间，提醒大家记住，以备自己或亲友将来需要时使用：

- **每周四上午**：医科大学总医院 **临床心理科（clinical psychology）**
- **每周六下午**：一大二院

老师提示：如果以后自己或亲友出现如下情况，可以尽早就诊、加号咨询：

- 睡不着觉
- 焦虑、失眠（anxiety, insomnia）
- 抑郁（depression）

三、老师展示个人科普文章：大学生抑郁症要重在早识别、早预防

老师提到左侧一本杂志，是中国心理卫生协会主办的科普杂志《心理与健康》。其中某年（老师说为**2023年5月**）邀请其撰写封面文章，主题是：

大学生抑郁症早期识别与预防（early identification and prevention of depression in college students）

老师强调的背景判断

疫情以后，大学生**抑郁症（depression）**已经成为大学生**休学、退学**的重要原因，甚至是主要原因之一。

老师回顾说：

- 过去学生休学退学原因中，较常见的是传染病、外伤等；
- 现在心理问题尤其突出；
- 抑郁症一旦发展起来，**不容易恢复**，因此更应强调**预防（prevention）**。

【学习建议】

凡是“不好治”的病，都要强调预防。对抑郁症而言，关键不是等严重了再处理，而是：

- 稍有苗头就要注意；
- 稍有症状就应及时发现；
- 及时调整，避免进一步加重。

四、政策背景：健康第一，尤其要重视“心理脆弱”

老师提到，国家层面已明确强调要重视**心理健康（mental health）**与**精神卫生（mental hygiene / mental health service）**。

并提到教育系统当前强调“**健康第一**”，不是“**学习第一**”。

老师提到的“三小”问题

当前学生群体，尤其是中小學生中，突出有“三小”：

1. **小眼镜**：近视问题突出；
2. **小胖墩儿**：肥胖问题增加；
3. **小脆心儿**：心理脆弱、抗挫能力差。

老师的意思是：过去很多家长、学生把“学习”放在第一位，甚至牺牲健康去换成绩；现在越来越清楚，**健康没了，学习最后也守不住**。所以必须把“健康第一”摆到前面。

五、从“危机（crisis）”讲起：危机的广义概念

老师先从一般性的“危机”讲起。危机可理解为：某种事件使社会偏离正常运行轨道，对公共安全、稳定造成重大影响的一种**非均衡状态（state of disequilibrium）**。

危机按来源大致可分三类

1. **天灾**：如地震、洪水、山火等；
2. **人祸**：如战争；
3. **自然因素与人为因素叠加**：人为因素加重自然危机。

老师这里举了若干国际和自然灾害新闻作为引入，目的不是让大家背新闻本身，而是让大家理解：**危机状态意味着安全感被打破，日常秩序被中断，人会进入高度不确定与高压状态。**

老师的引申

大家能坐在教室里正常上课、没有寒冷和生命危险，其实已经是一种相对稳定、安全的状态。而在地球另一些地方，人可能随时面对死亡威胁，这就是危机情境。

六、【考务】本课考试形式与平时成绩

老师在这里插入了课程考核说明。

【考务】

- 期末为开卷考试（open-book examination）
- 但不能互相抄袭
- 考试时可以看自己准备的材料、自己的笔记
- 不能看别人的试卷

【考务】平时成绩

- 大约有**30~40分**平时成绩
- 具体形式视任课老师习惯而定，可能包括：
 - 随堂测验
 - 签到
 - 课堂表现等

【备考建议】

总原则是：

- 平时成绩为辅；
- 期末开卷考试为主；
- 重点是**自己做好笔记**；
- 考前要做基本复习，不要完全空着去考。

老师说通常什么情况会不及格

1. 经常点名不在；
2. 平时成绩丢得太多；
3. 期末卷面基本空白。

【考点提示】

老师特别提醒：凡是**考试可能涉及的内容**，毛老师通常会在课件或板书中画**红三角**。同学们把这些重点拍下来、记下来即可；实在懒的话，课件下课可由学习委员拷走。

七、【考点】心理危机 (psychological crisis) 的定义

老师明确说：今天第一个重点，就是心理危机的概念。

【考点】心理危机定义

心理危机 (psychological crisis)：指个体面临突然的或重大的生活困境，无法用既有方式解决，从而出现**心理失衡 (psychological disequilibrium)** 的状态。

【考点】心理危机成立的三条标准

老师说，判断心理危机，要同时抓住三条：

1. 有一个“事儿”——即存在生活事件 (life event)

必须先有一个外部或内部触发的重大事件、困境或打击。

2. 出现严重反应

包括多方面的严重身心反应：

- **情绪反应 (emotional response)**
- **认知反应 (cognitive response)**
- **身体反应 (physical / somatic response)**
- **行为反应 (behavioral response)**

3. 不能有效自我缓解

也就是：

- 不能靠现有经验、办法、知识把问题解决掉；
- “老办法解决不了新问题”；
- 已超出个体固有能力边界。

老师总结式表述

心理危机本质上就是：**有重大事件 + 有严重反应 + 自己缓不过来。**

八、大学生常见心理危机的极端形式：以自杀为主

老师再次回到大学生群体，指出大学生常见心理危机的极端形式之一就是**自杀 (suicide)**。

老师对本校与兄弟院校的比较性评论

老师说，近几年本校没有自杀成功案例，是比较幸运的。但其他高校并不都如此，尤其一些学校学生多、竞争强、卷得厉害，相关问题更突出。

老师的解释

并不是医学生“天生更健康”，而是：

- 学校健康教育抓得相对较好；
- 医学生多学了一些健康知识；
- 更有利于自我识别和自我保护。

九、【举例 / 临床关联】天津师范大学女大学生因乙肝“大三阳”被孤立后自杀案例

老师说，单讲抽象概念大家容易困，所以开始举案例。他说明：许多真实案例涉及工作机密，不能讲，因此选了一个网上公开案例。

案例基本情况

- 学校：天津师范大学
- 对象：一名大一女生
- 转写中名字前后有异写，这里按同一案例整理

事件经过

该女生入学后，在一次偶然检查中发现自己是**乙肝大三阳**。老师指出：她本人可能当时并无明显症状，但被检查出有病毒、且具有传染性后，同学开始疏远、孤立她。

【医学相关】

老师这里提到：

- 乙肝大三阳与**乙型肝炎（hepatitis B）**相关；
- 传播主要与**体液传播（body fluid transmission）**有关；
- 并不是像呼吸道传染病那样通过日常呼吸轻易传播。

老师的意思是：真正传播风险未必像大家想象得那样大，但因为同学不懂医学知识，所以恐惧、疏远仍然发生了。

被孤立后的变化

- 吃饭、上课、生活中被刻意拉开距离；
- 逐渐被同学群体排斥；
- 心理压力越来越大。

学校与辅导员的处理

辅导员曾劝其先休学治病。但该女生认为：

1. 自己没症状；
2. 大三阳不是短时间就能治好的；
3. 家里贫困，休学意味着拖延毕业、增加经济负担；
4. 患病不能成为剥夺其受教育权的理由。

学校后续安排

在宿舍紧张情况下，学校为“照顾”她，给了一个**单间宿舍**。

老师指出：表面上看，像是“优待”；但实际上，这种安排也可能进一步加重其**隔离感、孤独感**。

结局

她于3月入住单间，一个月后在宿舍内**烧炭自杀**。

遗书内容与心理状态

老师转述其遗书意思：

- 对未来彻底绝望；
- 感到人生漫长而看不到尽头；
- 想从当前“腐坏”的生活中尽快逃离；
- 也知道“不应效仿”，但自己已救不了自己。

老师对其心理逻辑的概括

她感到：

- 因疾病被孤立；
- 眼前看不到希望；
- 未来读书、就业、社会交往似乎都会继续遭受歧视；
- 于是选择“尽快逃离”。

【易错 / 识别点】

老师补充说：

- 她不是没有努力过，也尝试向朋友解释疾病并不可怕；
- 但新生群体对传染病不了解，恐惧和流言仍在扩散；
- 自杀当天其母亲已有不祥预感，曾联系辅导员；
- 但因误判她人在图书馆，错过了抢救关键时机。

引发的争议

事件后来引起很大争议，焦点包括：

- 患有传染病的学生应如何安排；
- 学校在保障其权利与保护其他学生之间如何平衡；
- 辅导员、学校是否已尽责；
- 同学的排斥与恐惧在其中起了多大作用。

老师的评价

老师认为：

- 这是一个由疾病引发、再被孤立放大的心理危机；
- 其中有老师和学校的责任；
- 但客观说，学校也并非完全不作为，而是提供了某种支持；
- **真正困难的是：心理危机的预防并不容易。**

【助人者视角】

老师引用该校心理中心主任在事件后的朋友圈感慨，大意是：自杀像地震，很多征兆往往只有事后追溯时才显得具有预测意义。每个生命的逝去，都会让助人者感到悲伤、内疚、悔恨，以及无奈、无助。

十、【考点】危机干预（crisis intervention）的概念、目的与意义

讲完案例后，老师转入理论。

【考点】危机干预的提出

老师说，**危机干预（crisis intervention）**概念最早由美国心理学家**凯普兰（Caplan）**于**1954年**提出，并进行系统研究。

【考点】危机干预的定义

危机干预属于广义的**心理治疗（psychotherapy）**范畴。其核心是运用心理治疗的手段，帮助处于危机状态的当事人：

- 处理迫在眉睫的问题；
- 恢复心理平衡；
- 安全度过危机；
- 重新适应生活。

【考点】危机干预的两个主要目的**1. 避免自伤或伤人**

- 防止自杀、自残
- 防止伤及他人

2. 恢复心理平衡与心理动力

- 使人重新“运转起来”
- 不再陷于崩溃状态

【考点】危机干预成功的意义

如果危机干预成功，个体可以：

1. 更好地把握自己的现状；
2. 重新认识危机事件；
3. 学会未来再遇到类似危机时更好的应对策略。

十一、世界范围内的自杀情况：老师用于引入的流行病学比较

老师接着从全球范围谈自杀问题，作为宏观背景。

老师课堂中提到的比较

- 自杀率较高的国家：韩国、匈牙利、日本等
- 自杀率较低的国家：冰岛、西班牙、希腊等
- 自杀是一个**概率事件**，没有哪个国家是绝对零发生

老师进一步讲的趋势

从纵向看，西方国家自杀率在历史上有：

- 两次低谷：两次世界大战时期
- 两次高峰：经济大萧条相关时期

老师借此强调一个朴素判断：**经济压力、贫困、失业与心理危机密切相关。**

老师的口语化总结

“钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。”他用这个意思强调：收入和现实生活条件，确实能缓解大量现实压力和心理问题。

十二、中国大学生自杀率：老师强调“总体不高，但趋势需警惕”

老师提到：

- 美国总体自杀率居中；
- 美国大学生自杀率大致低于其全人群平均；
- 中国总体自杀率也有自己的水平；
- 中国大学生自杀率相对更低。

老师的解释

中国高校自杀率相对较低，老师将其归因为：

- 学校对心理健康工作的高度重视；
- 有专门心理老师；
- 有辅导员体系；
- 对学生有更强的组织性和日常管理。

【复习 / 观点】

老师顺带比较了中国大学与国外大学的学生管理差异：

- 国外大学多是个人化、分散式管理；
- 没有中国式的班级、班委、辅导员等强集体支持系统；
- 中国高校的班集体、宿舍集体，在心理危机预防上反而是一种保障。

老师要表达的是：一个人出问题时，若身处集体，更容易被发现、被支持。

十三、天津市学生自杀的趋势：疫情后出现低龄化

老师提到，天津市每年具体自杀人数属于保密信息，但他给出了几个趋势判断：

趋势

1. 总体逐年增长
2. 疫情后结构变化明显
 - 疫情前：非正常死亡学生中，研究生和本科生占比更高
 - 疫情后：中小學生占比明显上升
3. 低龄化
 - 老师提到最小案例已到小学四年级

老师结论

当前形势不容乐观。

十四、北京某调查总结的大学生自杀规律

老师说，最新数据未必掌握，但举了一个较早的北京研究作参考。该研究收集了 **200 例** 大学生自杀相关个案，从中总结了一些规律。

1) 自杀地点分布

老师提到，地点以以下场所为主：

- 宿舍最多
- 其次是教学楼
- 还有科研楼、家属楼等

解释

说明自杀行为常发生在学生**最熟悉、最常活动**的场所。

2) 跳楼楼层分布

老师说，自杀跳楼楼层较集中在：

- 5 楼
 - 6 楼
 - 7 楼
 - 8 楼
- 其中 **7 楼最多**。

老师用建筑标准与致死概率作口语化解释：

- 太低可能摔不死；
- 七层楼又常是学校建筑的典型高度。

3) 最主要原因：不适应 (maladjustment)

老师强调，“不适应”是非常核心的原因，而且是**各种不适应叠加**：

- 学业不适应
- 人际不适应
- 气候不适应
- 饮食不适应
- 环境不适应
- 专业不适应

【举例】

- 从小学到初中、高中到大学，角色变化导致失落；
- 原来在原学校很优秀，换环境后优势消失；
- 第一本志愿没录上，被调剂到不喜欢的专业；
- 想退学重考，又没勇气，长期纠结。

4) 抑郁 (depression)

老师说，很多学生已经处于抑郁状态，但：

- 自己不知道；
- 或者不承认；
- 硬撑、逞强，最后越来越严重。

5) 危机发生时间

老师强调一个容易与直觉不符的点：

- 大家往往以为夜里更容易出事；
- 但调查提示：**白天比晚上多**
- 尤其是**上午**更容易发生。

6) 自杀方式

最显著高于其他方式的是：**跳楼**

老师给的解释是：

- 不需要额外工具；
- 致死率高；
- 操作相对“简单”。

7) 年龄与年级分布

老师指出：

- 中小学阶段：高年级更突出
- 大学阶段：**随着年级升高，危机数量逐年增加**
- **毕业年级最高发**

老师对毕业年级高发的解释

毕业班问题交织最复杂：

- 能否毕业
- 找工作困难
- 考研压力
- 答辩、盲审压力
- 恋爱与分手问题
- 多重现实压力集中爆发

8) 性别差异

老师说，北京这项研究提示：

- 男女比例基本接近 **1:1**
- 自杀方式差异也不大
- 只是时间选择上略有不同：
 - 男生夜间稍多
 - 女生白天稍多

十五、费立鹏关于中国人自杀原因的总结

老师接着提到加拿大心理学家**费立鹏（Michael R. Phillips）**在中国开展研究，并总结出中国人自杀的八大相关因素。

八大原因

1. 抑郁程度重
2. 有自杀未遂史
3. 应激强度大（**high stress intensity**）
4. 生命质量低
5. 慢性心理压力大
6. 死亡前两天内有人际冲突
7. 有血缘关系的人存在自杀行为
8. 熟人有自杀行为

【考点理解】

老师特别强调第6条很有“中国特色”：中国人的自杀往往与**亲密关系中的激烈冲突**有关，很多是“吵起来了”“怄起来了”之后的**激情性自杀**。

十六、中国人与国外自杀模式的差异

老师根据费立鹏研究，讲了几组对比。

1) 性别差异不同

老师的课堂表述是：

- **中国**：女性自杀多于男性
- **国外**：男性自杀多于女性

老师解释认为：中国总体数据受**农村女性自杀率较高**影响很大。

2) 老师对农村女性高自杀率的解释

他认为与以下因素有关：

- 女性社会地位相对较低；
- 封建观念残余；
- 家庭矛盾无法有效解决；
- 遇到不公和挫折时缺乏支持与出路。

【举例】

老师以**彩礼**为例，从其角度批评这是一种对女性的物化和歧视。并指出在某些家庭情境中，女性在婚后面临：

- 婆媳矛盾
- 夫妻冲突
- 娘家、婆家双重压力
- 离也离不了，过也过不下去
最后可能走向极端。

3) 年龄差异不同

老师说：

- 国外自杀年龄偏大；
- 中国青少年、自青年龄段更突出；
- 中国 15~24 岁是高风险年龄段之一；
- 平均自杀年龄偏年轻。

老师的解释

年轻人之所以更容易自杀，是因为：

- 年龄阶段本身更敏感；
- 长期读书，理想主义色彩强；
- 接触现实后，发现现实与想象不一致；
- 本该“调整主观去适应客观”，但有些年轻人做不到，容易走向极端。

十七、精神障碍与躯体疾病也是自杀的重要原因

老师接着补充，自杀与**精神障碍**（mental disorders）、**躯体疾病**（physical illness / somatic disease）密切相关。

1) 抑郁症（depression）

老师强调，抑郁症不是简单的“想不开”，而是一种深度的**精神耗竭**（mental exhaustion）状态。

典型体验包括：

- 持续痛苦
- 大脑像被掏空
- 转不动
- 没动力（loss of motivation）
- 没兴趣（anhedonia）
- 认知越来越消极
- 觉得活着只有痛苦，没有出头之日

对正常人来说，“死”是可怕的；但对重度抑郁患者来说，死亡可能被体验为“唯一解脱”。

2) 精神分裂症（schizophrenia）

老师说，**精神分裂症**（schizophrenia）患者也可能自杀，因为会受：

- **幻觉**（hallucination）
- **妄想**（delusion）

支配。老师还引用电影《追捕》里的情节，帮助理解“被诱导走向死亡”的体验。

3) 严重躯体疾病

老师提到，一些严重躯体疾病也会增加自杀风险，例如：

- 癌症（cancer）
- 艾滋病（AIDS / HIV infection）等

其相关原因包括：

- 疾病痛苦大；
- 治疗困难；
- 经济负担重；
- 心态崩溃；
- 常伴发抑郁。

十八、与危机事件相关的常见诱因

老师归纳说，与心理危机相关联的事件，常有以下几类特点。

1) 持续压力 (chronic stress)

例如：

- 家庭经济困难
- 学业困难
- 单亲家庭压力

【举例】单亲家庭

老师特别讲到单亲家庭，尤其单身母亲抚养孩子时，容易出现：

- 家长把全部希望投射到孩子身上；
- 对孩子要求过高；
- 孩子一开始努力讨好；
- 之后逐渐达不到期待；
- 最终矛盾升级。

甚至现实中会出现极端的弑亲新闻。

2) 财产、健康、名誉、尊严丧失

老师举到：

- 网络诈骗 (telecom / online fraud)
- 健康受损
- 名誉受损
- 尊严被羞辱

【举例】网络诈骗

老师提醒：网络诈骗的两个高发受害群体是：

- 老年人
- 大学生

大学生容易成为目标，是因为：

- 社会经验不足；
- 容易轻信；
- 容易被“兼职”“退款”“小便宜”诱骗。

【学习建议】

一定要提高警惕。有的人损失一点钱无所谓，但对另一些人来说，经济打击可能直接把人推入生存危机。

3) 感情受挫

如：

- 失恋
- 情感挫败
- 情感冲突

4) 环境改变 (environmental change)

如：

- 入学
- 转学
- 搬家
- 留学

这些都可能成为危机高发节点。

5) 持续的人际关系紧张

包括：

- 夫妻关系
- 家庭矛盾
- 同学关系
- 宿舍关系

老师的总结

中国人的自杀，常有明显的人际关系因素参与。这是与一些西方社会相对不同的地方。

十九、人格 (personality) 与心理危机的关系

老师进一步说，心理危机不只和外部事件有关，也和人格基础有关。

人格的概念

人格 (personality) 是一个心理特征的总和，像一个相对稳定的“脸谱”。

人格是双刃剑：

- 有优势的一面；
- 也有脆弱、容易出问题的一面。

容易出现心理危机者常见人格特点

1. 注意力明显缺乏
2. 过分内省（excessive introspection）
3. 情绪稳定性差
4. 解决问题能力差

另一项研究归纳的心理特点

容易出现危机的人，往往还有以下特点：

- 不能客观评价自己，也不能客观评价外界；
- 容易夸大外部危险；
- 对自己评价要么过于自大，要么过度自卑；
- 存在多种**非理性认知（irrational cognition）**：
 - 过度概括（overgeneralization）
 - 非此即彼（all-or-none thinking）
 - 以偏概全
 - 负性推导
 - 过度绝对化、肯定化
- 人际关系不良；
- 人格不成熟；
- 适应能力差；
- 不会求助；
- 不会应对困难局面。

二十、【举例】两个典型案例：一个杀人，一个自杀

老师说，前面理论有点抽象，接下来用两个典型案例串起来理解：

1. **马加爵**：杀人案例
2. **杨元元**：自杀案例

二十一、【案例一】马加爵：从优秀贫困生到宿舍杀人案

基本情况

- 籍贯：广西
- 学校：云南大学
- 事件：大四最后一个学期前后，杀害 4 名同学，后逃到三亚，被捕并判死刑

老师先强调的一点

马加爵并不是人们想象中的“青面獠牙”式坏人，从外表看反而非常朴实。

入学前后的优秀经历

- 从小学到高中成绩都非常优秀；
- 初中参加全国数学竞赛获二等奖；
- 高中考入云南大学，成为村镇骄傲；
- 大一入学后积极报名当班委；
- 热心班级事务，参加活动，承担任务，是积极分子。

二十二、【案例二】杨元元：从优秀学生干部到研究生宿舍自杀

基本情况

- 2009 级，上海海事大学法学系硕士生
- 研一入学后不久，于宿舍卫生间自杀

自杀方式

老师提到她是用两条毛巾固定后，坐地将自己勒死。老师用这个细节强调：这说明其求死意志已经非常坚决，因为过程中理论上存在中断机会，但她没有停止。

入学前的优秀经历

- 从小学习刻苦，成绩优秀；
- 从高中到大学一直是学生干部；

- 大学期间加入中国共产党；
 - 还能帮助同学调解矛盾，是标准的“优秀学生干部”形象。
-

二十三、两案共同基础之一：贫困 (poverty)

老师说，自己的一家之言是：这两个人有一个共同基础——**穷**。

马加爵的贫困表现

- 吃饭时常只买素菜；
- 有时只靠馒头和免费汤；
- 家里寄钱晚了就借钱吃饭；
- 借不到钱就躺着不动，甚至以睡觉来减少消耗；
- 又穷又好面子，不愿申请贫困资助。

杨元元的贫困表现

- 六岁丧父；
 - 母亲无固定工作，还要照顾弟弟；
 - 她一边上学，一边承担家庭责任；
 - 本科毕业时因欠学校贷款，毕业证一度被扣；
 - 因没钱甚至卖掉手机，与同学联系中断。
-

二十四、两案共同基础之二：学业受挫

马加爵的学业受挫

- 大一时非常努力，想拿奖学金；
- 但英语基础差，成为短板；
- 尽管专业课不错，却因英语拖后腿，多次与奖学金失之交臂；
- 原本想通过奖学金同时解决经济和尊严问题，结果两头落空；
- 之后开始躺平、松散。

杨元元的学业受挫

- 本科业务成绩第一；
 - 但综合测评中其他加分因素影响，最终没能保研；
 - 她对这种结果感到委屈、不公平；
 - 毕业后又花两年准备考研，但一直没考上；
 - 最终是在反复受挫中继续往前顶。
-

二十五、两案共同基础之三：感情受挫

马加爵

- 喜欢班里一名女同学；
- 在男同学鼓动下尝试表白；
- 打电话被拒；
- 写情书又被当面撕毁；
- 受到强烈打击和羞辱感。

杨元元

- 大学时有男朋友；
 - 因毕业、考研、压力等因素，关系受挫，最终分手。
-

二十六、两案爆发前的关键人际冲突

马加爵的爆发点

老师讲到两个关键事件：

1. 被最看重的朋友排除在外

他认为某位老乡兼贫困生同学是自己最好的朋友。但这位同学过生日时请了几乎所有人，唯独没请马加爵。这件事对他伤害极大。

2. 打牌时被指“作弊”，并被拿“人品差”羞辱

另一名同学打牌输了后，不仅说他作弊，还拿前面“生日不请他”这件事嘲讽他，说这是因为他“人品不行”。

老师认为，这一下“捅到了肺管子”，彻底触发了他的杀意。

之后的发展

- 他买了锤子准备报复；
- 原本计划针对两人；
- 后来另外两名同学“误入现场”，被牵连杀害；
- 还有一名曾在他困难时请过他吃饭的同学，被他放过。

【举例中的老师提示】

老师借此强调一句很口语的话：“勿以善小而不为。”有时候一个很小的善意，真的可能在关键时刻改变走向。

二十七、杨元元案中的关键人际冲突：贫困、母亲、宿舍与羞辱感

事件背景

杨元元上大学时曾把母亲带到学校附近生活，学校后勤还曾给母亲安排临时保洁工作。到了上海读研后，她也想继续这样做，让母亲和自己一起生活。

冲突升级

但研究生宿舍管理严格，学校不同意。母亲曾趁宿管不注意进入宿舍，与她同住。其他同学反映后，学院领导与宿管介入，要求母亲离开。

她的主观体验

- 她希望学校能同情她、体谅她；
- 但学校采取公事公办态度；
- 宿管老师多次驱离其母亲；
- 她感到母亲脸面受辱，也感到自己无能；
- 与宿管、学校之间的矛盾不断加深。

二十八、老师对两案的心理学分析（一）：欲求的绝对性

老师认为，两人一步步走上危机道路，首先与**欲求的绝对性**有关。

欲求的绝对性是什么意思

就是对自己、对他人、对事情抱有过于理想化、绝对化的要求。典型想法包括：

- 人都应该讲理；
- 事情都应该公平；
- 别人应该按我的期待回应我。

在马加爵身上的表现

- 我打牌厉害，别人就应该承认并尊重我；
- 我把你当朋友，你就必须也把我当朋友；
- 如果你没有这样做，就是严重背叛与侮辱。

在杨元元身上的表现

- 坚信“知识改变命运”；
- 认为只要努力学习，就应该得到改变命运的结果；
- 明明资源不够、条件不够，却执着于一定要考上广的研究生；
- 认为学校理应同情、帮助自己和母亲；
- 一旦现实没有按理想运行，就难以接受。

老师结论

表面看像是“别人逼她/逼他”，但深层常常也是**自己用理想化要求把自己逼到了墙角**。

二十九、老师对两案的心理学分析（二）：感知的歪曲性

第二个特点是**感知的歪曲性**，即因为贫困、自卑、敏感等基础，在解释外界行为时更容易感到：

- 屈辱
- 被歧视
- 被贬低
- 被看不起

马加爵身上的例子

老师举了若干例子：

- 请老乡吃饭时，饭馆老板更重视老乡，不把他当主客；
- 去商场买鞋，被店员默认只能买最便宜的；
- 去银行等候，被保安当成蹭空调的人往外赶；
- 当班委时因常去找团支书汇报工作，被男同学嘲笑想“癞蛤蟆吃天鹅肉”。

老师的意思是：这些事在一般人看来未必都是“致命打击”，但对一个本就高敏感、高自尊的人来说，会不断叠加成屈辱记忆。

三十、老师对两案的心理学分析（三）：思维的消极性

老师说，他们在受挫后，思维会迅速走向消极和极端。

表现

- 对自己、对他人、对事情都越来越悲观；
- 一旦一件事没达到预期，就容易全面否定；
- 从“很理想主义”一下变成“彻底否定现实”。

例子

- 马加爵奖学金拿不到后，开始躺平、逃课、上网；
 - 杨元元长期坚持读书考研，发现并未改变命运后，开始彻底怀疑自己全部努力的意义。
-

三十一、老师对两案的心理学分析（四）：应对的非理性

第四个问题是**应对非理性（irrational coping）**。即在面对压力和挫折时，不会调整路线，不会换方法，不会求助，而是用极端方式解决问题。

马加爵

被捕后自述大意是：

- 贫困和艰辛我能忍；
 - 别人的歧视、蔑视我也能忍；
 - 但最好的朋友践踏我的人格尊严，我不能忍；
 - 既然如此，就“玉石俱焚”，要给那些歧视贫穷、歧视苦人的人一个教训。
- 老师强调：其核心是**自尊受伤**后，以极端暴力方式“讨回尊严”。

杨元元

老师转述其遗书中的一句核心态度：“**人可以被毁灭，但不可以被打败。**”

老师借此指出：这类人往往把“宁折不弯”当成尊严，但如果不会调整和转弯，就可能把自己逼向绝路。

三十二、老师总结两案共有的人格与心理特点

老师把两人的共性概括为三个词：

1. 高敏感

- 对人、对事太在乎；
- 容易把小事放大；
- 对羞辱、轻视体验格外强烈。

2. 高自尊

- 内里可能自卑；
- 但越自卑，越想通过成绩、表现、荣誉来证明自己；
- 追求高自尊的过程，反而不断受伤。

3. 执着、倔强

- 一条路走不通，也不愿转弯；
- 资源不够，却设定很高目标；
- 遇到困难不知调整；
- 坚持到最后，把自己“绷断”。

老师的概括性结论

本质上是：

- **资源不足**
- 却定了过于理想的目标
- 遇到挫折不懂调整
- 最后把自己逼崩了

老师认为，这种教训是很惨痛的。

三十三、【举例 / 本校案例】过度要强、宿舍关系差、学习方法僵化，最终精神失常边缘

老师接着举了一个本校女同学的危险案例，用来提醒大家重视现实中的前兆。

基本情况

- 女同学
- 本硕连读

- 高中时是学霸
- 家长在原学校还是主任级人物
- 从前荣誉很多，长期处于“优秀学生”位置

入学后的目标

她进入医大后，给自己偷偷立了一个很高的标杆：

- 要拿奖学金
- 要当班干部
- 要再创辉煌
- 要继续追求卓越

老师说：这种“想变好”本身没错，但她有明显短板。

短板一：看不起别人，宿舍关系恶化

- 宿舍里谁都看不顺眼；
- 对室友多有意见；
- 一个宿舍里同时得罪多数人，结果就是自己被孤立。

短板二：学习方法僵化

- 想继续用高中模式对付大学；
- 面对大学大量内容和不同老师讲课方式，不会调整方法；
- 开始靠“蛮力”学：
 - 少吃饭
 - 少睡觉
 - 拼命学

结果

形成恶性循环：

- 越睡不好
- 越吃不好
- 上课效率越差
- 情绪越不稳定

最终有一天夜里失控：

- 别人都睡了，她睡不着；
- 半夜喊口号给自己打气；
- 严重影响舍友；
- 大家意识到“不对劲”，赶紧上报老师。

后续处理

学校通知家长，希望家长陪同处理。但家长一开始并不理解，反而先追究是不是别人欺负了她，试图找“幕后黑手”。

老师的判断是：

- 宿舍小摩擦肯定有；
- 但更核心的问题还是她自身：
 - 过度要强
 - 性格短板
 - 不会处理人际关系
 - 学习遇挫时不会调整方法

【临床关联 / 风险提示】

老师明确提醒：如果这种情况继续发展，确实存在进一步升级的风险。虽然是女同学，不一定发展成持刀等暴力，但医学院环境里有：

- 实验室
- 有毒有害物质

如果人在极端状态下失控，后果可能非常严重。

【举例】复旦投毒案

老师顺带提到复旦大学研究生宿舍矛盾引发投毒致死的案例，用以说明：

- 宿舍矛盾若严重激化；
- 又碰上具备实验条件和危险物质；
- 后果可能是致命的。

三十四、本段结尾处老师的未完提醒

到你发来的这段转写末尾，老师的话停在：

“所以大家呢一定呢，哎，这个这个有矛盾啊，咱呢……”

也就是说，这一段最后显然还会继续讲：**遇到矛盾时应如何处理、如何避免激化、如何及时求助**。但由于当前转写片段在这里中断，笔记也先整理到这里。

本节英文术语索引

- 心理危机 —— **psychological crisis**
- 危机 —— **crisis**
- 危机干预 —— **crisis intervention**
- 心理危机干预与预防 —— **psychological crisis intervention and prevention**
- 心理治疗 —— **psychotherapy**
- 心理平衡 —— **psychological balance**
- 心理失衡 —— **psychological disequilibrium**
- 生活事件 —— **life event**
- 情绪反应 —— **emotional response**
- 认知反应 —— **cognitive response**
- 身体反应 / 躯体反应 —— **physical response / somatic response**
- 行为反应 —— **behavioral response**
- 心理健康 —— **mental health**
- 精神卫生 —— **mental hygiene / mental health service**
- 抑郁 / 抑郁症 —— **depression**
- 焦虑 —— **anxiety**
- 失眠 —— **insomnia**
- 自杀 —— **suicide**
- 伤人 / 杀人 —— **homicide / violence toward others**
- 临床心理科 —— **clinical psychology**
- 乙型肝炎 —— **hepatitis B**
- 乙肝大三阳 —— **hepatitis B “big three positive” / HBeAg-positive status**
- 体液传播 —— **body fluid transmission**
- 精神障碍 —— **mental disorder**
- 精神分裂症 —— **schizophrenia**
- 幻觉 —— **hallucination**
- 妄想 —— **delusion**
- 人格 —— **personality**
- 非理性认知 —— **irrational cognition**
- 过度概括 —— **overgeneralization**
- 非此即彼思维 —— **all-or-none thinking**
- 慢性压力 —— **chronic stress**
- 应激 —— **stress / stress response**
- 适应不良 / 不适应 —— **maladjustment**
- 自杀未遂史 —— **history of suicide attempt**
- 生命质量 —— **quality of life**
- 躯体疾病 —— **physical illness / somatic disease**
- 求助 —— **help-seeking**

排版备注：原始笔记此处之后检测到非课程内容残留，合订本已自动略去。

第2讲：心理危机的常见原因

主题：心理危机的常见原因（第2次课）

一、开场与本次课程主题

老师先说明了本节课内容：这是《心理危机干预与预防》第二次课，本次主要讨论心理危机（psychological crisis）的常见原因。

二、【复习】危机（crisis）的基本概念

老师先回顾了上节课可能已经讲过的“危机”概念，并强调危机有两层含义：

1. 危机可以指“突发事件”本身

即一个出乎人们意料而发生的事件，例如：

- 自然灾害（natural disasters）
- 技术性灾害（technological disasters）
- 恐怖袭击（terrorist attacks）
- 战争（war）等

老师举例说，人们会说“伊朗危机”，这里的“危机”就是指这个事件本身。

2. 危机也可以指“人所处的紧急失衡状态”

当个体遭遇重大问题或变化，感到：

- 难以解决
 - 难以把握
 - 原有平衡被打破
 - 正常生活受干扰
 - 内心紧张不断积蓄
- 进一步就可能出现：

- 无所适从
 - 思维和行为紊乱
 - 进入一种失衡状态（state of disequilibrium）
- 这就是心理学上讲的危机状态（crisis state）。

3. 危机的核心含义

老师强调：

- 危机意味着平衡与稳定被破坏。
- 危机之所以叫“危机”，就是因为它打破了人长期依赖的平衡，引起混乱和不安。

4. 危机并不单由事件本身决定，而取决于个体的应对能力

老师特别强调一个判断标准：

危机的出现，是因为个体意识到某个事件或情境超过了自己的应付能力（coping capacity），而不只是因为事件本身发生了。

也就是说：

- 同一件事，对有些人构成危机；
 - 对另一些人，可能并不构成危机。
-

三、【举例】以考试说明“危机感”的形成

老师用医学生熟悉的考试场景做例子。

1. 过去的生活中，很多“特别棘手的事”都可能让人感到危机

例如：

- 英语四级、六级
- 高考
- 未来的执业医师考试（physician licensing examination）

2. 【课堂提醒】执业医师考试对很多医学生来说会构成危机

老师提到：

- 临床、儿科、麻醉、影像等专业学生以后都要面对执业医师考试。
- 这对很多人来说是一道“坎”。

老师还提到学校执业医师通过率“不是那么喜人”，并借此说明为什么考试会构成危机：

- 今年没过，明年还得继续考；

- 明年又会加入新的考生；
 - “盘子更大”，竞争更强；
 - 在通过率限制下，个体主观上会感到希望更渺茫。
- 老师借此说明：危机感本质上来来自于“我觉得自己应付不过来”。

四、心理危机的表现与潜伏性

老师接着说明，心理危机（psychological crisis）可以表现为很多层面：

- 心理状态严重失调
- 心理矛盾激烈冲突、难以解决
- 精神濒临崩溃，甚至精神失常
- 出现心理障碍（psychological disorder）

1. 当事人不一定总能立刻察觉自己处于心理危机中

老师指出：

- 有的人会及时察觉；
- 也有人是在“不知不觉中”进入危机状态。

2. 表面看似“正常”的行为模式下，也可能潜伏危机

老师举例：

- 社会上很多人每天照常上班、下班；
- 表面看起来是正常的上班族；
- 但“压垮骆驼的是最后一根稻草”。

也就是说，一个人即便长期维持某种习惯化、看似稳定的行为模式，也可能潜藏着严重的心理危机。

五、【重点】成瘾行为背后的心理危机

老师由“隐癖”引入成瘾问题，强调：

- 严重不良隐癖（如物质滥用）背后，往往潜伏心理危机；
- 当隐癖被去除时，心理危机就会暴露出来。

1. 【课堂提问】最常见的精神活性物质滥用是什么

老师提问后给出答案：

- 最常见、也最容易引发法律问题的精神活性物质（psychoactive substance）滥用是酒精（alcohol）。
并提醒医学生：
- 这是临床上必须知道的常识；
- 酒驾、醉驾就涉及酒精滥用带来的现实法律问题。

2. 匿名戒酒者协会

老师提到一个组织：

- 匿名戒酒者协会（Alcoholics Anonymous, AA）
并说明其特点：
- 它不完全等同于正规心理治疗组织；
- 更接近一种互助组织（mutual-help group）；
- 会员采取匿名制；
- 定期组织活动，帮助成员戒酒。

3. 【核心观点】成瘾往往只是表面现象

老师强调这一点非常重要：

- 酒精成瘾也好
 - 手机成瘾也好
- 这些都往往只是表面现象，其背后真正掩盖的可能是：
- 无法解决的内心冲突
 - 情绪问题
 - 家庭矛盾
 - 其他长期心理危机来源

4. 只“戒行为”往往治标不治本

老师举精神科病房中的例子：

- 有些反复住院戒酒的患者，在住院期间当然喝不到酒；
 - 但他们会在医院里商量出院后去哪儿“大喝一顿”。
- 老师借此说明：
- 单纯把成瘾行为压下去，并不等于问题解决；

- 关键是识别成瘾行为背后的心理危机。

六、【复习】心理危机原因的多元性：生物—心理—社会医学模式

老师提醒大家，医学第一课通常就会讲到：

- **生物—心理—社会医学模式（biopsychosocial medical model）**
意思是：人的问题通常不是单一来源，而是由多个层面共同构成。
老师把危机原因概括为三个大方面：
 1. 生物/生理层面（biological/physiological factors）
 2. 心理层面（psychological factors）
 3. 社会文化层面（social and cultural factors）

七、生物生理层面：季节、光照与情绪变化

老师首先从生物生理学层面讲危机原因，并以“冬天和夏天的差异”为例。

1. 冬天常见的身心变化

老师提问并总结：

冬天相较夏天，人往往更容易出现：

- 更想吃碳水化合物（carbohydrates）
- 早晨起不来床
- 总犯困
- 情绪低落
- 整体更“打蔫儿”

2. 原因：北半球冬季光照减少

老师解释：

- 天津位于北半球；
- 北半球进入冬天后，光照逐渐减少；
- 到冬至时，光照最少；
- 夏至则昼最长、夜最短，冬至相反。

3. 光照减少对脑内神经递质的影响

老师从神经生化角度解释：

- 在光照减少时，大脑中的**松果体（pineal gland）**活动相关变化会使
 - **5-羟色胺（5-hydroxytryptamine, 5-HT; serotonin, 血清素）**减少
 - **褪黑素（melatonin）**增加

由此带来：

- 褪黑素高 → 更容易困、总想睡觉
- 5-HT 低 → 情绪活跃性下降，容易低落

老师借此说明：

- 冬天人总想睡觉、总显得没夏天那么活跃，是有生物化学机制的。

4. 【考点味很浓】季节性情感障碍 SAD

老师引出：

- **季节性情感障碍（Seasonal Affective Disorder, SAD）**

高纬度地区更常见，表现包括：

- 冬季情绪低落
- 烦躁
- 嗜睡
- 每天睡十几个小时，甚至更久
- 喜欢吃碳水化合物
- 体重增加

老师说明：

- 有些患者如果不做干预，也可能在春天自然缓解；
- 这说明它与**自然节律（natural rhythm）**关系密切。

5. 高纬度地区患病率更高

老师举美国不同地区为例说明：

- 佛罗里达州：约 1%
- 华盛顿特区：约 4%
- 阿拉斯加：约 10%

老师借此得出结论：

- 随着**纬度升高**，SAD 发生率上升；
- 说明人的情绪状态会受到自然环境显著影响。

八、【机制讲解】为什么情绪不好时容易想吃碳水

老师顺势解释“情绪不好就想吃东西”的生化基础。

1. 情绪差时，很多人偏爱碳水食物

老师提醒大家观察生活现象：

- 情绪不好的人，常会“化郁闷为食量”；
- 尤其偏爱富含糖和淀粉的食物。

2. 生化机制

老师按生理生化逻辑解释：

- 吃碳水后 → **胰岛素（insulin）** 分泌增高；
- 胰岛素会促进除**色氨酸（tryptophan）**以外的其他竞争性氨基酸从血液进入组织；
- 血液中色氨酸相对比例上升；
- 氨基酸通过**血脑屏障（blood-brain barrier, BBB）**需要载体转运；
- 色氨酸比例升高后，更容易抢占载体进入脑内；
- 色氨酸是 **5-羟色胺（5-HT）** 的原料。

3. 结论

从这个意义上说：

- 情绪低落时吃碳水，在一定程度上确实可能改善抑郁情绪；
- 这种做法是有生化机制支持的。
但老师也强调副作用：
 - 容易肥胖
 - 体重增加
 - 增加代谢负担
 - 长期大量甜食对胰岛不利

九、社会文化层面：人不仅是生物学的人，也是社会文化的人

老师接着强调：

- 人不能只作为一个生物学个体来理解；
- 人还处在**社会文化（social and cultural）**之中；
- 文化与历史不断在人身上留下“烙印”。

1. 【举例】男女衬衫开襟方向不同

老师举了一个很日常但很多人没注意过的例子：

- 男装衬衫通常是**左压右**
- 女装衬衫通常是**右压左**

老师解释其历史文化原因：

男装为什么左压右

- 欧洲最早有纽扣衣服时，穿得起带纽扣衣服的多是贵族；
- 贵族男性常佩剑；
- 剑一般挂在左侧；
- 如果衣服不是左压右，而是右压左，拔剑时剑的护手容易勾住衣服；
- 为避免决斗时影响动作，男装形成左压右。

女装为什么相反

- 女性一般不佩剑；
- 贵族女性的穿衣常由仆人协助；
- 反向开襟更方便侍者操作。

老师借此说明：**看似理所当然的日常习惯，很多都是文化长期塑造的结果。**

2. 【举例】东京与大阪自动扶梯左右站位不同

老师又举日本的例子：

- 东京：站左边，把右边让出来
- 大阪：站右边，把左边让出来

解释如下：

东京（江户）为什么靠左

- 东京历史上是政治中心；
- 武士佩刀，刀通常挂左侧；
- 若两人都靠右走，刀容易相碰，引发冲突；
- 因此形成靠左通行的习惯。

大阪为什么靠右

- 大阪是商业中心，商人多；
 - 商人常把贵重物品放在右侧，便于右手看护；
 - 因此习惯靠右站立，以减少被顺手牵羊的风险。
- 老师借此再次强调：文化历史会长期塑造人的行为模式。

十、心理层面：人格、选择与“后悔”

接着老师谈到心理层面，尤其是人格与应对方式（personality and coping style）。

1. 关于“后悔过去的决定”

老师问大家：

- 在过去 20 多年的生活中，有没有做过让今天的自己后悔的决定？
- 甚至开玩笑举例：“比如学医。”

2. 老师的观点：很多后悔是“事后诸葛亮视角”

老师提出一个思考框架：

- 假如用时光机器把你送回当年；
 - 但你对未来发生的事一无所知；
 - 在当时那个情境里，你大概率还是会做出和当年相似的选择。
- 由此老师认为：
- 我们今天常常是站在“事后”评价当初的自己；
 - 但人在当时的信息条件下，通常已经做出了当时自己能做出的最好选择。

3. 结论

老师的结论是：

- 没有必要过度沉溺于对过去决定的后悔；
 - 因为再来一遍，在同样信息条件下，大概率还是会那么选。
- 并由此引出一句话：
- “人格决定命运。”

十一、心理危机原因的呈现方式：两种典型模型

老师用两个图像比喻危机来源的两种呈现方式。

1. 左图：山上巨石突然滚落

象征：

- 突如其来
 - 毫无预兆
 - 灾难性强
 - 破坏性大
 - 难以提前预测和应对
- 即：突发性灾难事件。

2. 右图：鞋里不断进沙子

象征：

- 生活中看似平凡琐碎的小事
- 不断摩擦、积累
- 持续消耗个体心理资源

老师强调：

- 大多数人一生中未必会遭遇巨石般的灾难；
- 但更常见的是“鞋里的沙子”——也就是日常生活中不断积累的小困扰、小冲突、小压力。

3. 【举例】中年人的日常“沙子”

老师举例：

- 孩子作业写错得离谱（如“800-700=900”）
- 父母被保健品推销套路

- 伴侣追问“你是不是不爱我了”
老师借此说明：
 - 这些看似日常的小事，同样可能成为心理危机的重要来源。
-

十二、心理危机原因总分类：外部原因与内部原因

老师把心理危机原因概括为两大类：

1. 外部原因

- 生态环境（ecological environment）
- 社会环境（social environment）

2. 内部原因

- 健康状况（health status）
 - 人格及应对方式（personality and coping style）
- 接下来老师按这个框架展开。
-

十三、生态环境导致的心理危机

1. 主要类型

老师列举生态环境层面的常见危机来源：

- 自然灾害：地震、洪水、海啸、雪灾
- 传染性疾病：SARS、COVID-19、甲流等
- 技术性灾害：飞机坠毁、核设施泄漏、建筑物倒塌等

2. 共同特点

老师强调这些事件的特点：

- 多数不可预见
 - 趋向不可预测
 - 趋向不可控制
-

十四、【临床关联】流行病高峰与儿科医疗系统压力

老师结合医疗工作经验举例：

- 秋冬季通常是儿科最忙的时候；
- 新冠放开后某一年甲流大暴发，医院压力巨大。

1. 【举例】老师路过天津老儿童医院的观察

老师说自己曾亲眼看到：

- 老儿童医院门口排队车辆一直排到友谊路并拐弯；
- 现场有人举牌引导停车；
- 刚过去的 2025 年，天津市儿童医院曾创下一天接诊 **13000 人次** 的纪录。

2. 【临床观察】儿科急诊系统承压

老师还提到：

- 自己所在私立医院儿科急诊，晚上看诊也要等 2~3 小时；
- 这说明整个医疗体系正在承受严重挤兑。

3. 【临床关联】天津与深圳儿童医院分诊体系对比

老师对比两种模式：

天津常见情况

- 分诊处多为护士；
- 先分科，再等待就诊；
- 见到医生后才开检查；
- 检查后又得排队，效率低。

深圳儿童医院模式

- 分诊处由儿科医生先做初步判断；
- 提前开必要的检查化验；
- 家长先带孩子做检查；
- 回来时差不多轮到正式就诊；
- 医生能更快根据检查结果做出初步诊断并开药。

老师认为这种模式效率更高，也更有利于患儿尽早接受处理。

十五、【举例】重大生态灾难与创伤反应

1. 唐山大地震（1976）

老师提到：

- 唐山地震将整座城市夷为平地；
- 铁轨都被拧成麻花，显示其破坏力极大。

老师转述老一辈人的描述：

- 地震后几个月，幸存者之间见面会互相问“你们家几个”，意思是“家里死了几个人”。
- 老师指出，这种**情感麻木、淡漠**是典型的：
- **创伤后应激障碍（post-traumatic stress disorder, PTSD）**表现之一。

2. 切尔诺贝利核泄漏（Chernobyl disaster）

老师讲到：

- 1986年4月26日，乌克兰切尔诺贝利4号反应堆爆炸；
- 这是人类历史上最严重的核泄漏事故之一。

老师重点强调了灾后处置中的极端危险：

- 直升机向反应堆上空投掷砂/硼酸和沙土；
- 辐射极强，机器与人都难以承受；
- 机器人失效后，只能招募人员身穿厚重铅防护服上屋顶人工铲除放射性碎片；
- 每个人暴露时间必须极短。

老师借此说明：

- 技术性灾害不仅是“灾难”，还可能迅速转化为严重的群体性心理创伤。

3. 【举例】SARS（2003）

老师回忆2003年非典：

- 当时防疫条件远不如今天；
- 甚至没有今天熟悉的**N95口罩**概念；
- 防疫常靠多层纱布口罩。

老师还提到：

- 当年许多医学院研究生往返医院和学校做课题；
- 疫情影响下，很多研究和毕业安排被打乱；
- 学校甚至延后了毕业答辩时间。

4. 汶川地震（2008）

老师简单提到：

- 汶川地震十分惨烈；
- 大家虽可能年纪太小印象不深，但这是重要的国家级灾难事件。

5. 东日本大地震（2011）与福岛核泄漏

老师提到：

- 2011年3月11日东日本大地震是人类观测史上极严重的地震之一；
- 岩手、宫城、福岛受灾尤重；
- 此后又引发**福岛核电站泄漏**。

十六、【举例】福岛核泄漏后的“抢盐”现象：群体性荒谬反应

老师借福岛事件讲了一个经典社会心理例子。

1. 当年出现“抢盐潮”

老师回忆：

- 2011年春天，很多地方的盐被抢购一空；
- 有人一口气囤很多盐，但其实自己也说不清理由。

2. 谣言的演变过程

老师描述谣言是如何“进化”的：

- 最初：担心海水受污染，所以海盐不安全；
- 后来进一步演变为：**吃加碘盐可以防辐射**。

3. 【课堂提醒】从医学角度看待“吃盐防辐射”

老师提醒医学生：

- 理论上碘在某些特定情况下与甲状腺放射性核素防护有关；

- 但“抛开剂量谈疗效”是没有意义的。

老师举出极端对比：

- 若真靠食盐摄入碘达到防护剂量，所需摄入量极大；
- 而盐本身过量摄入早就先带来严重风险。

4. 【重点】心理危机可用荒谬形式爆发

老师借此说明：

- 在灾难和群体焦虑背景下，
 - 人会以非常荒谬、失去判断力的方式做出反应；
 - 这也是危机状态的一种社会性表现。
-

十七、【举例】812 天津港爆炸事故

老师接着讲到较近的本地重大事故：

- 天津港危险化学品违规储存并起火；
- 早期进入现场的消防员不清楚仓库存放物质；
- 喷水降温诱发剧烈爆炸；
- 造成多名年轻消防员牺牲。

老师还提到：

- 爆炸点附近小区玻璃几乎全部震碎；
- 大量伤员被送往塘沽及市区各医院；
- 那晚医疗系统也面临突发性巨大压力。

老师借此再次说明：

- 技术性灾难往往来得突然、破坏巨大，也会迅速造成严重的群体心理冲击。
-

十八、【举例】新冠疫情及其后果

老师提到：

- 2020 年 1 月新冠疫情爆发；
- 在中国持续约三年；
- 到 2022 年底才全面放开。

1. 放开后的群体性影响

老师的课堂描述包括：

- “每个人是自己健康第一责任人”；
- 整个过程某种意义上变成了全民免疫过程；
- 放开初期带来显著的群体性冲击与社会系统压力。

2. 老师的社会观察

老师用天津本地的丧葬行业举例，强调：

- 放开后的冬天，死亡相关事务陡增；
 - 说明疫情冲击不只是医学层面的，也深刻影响社会心理与生活秩序。
-

十九、社会环境导致的心理危机

老师接下来进入社会环境（social environment）层面，列出常见来源：

- 恐怖袭击
 - 人质事件
 - 暴乱
 - 经济危机
 - 社会变革
 - 学业压力
 - 工作压力
 - 家庭矛盾
-

二十、【课堂举例】恐怖袭击、人质事件与战争

1. 9·11 事件

老师提到 9·11 事件，并说课堂上有人还会从纪录片角度提出若干“疑点”与质疑。

这里的重点不是历史定论，而是老师借此强调：

- **重大恐怖袭击事件会构成强烈社会性危机来源：**
- 其后续政治、战争、社会舆论与群体心理反应，会进一步放大危机。

注：老师课堂中提到的部分纪录片内容属于其转述的“质疑性观点/材料”，可作为课堂举例理解，不宜直接当作已证实结论。

2. 别斯兰人质事件 (2004)

老师提到：

- 俄罗斯北奥塞梯别斯兰第一小学开学典礼上发生人质事件；
- 武装分子劫持师生；
- 最终造成大量人质死亡，绝大多数为儿童。

老师借此说明：

- 人质事件、恐怖袭击不仅造成直接伤亡，也会引起深重的社会创伤。

3. 【时事举例】伊朗局势与霍尔木兹海峡

老师以近期中东局势为例，强调：

- 国际局势并不一定“离我们很远”；
- 霍尔木兹海峡是全球重要能源运输通道；
- 国际冲突会影响石油、天然气供应；
- 最终通过油价、运输成本、物价等方式影响普通人的日常生活。

老师借此说明：

- 国际政治冲突也可能成为普通人的心理压力源和危机来源。

二十一、【举例】恶性无差别伤害事件与社会安全感受损

老师列举了一系列恶性无差别伤害事件，说明社会环境如何成为心理危机的重要来源。

1. 福建南平实验小学案 (2010)

老师提到：

- 该案针对的是校门口聚集的小学生；
- 之后全国出现多起模仿式校园无差别伤害事件。

2. 老师的个人记忆

老师回忆：

- 当年很多小学、幼儿园上下学时段，民警持枪站岗；
- 社会整体安全感明显受到冲击。

3. 近年的无差别袭击事件

老师又举例：

- 沈阳铁西区多起无差别伤害案件
- 山东德州驾车冲撞放学小学生
- 珠海体育中心驾车冲撞事件

老师借此说明：

- 这类事件会显著破坏公众的安全感；
- 社会环境中的不确定性、暴力性也会构成心理危机来源。

二十二、学业与就业压力：多数人更常见的危机来源

老师强调：

- 大多数人未必遇到战争、恐袭、灾难；
- 但更常遇到的是**就业、工作、经济与家庭压力**。

1. 【课堂提醒】医学并不意味着“天然好就业”

老师直言：

- 学医不等于一定轻松找到工作；
- 医院更希望招来就能独当一面的人；
- 不希望从零开始慢慢培养。

2. 【学习建议】医学生在校期间就要完成从“学生”到“医生”的转换

老师强调：

- 大家在校期间就必须尽快完成这一角色转变；
- 否则到临床后会很被动。

二十三、【临床关联】医生职业的工作压力

老师用医院工作流程举例，说明工作压力如何成为危机来源。

1. 医生的工作节奏很辛苦

老师举总医院为例：

- 早晨 7:30 交班；
- 住院医生应更早到达科室；
- 到岗后要先看病人、看夜间病情变化、看临时医嘱、看检查结果。

2. 【课堂提醒】汇报病例不是照着病历念

老师强调：

- 汇报病例要把主诉、现病史等内容真正掌握；
- 重要化验值也要记住；
- 不能只是拿着病历照本宣科。

3. 医生常常下班不由自己

老师举例：

- 快下班时急诊再收一个病人；
- 就意味着还要完成查体、化验、输液、病历等一整套工作。

4. 老师的概括

老师用一句很直白的话形容高强度职业：

- “人肉换猪肉。”
- 意思是：
- 高收入背后往往是用身体、健康、时间、精力去换的。
-

二十四、【举例】996、007 与高压劳动

老师把医生工作进一步放到更广泛的劳动环境里讨论。

1. 996

- 早 9 点到晚 9 点
- 一周工作 6 天

2. 007

- 0 点到 0 点
- 一周 7 天无缝衔接

3. 老师观点

老师借此说明：

- 无论是互联网大厂还是其他高压行业，
 - 高收入背后都可能意味着严重的身体透支与心理消耗。
-

二十五、【举例】富士康事件与 EAP

老师又举富士康跳楼事件，说明制度化高压环境如何导致心理危机。

1. EAP

老师提到企业后来引入：

- 员工帮助计划（Employee Assistance Program, EAP）

2. 老师指出的问题

老师认为，富士康暴露出的并不只是个体心理问题，而是制度性、环境性问题，例如：

- 车间“静音模式”
- 吃饭时间极短
- 工作与生活高度机械化
- 宿舍工友因作息完全错开，彼此甚至连名字都说不全

3. 结论

老师借此强调：

- 心理危机并不总是个体“脆弱”；
 - 很多时候是环境本身在持续制造危机。
-

二十六、经济压力与现实生活困境

老师接下来谈经济压力。

1. 收入与生活压力

老师提到天津市职工平均工资数据，并借此说明：

- 很多岗位想月薪过万并不容易；
- 往往要付出极大的体力、时长或劳动强度。

老师列举：

- 快递员
- 外卖员
- 装卸工
- 网约车司机
- 电子厂工人等

意在说明：

- 经济压力是非常现实、非常普遍的危机来源。

2. 房地产问题

老师提到：

- 房企爆雷、楼盘烂尾
- 房价下跌
- 买房后跌破买价
- 贷款压力巨大

老师强调：

- 对很多家庭来说，这会成为持续性的心理危机。

3. 【举例】真实“蜗居”

老师还提到：

- 日本胶囊酒店
- 日本网吧常住人群

用来说明：

- 经济压力会直接转化为居住困境、尊严受损和长期压抑。

二十七、【举例】股市暴跌与金融压力

老师讲到股市暴跌引发的心理崩溃案例。

1. 杠杆风险

老师提醒：

- 不要轻易加杠杆；
- 杠杆放大收益，也同样放大亏损；
- 一旦触发强制平仓（forced liquidation），可能“什么都没了”。

2. 【举例】2015 年股灾

老师回忆自己亲眼见到与股灾相关的极端后果，借此说明：

- 金融风险也会迅速演变成心理危机、甚至极端事件。

二十八、婚恋压力与人际失败

老师提到，当代年轻人与中年人的另一个高频危机来源是：

- 找对象难
- 婚恋压力大

1. 【举例】天津中心公园“婚恋市场”

老师用“婚姻人口期货市场”作调侃式描述，指出：

- 许多相亲场景中，真正到场的反而不是当事人，而是父母；
- 从“盘面”上看，供求失衡明显。

2. 老师借出生率变化说明

老师提到近年出生率下降、节日婚车减少等现象，想说明：

- 婚恋困难已成为现实而广泛的社会问题。

3. 【举例】由单身羞辱引发的极端事件

老师提到：

- 有人因长期单身、被周围人轻视嘲讽而产生强烈报复心理，最终实施投毒。

老师借此强调：

- 不要轻视婚恋挫败、羞辱感带来的心理打击；
- 有时这会成为危机爆发的诱因。

二十九、家庭矛盾：最常见也最容易被忽视的危机来源

老师指出：

- 结不了婚的愁，结了婚也可能更愁；
- 家庭中的冲突非常常见，也常常最能消耗一个人。

1. 【举例】辅导作业导致家长崩溃

老师举例：

- 小女儿把“800-700”算成“900”；
- 父亲情绪崩溃，甚至哭求警察“把自己抓走”。

老师借此说明：

- 养育、教育、家庭责任会成为很多中年人崩溃的临界点。

2. 网络段子中的家庭情绪调节

老师引用流行说法，说明现实中很多家长会靠自我调侃撑住：

- “亲生的、亲生的……”
- “孩子爸是我选的……”

虽然带有玩笑成分，但本质上反映的还是：

- 家庭教育压力真实存在。

3. 【学习建议/教育理念】不要总替孩子改作业

老师转述一位小学数学老师的教育理念：

- 家长不要总把孩子写错的作业改正确；
- 保留原始错误，老师才能判断孩子的问题出在哪里；
- 过度代改作业，反而遮蔽了真正的教育信息。

这段虽然是家庭教育话题，但也体现出：

- 正确处理家庭中的压力与角色边界，是降低危机的重要方式。

三十、健康状况与心理危机

老师接着讲内部原因中的**健康状况（health status）**。

1. 相关类型

包括：

- 不治之症
- 慢性疾病（chronic disease）
- 躯体伤残
- 功能障碍
- 精神疾病（mental illness）
- 行为问题（behavioral problems）

2. 【举例】艾滋病防治宣传

老师提到学校厕所中的公益海报“防艾”，借此提醒：

- 艾滋病（AIDS / HIV infection）并不遥远；
- 健康问题本身就是心理危机的重要来源。

3. 【举例】隐瞒精神病史引发的极端案件

老师提到2021年天津一例轰动案件：

- 当事人有精神病史，却在恋爱、结婚过程中隐瞒；
- 甚至自行停药；
- 后来精神疾病复发，在冲突中对妻子实施严重暴力。

老师借此提醒：

- 精神疾病与停药、隐瞒病史、婚恋关系破裂等，都是高风险危机场景。

三十一、人格与应对方式：心理危机的内部基础

老师进入最后一个大部分：**人格（personality）与应对方式（coping style）**。

1. 人格的定义

老师说：

- 人格过去也叫“个性”；
- 指一个人较固定的行为模式，以及日常待人处事的习惯方式；
- 是全部心理特征的综合。

2. 人格的特征

老师总结人格具有以下特点：

(1) 社会性

- 不同社会中，人格表现受到不同社会规范影响。

(2) 独特性

- 每个人都是独特个体。

(3) 稳定性

- 人格短时间内不会发生巨大变化；
- 若一个人“昨天和今天判若两人”，就需要警惕问题。

(4) 可塑性

- 人格并非完全固定；
 - 会随着时间和经历逐渐变化。
-

三十二、人格的构成：气质、性格、能力

老师把人格构成分为三部分：

1. **气质 (temperament)**：先天部分，与遗传素质有关
2. **性格 (character)**：后天部分，与生活环境和教育有关
3. **能力 (ability)**：与个人实践活动、智力发展等相关

【比喻】

老师把人格比作一幅名人字画：

- 气质 = 画纸/画布（先天基础）
 - 性格 = 画了什么（后天塑造）
 - 能力 = 画得怎么样、值不值钱（实践水平）
-

三十三、【复习】四种基本气质类型

老师讲了经典的“四个人去看戏”故事，说明四种基本气质。

1. 胆汁质 (choleric temperament)

特点：

- 外向
- 情绪不稳定
情境反应：
 - 因为迟到被拦，直接和检票员吵起来、打起来。

2. 多血质 (sanguine temperament)

特点：

- 外向
- 情绪稳定
情境反应：
 - 趁别人混乱时自己溜进去。

3. 黏液质 (phlegmatic temperament)

特点：

- 内向
- 情绪稳定
情境反应：
 - 既然说中场休息能进，那就去咖啡厅等会儿。

4. 抑郁质 (melancholic temperament)

特点：

- 内向

- 情绪不稳定
情境反应：
 - 觉得“今天干啥都不顺”，索性不看了，撕票回家。
老师借此说明：
 - 这是人格中先天气质的差异。
-

三十四、性格与环境：后天塑造的重要性

老师强调：

- 后天性格受从小到大接触过的人的影响；
 - “近朱者赤，近墨者黑”；
 - “孟母三迁”本质上也是为了环境塑造。
老师指出：
 - 今天家长拼学区房，本质上也是在争取更好的环境塑造条件。
-

三十五、人格发展的特点

老师总结：

1. 随年龄呈抛物线式变化

- 人格逐渐发展成熟；
- 到一定阶段后可能走向退化；
- 极端情况下会涉及痴呆等问题。

2. 变化速度慢

- 短期效应一般不明显；
- 头天和今天相比，不会突然发生根本变化。

3. 受环境影响很大

老师强调：

- 经常接触社会、与不同人打交道，会促进人格成熟；
 - 若总是不接触社会、一意孤行，则人格更容易出现问题。
-

三十六、人格素质、人格问题与人格障碍

1. 人格素质本身无绝对好坏

老师认为：

- 各种人格素质都有积极面和消极面；
- 关键看比例是否均衡。

2. 【概念纠正】强迫特质 ≠ 强迫症

老师用手术举例说明：

- 手术结束前必须清点器械、敷料、针线、纱布等；
- 这种谨慎、反复核对是必要的，不是病态。
据此可理解为：
- 强迫性人格特质（obsessive-compulsive traits）不等于 强迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）

3. 健康人格的特点

老师概括为：

- 相对均衡
- 中庸
- 中正
- 平和

4. 人格问题/人格障碍（personality disorder）

老师指出：

- 当某种人格素质比例过高，导致整体人格结构失衡时，
 - 就可能发展为人格问题甚至人格障碍。
-

三十七、【举例】超前消费、网贷与人格问题

老师提到：

- 过去有“卡奴”，现在则更多表现为网贷滚债；
- 这种反复借贷、超前消费、缺乏还款能力评估的行为，
- 不只是经济问题，也体现出某种人格和应对方式的问题。

【课堂提醒】

老师顺带解释了为什么辅导员要排查网贷：

- 不只是怕欠钱；
 - 更是为了预防由债务、人际、羞耻感等引发的心理危机事件。
-

三十八、【举例】马加爵案：人格长期压抑与极端爆发

老师讲到马加爵案，说明人格问题与长期压抑情绪可能带来的严重后果。

1. 事件概括

- 马加爵为云南大学学生；
- 宿舍打牌时被室友嘲讽“作弊”“人格有问题”等；
- 长期压抑的负性情绪爆发；
- 最终实施极端暴力行为，案件轰动全国。

2. 老师借此强调

一些看似“小摩擦”的事情，若叠加在长期压抑、失衡的人格结构之上，可能造成极严重后果。

3. 【学习建议/做人提醒】

老师由此给出一个非常生活化的提醒：

- 将来毕业时，记得拥抱室友，感谢彼此“不杀之恩”。
虽然是玩笑口吻，但核心意思是：
- 宿舍关系、日常相处、互相体谅非常重要。

4. 【举例】“一饭之恩”救命

老师提到：

- 马加爵唯独放过了一位曾在他困难时给过他饭吃的同学；
- 说明一个小小善举，有时真的可能在关键时刻改变结局。

5. 【学习建议】

老师最后提醒：

- 看到身边同学有困难，能帮就帮；
 - “勿以善小而不为”。
-

三十九、课末补充：当前教育要求

录音最后，老师提到：

- 2026年2月25日，教育部举行“落实健康第一”工作部署会
 - 强调：
 - 让学生动起来
 - 心理强起来
- 说明心理健康已成为当前教育中的重要要求。

录音结尾情况

老师最后一句提到：

- “大概几十秒之后七点四十会在雨课堂发布我们今天的……”

录音到这里中断，后半句未录全。推测这里即将发布**当堂任务/签到/问卷/课堂活动**之类内容，但原录音未完整保留，不能强行补写。

本节英文术语索引

- 危机 — crisis
- 心理危机 — psychological crisis
- 危机状态 — crisis state / state of disequilibrium
- 应对能力 — coping capacity
- 精神活性物质 — psychoactive substance
- 物质滥用 — substance abuse

- 酒精 — alcohol
- 匿名戒酒者协会 — Alcoholics Anonymous (AA)
- 生物—心理—社会医学模式 — biopsychosocial medical model
- 松果体 — pineal gland
- 5-羟色胺 — 5-hydroxytryptamine (5-HT) / serotonin
- 褪黑素 — melatonin
- 季节性情感障碍 — Seasonal Affective Disorder (SAD)
- 碳水化合物 — carbohydrates
- 色氨酸 — tryptophan
- 胰岛素 — insulin
- 血脑屏障 — blood-brain barrier (BBB)
- 创伤后应激障碍 — post-traumatic stress disorder (PTSD)
- 非典型肺炎 — severe acute respiratory syndrome (SARS)
- 新型冠状病毒病 — COVID-19
- 员工帮助计划 — Employee Assistance Program (EAP)
- 人格 — personality
- 应对方式 — coping style
- 气质 — temperament
- 性格 — character
- 能力 — ability
- 人格障碍 — personality disorder
- 强迫症 — obsessive-compulsive disorder (OCD)
- 强迫特质 — obsessive-compulsive traits
- 胆汁质 — choleric temperament
- 多血质 — sanguine temperament
- 黏液质 — phlegmatic temperament
- 抑郁质 — melancholic temperament
- 慢性疾病 — chronic disease
- 精神疾病 — mental illness
- 行为问题 — behavioral problems
- 执业医师考试 — physician licensing examination

如果你愿意，我下一步可以把这份笔记继续整理成“更适合考前背诵的精简版”，或者再给你单独抽一版“本节可能会考的关键词和论述题框架”。

第3讲：心理危机的表现、应激与自杀

- 课程：心理危机干预与预防
- 老师：彭睿
- 日期：2026-03-17

一、课前说明与课堂安排

【课程说明】本课为选修课，老师说明不强求所有同学全程高度集中听讲；如果觉得内容有用可以认真听，如果想在下面自习也可以，但**不要影响课堂纪律**，不要交头接耳、影响他人。

【课堂安排】本节课中间会有：

- 签到
- 随堂测验

两项都通过**雨课堂**完成，且需在**当晚12点前**完成。

二、课程导入：什么是“危机（crisis）”与“心理危机（psychological crisis）”

老师先从“危机”的一般概念讲起。

1. 危机的两个含义

危机（crisis）有两个层面的含义：

1. **突发事件本身**如地震、水灾、空难、疾病、战争等重大应激事件。
2. **人所处的紧张状态**即个体在遭遇这些重大应激事件后，进入的一种紧张、失衡、难以把握的心理状态。

2. 心理危机的定义

心理危机（psychological crisis）是指：当个体遭遇重大问题或变化时，感到**难以解决、难以把握**，原有心理平衡被打破，从而出现**思维或行为的紊乱**。

也就是说，当个体意识到：

- 当前困难**超过了**自己的**应对能力**
- 原有平衡已经无法维持

就会出现一系列反应，包括：

- 生理反应
- 情绪反应
- 认知反应
- 行为反应

常见表现如：

- 焦虑（anxiety）
- 紧张
- 恐惧
- 压抑
- 痛苦等负性情绪

三、心理危机干预（crisis intervention）的基本含义

老师强调，心理危机干预是一种**心理治疗方式**，主要面向处于困境或遭受挫折的人，提供：

- 心理关怀
- 短程帮助（brief help）
- 倾听
- 提问
- 情绪释放
- 干预措施

其目标是让当事人能够：

- 正确认识自己的危机
- 释放被压抑的情绪
- 逐步纠正内心“错位”
- 恢复心理平衡

1. 判断是否达到“心理危机”的三个标准

是否构成心理危机，一般看三个方面：

1. **有重大影响性的事件**
 - 如水灾、火灾、地震

- 或重大生活应激事件
 - 2. 出现**严重不适感**
 - 包括生理反应
 - 也包括心理反应
 - 3. 原有**应对方式已无效**
 - 个人过去的应对方法已经无法解决问题
- 满足这些情况时，就需要进行心理危机干预。

2. 心理危机干预的分类

心理危机干预可分为：

- **预防性干预**（preventive intervention）
- **治疗性干预**（therapeutic intervention）
- **补救性干预**（remedial intervention）

【老师观点】目前多数心理危机干预仍停留在**补救**层面；真正系统的**预防性干预**还不够普遍，日常心理健康教育做得也相对较少。

四、按刺激来源划分的危机类型

根据危机刺激来源，可分为三类：

1. 发展性危机（developmental crisis）

又称：

- **内源性危机**
- **常规性危机**

指个体在成长发展过程中，由于阶段性急剧变化而产生的异常反应。

老师强调：人生由一连串发展阶段组成，当一个人从一个阶段进入另一个阶段时，如果原有的适应能力不足，就可能出现发展性危机。

【举例】

- 儿童与父母分离后的焦虑
- 青少年情感困惑
- 中年职场压力、下岗
- 父母衰老或死亡
- 配偶离去等

【要点】发展性危机具有以下特点：

- 常规发生
- 可预期
- 在生命各阶段都会存在

【学习理解】如果个体有足够时间和机会去适应，如：

- 获取相关信息
- 学习新技能
- 承担新角色

则发展性危机对个体的冲击会减少。

2. 境遇性危机（situational crisis）

又称：

- **外源性危机**
- **环境性危机**

指由外部突发、异常事件引起的危机。

【举例】

- 地震
- 战争
- 疾病
- 恐怖袭击等

3. 存在性危机（existential crisis）

与人生重大问题相关，涉及：

- 人生目的（purpose of life）
- 人生责任（responsibility）
- 独立性（independence）
- 自由（freedom）
- 承诺（commitment）等

它表现为围绕这些问题产生的**内部冲突与焦虑**。

【举例】

- 一个人到40岁还一事无成，可能产生强烈空虚感和存在性危机

【补充】存在性危机既可能基于现实问题，也可能基于后悔、空虚感等主观体验。

五、按发生过程划分危机；危机后的四个阶段

1. 危机按进程可分为

- 急性危机（acute crisis）
- 慢性危机（chronic crisis）
- 混合性危机（mixed crisis）

主要依据危机发生的快慢进行区分。

2. 危机发生后的四个阶段

老师将危机后的过程分为四期：

（1）冲击期（impact phase）

危机刚发生不久，个体表现为：

- 震惊
- 惊慌失措

（2）防御期（defensive phase）

个体开始试图恢复心理平衡，努力控制焦虑，恢复受损认知功能，但不知道如何做，因此常出现心理防御机制：

- 否认（denial）
- 合理化（rationalization）

（3）解决期（resolution phase）

个体开始：

- 采取积极办法
- 寻求资源
- 减轻焦虑
- 恢复社会功能

（4）成长期（growth phase）

危机过后，部分人会：

- 变得更成熟
- 学会处理危机的技巧

【老师提醒】并不是每个人都会成长。有的人危机之后会成长，有的人反而会出现不健康的心理和行为。

六、本节课聚焦的三个重点问题

老师说明：并不是所有受灾/受创人群都会发展为明确的精神障碍。在整个“受灾人群”中，只有一部分进入亚健康状态；在亚健康状态的人群中，也只有一部分进一步出现心理危机或精神障碍。

这些问题之间还会互相重叠，而不是彼此独立。

【复习/引入】老师提到常见相关问题包括：

- 急性应激障碍（Acute Stress Disorder, ASD）
- 创伤后应激障碍（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）
- 抑郁（depression）
- 焦虑（anxiety）
- 自杀（suicide）
- 酒依赖/物质滥用（alcohol dependence / substance abuse）

【本节重点】今天主要讲三个内容：

1. 创伤后应激障碍 PTSD
2. 急性应激障碍 ASD
3. 自杀（suicide）

【考点理解】老师特别指出：

- 自杀并不是精神病诊断系统中的单独疾病诊断
- 它会出现许多精神障碍中
- 但由于社会意义重大，所以单独拿出来讲

七、精神科两套常见诊断系统

老师提到精神科常见有两套诊断标准：

1. **ICD 诊断系统**国际疾病分类（International Classification of Diseases, ICD）最新为 **ICD-11**
2. **DSM 诊断系统**美国精神障碍诊断与统计手册（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM）最新为 **DSM-5**

【复习】在 DSM-5 中：

- 急性应激障碍（ASD）
 - 创伤后应激障碍（PTSD）
- 都属于**创伤及应激相关障碍**（Trauma- and Stressor-Related Disorders）这一大类。

八、急性应激障碍（Acute Stress Disorder, ASD）

1. 定义

急性应激障碍又称：

- **急性心因反应**
指个体在突然遭遇强烈应激事件后，**数分钟到数小时内**出现的急性应激反应，且：
 - 持续 **3 天以上**
 - 不超过 **1 个月**

【考点】“3 天以上、不超过 1 个月”是诊断 ASD 的关键病程标准。

如果超过 1 个月，就要考虑是否转为 PTSD。

2. 常见应激事件

包括：

- 重大交通事故
- 亲人死亡
- 歹徒袭击
- 强奸
- 虐待
- 自然灾害
- 战争
- 恐怖袭击
- SARS/非典等重大公共卫生事件
- 实际接触到死亡或死亡威胁

3. 临床表现

老师强调，精神科疾病主要通过**临床表现**进行识别和诊断。

（1）意识范围狭窄、意识清晰度下降

可出现：

- 定向困难（disorientation）
- 注意力不集中
- 对外界刺激理解困难
- 言语凌乱破碎

【解释】

- **意识范围狭窄**：只对狭窄范围内的刺激有反应，超出范围可能没有反应
- **意识清晰度下降**：可表现为嗜睡、意识浑浊、昏睡，甚至昏迷
- **定向障碍**：分不清时间、地点、人物，严重时甚至不知道自己是谁

【举例】刚接触创伤事件时，人常处于“整个人都懵了”的状态。

（2）闯入性再体验

- 反复出现创伤性回忆
- 在睡梦中反复出现与创伤有关的痛苦体验
- 伴随明显精神痛苦或生理反应

（3）精神运动性抑制或兴奋

抑制时可表现为：

- 目光呆滞
- 情感迟钝
- 少语少动
- 甚至木僵（stupor）

【举例】整天端坐、卧床，对外界刺激毫无反应。

兴奋时可表现为：

- 激越（agitation）
- 喊叫
- 情绪爆发
- 冲动伤人或毁物行为

（4）警觉性增高（hyperarousal）

包括：

- 过分警觉
- 反复噩梦
- 触景生情式痛苦
- 自主神经功能紊乱

常见症状：

- 心神不宁
- 头痛
- 出汗
- 失眠
- 紧张
- 坐立不安

(5) 回避与选择性遗忘

患者会：

- 尽量不去想创伤相关的人和事
- 回避能引发触景生情的活动和场所
- 对创伤事件出现**选择性失忆**

(6) 分离症状：人格解体与现实解体

- **人格解体 (depersonalization)**
- **现实解体 (derealization)**

本质上都是一种对自身或周围环境的不真实感。

【老师提示】后面视频会帮助理解这两种体验。

4. 病程演变

上述症状一般在 24~48 小时后开始减弱。若症状持续超过 1 个月，则要考虑 PTSD。

5. 急性应激障碍的亚型

有一个亚型叫：

- **急性应激性精神病**

特点：

- 由强烈心理创伤引起
- 以**幻觉 (hallucination)**、**妄想 (delusion)** 和严重情感障碍为主要表现
- 内容与应激事件密切相关，且一般可以被理解
- 虽然病情看起来严重，但病程较短，通常 1 个月内可恢复

6. DSM-5 诊断标准 (课堂版梳理)

老师按 A-B-C-D-E-F 标准讲解。

A 标准：暴露于创伤事件

包括：

- 直接经历创伤
- 亲眼目睹他人遭遇创伤
- 得知亲密家人/朋友遭遇创伤
- 反复暴露于创伤事件的令人痛苦细节中

【举例】

- 急救人员反复收集残骸
- 警察反复接触虐待儿童案件细节

B 标准：五大类症状中总计至少 9 条

五大类为：

1. 侵入性症状 (intrusion)
2. 负性心境 (negative mood)
3. 分离症状 (dissociation)
4. 回避 (avoidance)
5. 唤起 (arousal)

【要点】在相关症状中，至少满足 9 条。

侵入性症状

- 反复、非自愿、侵入性的痛苦回忆
- 反复做相关噩梦
- 感觉再次亲临事件现场，即**闪回 (flashback)**
- 接触相关线索后出现强烈心理/生理反应

负性心境

- 无法体验 positivity 情绪

分离症状

- 人格解体
- 现实解体
- 无法回忆创伤事件的重要方面

回避症状

- 回避相关记忆、思想、感觉
- 回避相关外部线索

唤起症状

- 睡眠紊乱
- 易激惹
- 愤怒爆发
- 过度警觉
- 注意力不集中
- 过度惊跳反应

C 标准：病程标准

- 暴露后持续 3 天到 1 个月

D 标准：社会功能损害

- 引起明显临床痛苦
- 或导致明显社会功能受损

E 标准：排除标准

- 排除酒精、药物或其他精神疾病所致
- 【考点】ABCDE 满足后，方可诊断 ASD。

7. 预防与治疗

(1) 预防

- 加强公众心理健康教育
- 对创伤事件开展危机干预

(2) 支持疗法 (supportive therapy)

急性应激障碍治疗首先强调支持疗法。

【学习建议】面对危机事件时：

- 要学会自助
- 依靠社会支持网络
- 促进自我修复

【干预重点】

- 减轻患者的自罪自责
- 帮助其认识：在极端事件中，很难做出“最完美选择”
- 让其意识到自己已经尽力把损害降到较低水平

此外还应：

- 设置温馨、安全环境
- 帮助其面对和认识最近的经历与感受
- 在客观危险消失后，允许适度宣泄情绪
- 保证饮水、进食、睡眠
- 维持水电解质平衡
- 防止身体衰竭

【临床关联】若创伤事件导致残疾，还需帮助患者适应残疾后的生活。

(3) 心理治疗

- 首先是认知行为治疗 (Cognitive Behavioral Therapy, CBT)

(4) 药物治疗

目的主要是减少创伤相关恐惧与激越。

可考虑：

- β 受体阻滞剂 (beta-blockers)
- 若有明显失眠、激越、躁动、自残行为，可用：
 - 抗精神病药物 (antipsychotics)

- 苯二氮卓类（benzodiazepines）
- 若伴焦虑、抑郁，可给予相应抗焦虑/抗抑郁药物
- 【用药原则】
- 以小剂量为主
- 疗程不宜过长
- 【对比】这一点与后面讲的 PTSD 不同。

九、创伤后应激障碍（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）

1. 定义

PTSD 指个体遭遇异常强烈创伤应激事件后，**较迟出现**的一类应激相关障碍。

【与 ASD 的区别】

- ASD：事件后很快出现
- PTSD：**较迟出现**
- PTSD 的病程要求通常**超过 1 个月**

2. 核心症状

PTSD 的核心表现包括：

1. 反复闯入意识或梦境的创伤性体验
2. 显著而持续的焦虑状态
3. 对创伤性事件的持续回避

3. 流行病学与危险因素

老师提到：

- PTSD 的患病率约 **5%~12%**
- 常与**酒依赖**共病

风险因素从高到低包括：

- **强奸（rape）**
- 强烈暴力行为
- 性虐待
- 严重事故或重伤
- 被刺伤、被枪击
- 亲密朋友/亲属突然去世
- 童年期受到威胁或患病
- 目睹杀人现场
- 严重事故
- 自然灾害等

4. 结合视频理解 PTSD

老师播放了美国退伍军人的英文访谈，用来帮助理解 PTSD 的真实体验。

【临床关联】视频中可见的线索包括：

- 长期参战后出现 chronic PTSD
- 曾住精神病院
- 有严重攻击冲动，甚至准备出去杀人
- 反复闪现暴力计划
- 需要多种药物控制焦虑、睡眠和激越
- 存在极重的内疚、自责、创伤回忆及社会疏离

【药物术语补充】老师借视频顺带讲了几个药名：

- **Clozapine 氯氮平**：抗精神病药，有较强镇静作用
- **Abilify 阿立哌唑（aripiprazole）**：抗精神病药，可改善古怪念头、攻击暴力行为等
- **Xanax 阿普唑仑（alprazolam）**：苯二氮卓类抗焦虑药，兼具镇静催眠作用

5. PTSD 的临床表现

（1）创伤性再体验（re-experiencing）

包括：

- 思维、记忆或梦中反复不自主出现创伤情境
- 遇到相关线索时触景生情、极度痛苦
- 闪回（flashback）
- 做与创伤相关的噩梦
- 从梦中尖叫、惊醒
- 醒后恐惧情绪仍持续
- 有时还会出现冲动行为
- 甚至出现惊恐发作（panic attack）

【解释】惊恐发作常表现为：

- 突如其来的急性焦虑
- 濒死感
- 失控感
- “快疯了”的感觉
- 一般持续十几分钟到半小时后缓解

(2) 回避与麻木 (avoidance and numbing)

回避可以是：

- 有意识回避
- 无意识回避

有意识回避：

- 极力不去想相关人和事
- 不愿谈起创伤事件

【临床关联】媒体采访、法医取证等要求患者回忆创伤事件时，可能给患者带来巨大痛苦。

无意识回避：

- 对创伤事件出现选择性遗忘
- 与创伤无关的记忆保持完好
- 也可能表现为拼命工作，用工作压住创伤回忆

【举例】视频中的美国大兵就是不停工作来回避。

情感麻木还可表现为：

- 对任何事失去兴趣
- 与外界疏离
- 缺乏信任感
- 难以建立亲密关系
- 不愿进行情感交流
- 得过且过
- 对任何事无动于衷
- 甚至出现“生不如死”、自杀观念和行为

【复习】老师特别指出：这些表现和抑郁症很相似。

(3) 分离症状：人格解体/现实解体

老师又播放了一段英文视频，专门讲：

- 人格解体 (depersonalization)
- 现实解体 (derealization)

视频中所描述的体验包括：

- 感觉自己不像一个真实的人
- 像个“幽灵”
- 像在身体外面看着自己
- 感觉一切动作不是自己在做
- 像与现实脱离
- 通过 grounding exercises (落地化训练/现实定向训练) 才能慢慢缓回来

(4) 警觉性增高

包括：

- 入睡困难
- 睡眠浅
- 容易惊醒
- 梦中反复出现创伤场景
- 惊醒后情绪激动
- 躁动不安
- 易激惹
- 难以集中注意力

(5) 伴随问题

老师强调 PTSD 常与以下问题密切相关：

- 酒精/药物滥用
- 攻击行为
- 伤人毁物
- 自杀行为
- 性格改变 (如孤僻、不再信任他人)

6. PTSD 的诊断标准 (课堂版)

老师将其与 ASD 对照讲解。

A 标准

与 ASD 基本相同：必须有创伤暴露。

B 标准：侵入性症状至少 1 条

包括：

- 反复、非自愿、侵入性的痛苦回忆
- 反复做相关噩梦
- 闪回
- 接触相关线索时出现明显心理痛苦或生理反应

C 标准：回避

至少满足以下之一：

- 回避相关记忆、思想、感觉
- 回避相关线索

D 标准：认知和心境负性改变，至少 2 条

包括：

- 无法回忆创伤的重要部分
- 持续负性信念或预期例如：“我很坏”“没人可信”“世界很危险”
- 对创伤原因/结果产生扭曲认知
- 持续自罪自责
- 恐惧、愤怒、内疚等负性情绪
- 兴趣减少
- 与他人疏离
- 无法体验正性情绪

E 标准：警觉性和反应性改变，至少 2 条

包括：

- 易激惹
- 愤怒爆发
- 不顾后果的自毁行为
- 过度警觉
- 过分惊跳反应
- 注意力不集中
- 睡眠改变

F 标准：病程

- 持续时间超过 1 个月

G 标准

- 导致明显社会功能损害

H 标准

- 排除酒药或躯体疾病所致精神障碍

7. PTSD 的治疗**（1）药物治疗**

如果伴有抑郁表现，可使用：

- **SSRI**：选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（Selective Serotonin Reuptake Inhibitors）
 - 舍曲林（sertraline）
 - 氟西汀（fluoxetine）
 - 帕罗西汀（paroxetine）
- **SNRI**：5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors）
 - 文拉法辛（venlafaxine）

【考点】PTSD 药物起效通常较慢：

- 一般 4~6 周开始改善
- 有时需 8 周或更长才达到充分治疗效果

【用药原则】

- 从小剂量开始
 - 逐渐加至治疗剂量
- 其他可合并药物包括：

- 哌唑嗪（prazosin）——对噩梦较有效
- 曲唑酮（trazodone）
- 米氮平（mirtazapine）

- 奎硫平（quetiapine）等
若表现突出，还可考虑：
- **抗肾上腺素能药物**：用于警觉高、多动、分离症状明显者
- **心境稳定剂（mood stabilizers）**：用于攻击性、冲动性、行为不稳明显者
- **新型抗惊厥药**：辅助改善睡眠
- **非典型抗精神病药**：用于明显恐惧、多疑、过度警觉等

【易错/对比】PTSD 一般不常规使用**苯二氮卓类药物**，因为研究提示其对长期预后帮助不大。这点与 ASD 的处理不同。

（2）心理治疗

首选：

- **认知行为治疗（CBT）**
核心方法：
- **暴露疗法（exposure therapy）**
【举例】如果患者因车祸后害怕坐车，可在情绪缓解后，逐步再次进入乘车环境，让其重新认识到：
 - 乘车总体是相对安全的
 - 车祸是小概率事件从而逐渐恢复信心。

（3）焦虑处理训练

包括：

- 放松训练
- 肌肉放松
- 腹式呼吸
- 正性思维训练
- 自信训练
- 学会表达感受、意见和愿望

（4）其他治疗

- **生物反馈治疗（biofeedback）**
- **无抽搐电休克治疗（modified electroconvulsive therapy, MECT）**
- **重复经颅磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS）**
【老师解释】
 - 生物反馈：通过监测脑电等指标，把情绪状态可视化，帮助患者学会调节
 - MECT：是在传统 ECT 基础上改良，加入麻醉剂、肌松剂等，减少痛苦和副作用
 - rTMS：利用外加磁场影响脑内神经元放电节律，帮助恢复较正常的脑功能节律

【易错】老师特别指出：“电磁辐射对人完全没有影响”这种说法是错误的。从 rTMS 的治疗原理就能看出，电磁刺激是可以影响神经元放电的。

十、第一节课结尾：引入“自杀”话题与教学项目招募

老师说，接下来将进入“自杀（suicide）”这一重要主题。在正式讲之前，原本准备播放一段关于抑郁症患者自杀自述的 AI 视频，但因第一节快结束，放到第二节再看。

【课堂信息】老师顺带介绍自己正在做一个课题：

- 用 **AI 短视频**来呈现精神科中较抽象的病例和症状
- 目标是辅助精神病学教学
- 当前主要是老师自己在做，非常缺人手
- 如果有同学对相关工作感兴趣，可以联系老师

十一、第二节课开始：AI 视频中的自杀未遂与抑郁症表现

第二节课一开始，老师播放了一段由 AI 制作的、整合真实案例的教学视频，内容围绕：

- 自杀未遂后的身体创伤
- 抑郁症患者的主观体验
- 抑郁症的部分核心症状

1. 视频中展示的自杀未遂体验

【临床关联】跳楼后可出现严重多发伤：

- 脚踝骨折
- 腿骨折
- 肋骨骨折
- 血气胸（hemothorax）

- 肾脏/骨盆出血
 - 腰椎粉碎等
- 视频还描述了：
- 当时意识模糊、耳鸣、说不出话
 - 明知自己快死
 - 喘不上气
 - 只想睡，但强迫自己不能闭眼
 - 抢救后反复梦见自己一遍遍跳楼
 - 醒后持续“生不如死”
 - 身体疼痛极重
 - 即使活下来了，仍感到对不起亲人，甚至“还是想死”

2. 视频中呈现的抑郁症体验

【临床关联】视频展现的典型抑郁表现包括：

(1) 兴趣丧失 / 快感缺失

- 对几乎所有事情失去兴趣
 - 以前喜欢的旅行、聚餐、工作成就都引不起波澜
- 老师借视频强调：抑郁的反面不一定是“快乐”，而可能是“生命力”。

(2) 意志活动减退

原本很简单的小事，也变成巨大负担：

- 回消息觉得麻烦
- 吃饭都觉得流程太复杂
- 倒一杯水都难如登天
- 穿衣、洗头都做不到
- 可以一个月不洗澡
- 长时间躺床不起

(3) 注意力与决策功能下降

- 看文件一下午看不进去
- 看了就忘
- 穿哪件衣服、点什么外卖都能纠结一两个小时

(4) 精神运动性迟滞/僵住

【举例】视频中描述：

- 明知该打电话求助
- 却伸不出手、拿不起电话、拨不了号
- 就这样盯着电话看了四个小时

(5) 睡眠紊乱

- 先是长期失眠
- 后来变成早醒
- 凌晨三四点突然醒来
- 醒后满脑子负面念头
- 再也睡不着

【临床关联】老师提到，很多时候精神症状出现前，身体症状已经先发出信号。

3. 课堂说明：视频并未囊括抑郁全部症状

老师说明：

- 目前视频只做出了抑郁症症状的一半
- 另一半还在制作中

十二、老师再次介绍 AI 教学视频项目

【学习建议/课程外拓展】老师再次“打广告”：

如果同学对以下内容感兴趣，可以联系老师：

- 精神疾病临床表现
- AI 视频本地化制作
- 开源模型部署
- 医学教学与 AI 结合

老师补充说明：

- 目前没有课题经费
- 没有现成“免费模型/算力”福利
- 现在主要用开源模型在本地跑

- 也在联系学校计算机教研室，看看能否借助天津科技大学高性能计算平台，为电脑性能不足的同学提供硬件支持

十三、自杀 (suicide) 话题正式开始：先纠正“觉得好笑”的态度

老师提到，放视频时有同学在笑。老师明确指出：

【课堂提醒】不要把自杀当成笑话。视频虽然是 AI 合成的教学视频，但素材来自三个真实案例。

老师强调：

- 自杀并不是离学生很远的事
- 每天都可能有大学生正在自杀
- 甚至是已经自杀死亡，不是单指自杀未遂

十四、自杀的流行病学：总体情况

1. 全球情况

老师提到 2019 年全球年龄标化自杀率地图：

- 颜色越深，自杀率越高
- 俄罗斯、部分南非国家、美国、加拿大、澳大利亚等相对较高
- 中国处于中等水平

2. 中国城乡差异

1998—2020 年中国自杀城乡分布显示：

- 农村高于城市

3. 性别差异

【考点】

- 自杀死亡 (completed suicide) 男女比约 3:1
- 自杀未遂 (suicide attempt) 男女比约 1:3

老师用很口语化的话解释：

- 女性“要死要活”更多，但不一定成功
- 男性尝试少一些，但一旦实施，成功率更高

4. 家族聚集性

自杀具有一定家族聚集倾向，提示：

- 遗传因素
 - 家庭环境因素
- 都很重要。

5. 全球青年死因排序

在 15~29 岁年龄段，全球前四位死因包括：

1. 道路交通事故
2. 肺结核
3. 人际暴力
4. 自杀

【考点】自杀在青年人中是非常重要的死亡原因。

十五、大学生自杀：老师重点展开

老师引用关于中国大学生自杀的流行病学研究。

1. 大学生自杀率并不一定高于同龄总体人群

根据以 2008—2010 年中国高校自杀数据为基础的研究：

- 我国大学生年均自杀率约为 10 万分之 1.24
 - 低于青少年总体自杀率 10 万分之 3.01
 - 也低于我国 20~24 岁总体人群自杀率（2009 年该年龄段为 10 万分之 3.79）
- 与美国相比：
- 美国大学生自杀率约 10 万分之 7.5
 - 中国大学生不到其五分之一

2. 但仍绝不能掉以轻心

【考点/老师强调】即便按 10 万分之 1.24 计算，因为我国高校在校大学生总数超过 3500 万，所以：

- 每年自杀大学生绝对数量仍会超过 400 人

- 平均每天都有 **1 名以上** 大学生自杀死亡
- 因此：
- 不能放松预防和干预
- 应持续加强大学生心理危机干预工作

3. 大学生自杀的一些特点

教育部资助项目研究显示：

- 女生自杀率高于男生
 - 家庭经济贫困者比例较高
 - 研究生自杀现象在多省市、重点高校均有发生
 - 自杀原因多元，但相对集中
- 主要相关因素包括：
- 学习竞争
 - 就业竞争
 - 失恋（仍是重要原因之一）

4. 常见方式与“网约自杀”

大学生自杀方式趋于多元，但：

- **校内跳楼** 仍是最主要方式
 - 自 2014 年以来还出现：
 - **网约自杀**
- 即有自杀意念者通过网络社交平台相约一起赴死。老师指出：
- 这些人彼此可能根本不认识
 - 因为怕一个人死、对死亡又恐惧，所以“找人作伴”
 - 社交软件会强化自杀意念，起到催化作用
- 【老师观点】
- 关闭相关 QQ 群、微信群等是必要的
 - 但关闭群并不能解决这些人的根本问题
 - 关键仍是帮助他们解决自身难以处理的人生问题

5. 纪念日

- **世界预防自杀日：9 月 10 日**
- 与教师节是同一天

十六、自杀相关概念辨析

老师专门讲了几个容易混淆的概念。

1. 自杀意念 (suicidal ideation)

- 有“想死”的念头
- 但尚未转化为行为

2. 自杀计划 (suicide plan)

比意念更进一步，已经想好：

- 什么时间
- 什么地点
- 用什么方式

3. 自伤行为 (self-harm)

如：

- 割腕留下疤痕
- 老师提醒：自伤行为有时容易被忽视，但也属于非常重要的危险信号。

4. 自杀未遂 (suicide attempt)

已经实施自杀，但未成功：

- 可能自己中止
- 也可能被别人救下

5. 自杀企图

老师特别澄清：

- “自杀企图”其实是“自杀未遂”的另一种说法
- 并不是单纯只有“想法”

6. 自杀死亡 (completed suicide)

最终因自杀而死亡。

十七、两个特殊概念：扩大性自杀与间接自杀

1. 扩大性自杀

又称：

- 怜悯性杀亲

指个体不仅自己想死，还会认为：

- “我死后孩子/家人怎么办？”
- “不如先把他们也带走”

于是：

- 先杀家人
- 再自杀

2. 间接自杀

又称：

- 曲线自杀

指个体自己想死，但又害怕直接自杀，于是：

- 通过杀人等行为
- 希望获得法律严惩
- 借此实现“死亡目的”

其特点是：

- 被害人往往和施害者没有重大利益纠葛
- 甚至可能是陌生人

十八、两个案例：扩大性自杀与间接自杀

1. 扩大性自杀案例

老师放了关于“重庆母子三人家中死亡”的报道。

【临床关联】该案特点：

- 母亲患抑郁症多年
- 在卧室烧炭自杀
- 两个孩子也一氧化碳中毒死亡
- 留有遗书，表达：
 - 自杀与长期抑郁有关
 - 老公很好
 - 对不起家人
 - 希望不要解剖、不要调查、不要上新闻

【老师借案例强调】

- 这类悲剧原本有机会预防
- 对长期抑郁患者的陪伴与监护非常重要

2. 间接自杀案例

老师播放了“自己想死但没勇气，于是杀人求死刑”的报道。

【案例要点】

- 行为人为感情受挫、自卑、心理崩溃
- 杀害与自己无仇怨的儿童
- 一开始表示就是想借法律极刑来实现死亡
- 但到审判后期又请求从轻处罚

【老师分析】这恰恰反映出自杀者常处于一种：

- 犹豫
- 摇摆
- 矛盾

的心理状态。

【危机干预启示】

- 自杀者并非总是“坚定求死”
- 外界刺激、某些报道、某种认同，都可能让他突然更靠近自杀行为
- 这正是危机干预的重要切入点

【举例】老师还举到：

- 济南抑郁症患者杀全家后自杀
- 浙江男子为情所困杀死女友后自杀
- 深圳男子割喉杀邻居求死刑
- 上海男子故意杀人求死刑

这些都属于扩大性自杀或间接自杀的相关案例。

十九、自杀方式的分布特点

老师讲到不同人群的自杀方式有差异。

1. 年龄差异

- 服农药、跳楼：随年龄增长而减少
- 上吊、开煤气：随年龄增长而增加

2. 性别差异

- 男性更多采用**激烈方式**
 - 上吊
 - 跳楼
- 女性更多采用相对“温和”的方式
 - 服药/服农药
 - 跳河

3. 城乡差异

- 城市居民：
 - 开煤气
 - 跳楼
- 农村居民：
 - 服农药
 - 跳河

【考点/干预启示】自杀方式与“工具获取便利性”密切相关。因此，**减少自杀工具的可得性**，也是自杀危机干预的重要切入点。

二十、自杀的成因：生物—心理—社会多因素模型

1. 医学遗传学方面

有自杀或自杀未遂家族史者，其亲属中：

- 有自杀行为
 - 有自杀观念
- 的比例明显更高，提示存在家族聚集性。

2. 应激-易感模型 (stress-diathesis model)

老师提到，应激易感模型认为：

- 遗传因素
 - 后天环境因素
- 共同导致个体形成某种易感素质。
- 相关因素包括：
- 早年创伤
 - 慢性疾病
 - 长期物质滥用
 - 内外环境共同作用

3. 神经生化方面

在应激环境下：

- **蓝斑 (locus coeruleus)** 神经活动增强
 - **去甲肾上腺素 (norepinephrine, NE)** 释放和代谢增加
- 提示 NE 在应激处理里作用重要。
- 老师还提到：
- **酪氨酸羟化酶 (tyrosine hydroxylase)** 是 NE 合成酶
 - 其基因与适应障碍 (adjustment disorder) 存在相关性
- 此外：
- 脑脊液中 **5-羟色胺 (serotonin, 5-HT)** 及其代谢产物 **5-羟吲哚乙酸 (5-HIAA)** 水平低下，与自杀显著相关
 - 可能因中枢 5-HT 降低，导致冲动、攻击性增加
 - 血浆胆固醇降低，也可能与自杀意念相关

二十一、社会心理因素：哪些人更容易走向自杀

1. 社会支持不足

高危因素包括：

- 社会隔离
- 孤独感强
- 社会支持差
- 缺乏可依赖的亲密关系

2. 负性生活事件

自杀前往往存在各种负性事件。

青年人常见：

- 人际冲突
- 人际关系丧失

也可有：

- 法律问题
- 经济问题

老年人常见：

- 健康恶化

3. 儿童青少年早期经历

以下因素会影响人格发展，增加成年后自杀风险：

- 父母离异
- 父母去世
- 虐待
- 忽视
- 严厉体罚
- 情感虐待
- 校园暴力/恐吓

4. 家庭精神病理背景

自杀者父母中，以下问题比例更高：

- 情绪障碍
- 物质滥用
- 攻击行为

二十二、自杀者的常见心理特征

1. 认知特点

- 认知不良
- 非此即彼
- 以偏概全
- 容易走极端
- 容易钻牛角尖
- 宿命论倾向
- 认为痛苦不可避免、问题无法解决、无法承受
- 习惯从阴暗面看待人、事、己、社会
- 容易自卑、自尊过强、怀有偏见和敌意
- 缺乏洞察、分析和处理问题能力

2. 情感特点

- 长期慢性痛苦
- 焦虑
- 抑郁
- 愤怒
- 厌倦
- 内疚
- 缺乏精神支柱
- 强烈无望感

3. 意志与行为特点

- 冲动性
- 盲目性
- 不计后果
- 人际交往少
- 回避社交
- 难以获得支持

- 适应能力差
- 对新环境不易适应
- 具有一定攻击性

二十三、自杀的社会性因素

1. 年龄

- 自杀率总体随年龄增长而升高
- 进入老年后更明显
- 10岁以下儿童少见，但有**低龄化趋势**
- 多数国家有两个高峰：
 - 15~35岁
 - 65岁以上

【考点】大学生群体正处于其中一个高峰年龄段。

2. 婚姻与家庭

- 独身、离婚、丧偶者自杀率高于婚姻稳定者
- 已婚者中：
 - 无子女者自杀率高于有子女者

3. 社会阶层

老师提到美国研究显示：

- 蓝领工人自杀率较低
 - 两端人群更高：
 - 高社会地位高压职业：医生、律师、作家等
 - 社会底层：贫困、无固定职业者
- 老师的解释是：
- 中间层生活较稳定，心理冲击相对没那么极端
 - 两端人群要么经济压力过大，要么社会地位高、精神压力极大

4. 宗教与文化

【举例】

- 基督教文化中，自杀被视为罪
 - 某些文化中，自杀可能被赋予特殊意义
- 老师用日本切腹文化举例，说明文化环境也会影响自杀发生。

二十四、与自杀密切相关的精神障碍与躯体疾病

1. 精神障碍

（1）抑郁症（depression）

由于：

- 无助
- 无望
- 无用

而出现自杀观念。

（2）双相障碍（bipolar disorder）

因既可有躁狂发作，也可有抑郁发作，因此也与自杀密切相关。

（3）PTSD

前面已讲，是重要相关疾病。

（4）精神分裂症（schizophrenia）

自杀可来自两个方面：

- 命令性幻听（command hallucination）
 - 比如幻听命令其跳楼
- 精神分裂症后抑郁
 - 患者在病情部分恢复后意识到自己患病
 - 因病耻感、长期治疗、对预后失去信心等而抑郁并自杀

（5）焦虑障碍（anxiety disorders）

严重焦虑、烦躁难忍时，也可能出现自杀行为。

（6）老年期痴呆

尤其老年男性，因从“家庭支柱”变为“功能下降、需要照顾的人”，容易产生：

- 自卑
- 拖累家人的感觉
- 自杀观念

2. 躯体疾病

在自杀死亡者中，有相当比例同时存在躯体疾病。

高风险疾病包括：

- 脑损伤
- 癫痫
- 帕金森病（Parkinson disease）
- 癌症（cancer）
- 糖尿病（diabetes mellitus）等

【原因】

- 功能受限
- 社交受影响
- 慢性疼痛
- 毁容
- 对治疗失去信心
- 经济负担重
- 觉得拖累家人

二十五、关于自杀的常见误解，老师逐条纠正

1. “自杀不可预防”

错。大多数自杀是可以预防的。

2. “自杀没有预兆”

错。多数人在自杀前都有各种预兆和表达。

3. “自杀的人就是真的一心求死”

不完全对。很多人其实处于矛盾、犹豫、摇摆状态。

4. “谈自杀的人不会真的去死”

错。很多人会在自杀前直接或间接表达过其意愿。

5. “有自杀想法的人就是精神病”

这是错误贴标签。会使其感到侮辱和歧视，反而加重风险。

6. “不能和有自杀念头的人谈自杀”

错。恰恰应该适当沟通，以便：

- 识别风险
- 评估企图
- 让对方感受到被理解、支持、关爱

7. “自杀危机缓解了就没事了”

错。自杀危机干预需要持续进行，不能只看眼前好转。

二十六、自杀的先兆表现：老师反复强调要会识别

1. 高危线索

- 最近曾自杀过
- 有明确自杀计划
- 家庭中刚有人自杀
- 近期重大失落
- 对生活失去兴趣
- 感到无助、绝望
- 突然饮酒/吸毒
- 生活习惯突然改变
- 把珍贵、纪念性物品送人
- 情绪明显不稳定
- 经常谈到死亡

2. 言语线索

直接表达

- “我不想活了”
- “我想自杀”

间接表达

- “没人能帮我”
- “没有我大家都会更好”
- “我受不了了”
- “生活没意义”
- “再也受不了这种痛苦了”

还包括：

- 谈论自杀
- 拿自杀开玩笑
- 谈自己准备怎么死
- 与他人告别
- 主动获取自杀方式或工具等

3. 行为线索

- 严重抑郁
- 突然行为改变
- 白日梦增多
- 幻觉出现等

【老师提醒】新闻里有人跳楼/跳桥但最后没跳，不应仅仅理解为“闹事”“讨债”“获利手段”。在危机干预中，仍要把这类表现按**真实自杀风险**来对待。

二十七、几个特别需要提高警惕的人群与时段

老师再次强调，自杀高危人群包括：

- 抑郁症患者
- 精神分裂症患者
- 酒依赖患者

【易错】尤其要警惕一种情况：

如果这类患者的情绪**突然“好转”**，不一定真的是病好了，有时反而可能是：

- 已经下定决心准备自杀
- 情感上出现了“解脱感”

老师还提到：

- 抑郁症自杀不一定发生在最重的时候
- 在疾病缓解期也可能风险很高
- 某些抗抑郁药说明书中甚至会提示：早期可能**不降低反而增加**部分患者自杀风险

【原因理解】可能是：

- 患者情绪尚未明显改善
- 但行动能力先恢复了一部分
- 于是更有能力把自杀想法转化为行为

二十八、本节内容的结尾情况

本次转写在最后一段中断，老师最后正在讲：

- 抑郁症患者在疾病高峰期与缓解期的自杀风险差异
- 抗抑郁药与自杀风险之间的复杂关系

因此这部分内容在原始录音中应还有后续，但当前总稿到此结束。

本节英文术语索引

- 危机 — crisis
- 心理危机 — psychological crisis
- 心理危机干预 — crisis intervention
- 发展性危机 — developmental crisis
- 境遇性危机 — situational crisis
- 存在性危机 — existential crisis
- 冲击期 — impact phase

- 防御期 — defensive phase
- 解决期 — resolution phase
- 成长期 — growth phase
- 国际疾病分类 — International Classification of Diseases (ICD)
- ICD 第 11 版 — ICD-11
- 精神障碍诊断与统计手册 — Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)
- DSM 第 5 版 — DSM-5
- 创伤及应激相关障碍 — Trauma- and Stressor-Related Disorders
- 急性应激障碍 — Acute Stress Disorder (ASD)
- 创伤后应激障碍 — Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
- 焦虑 — anxiety
- 抑郁 — depression
- 自杀 — suicide
- 自杀意念 — suicidal ideation
- 自杀计划 — suicide plan
- 自杀未遂 / 自杀企图 — suicide attempt
- 自伤行为 — self-harm
- 幻觉 — hallucination
- 妄想 — delusion
- 木僵 — stupor
- 定向障碍 — disorientation
- 闪回 — flashback
- 人格解体 — depersonalization
- 现实解体 — derealization
- 警觉性增高 — hyperarousal
- 支持疗法 — supportive therapy
- 认知行为治疗 — Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
- 暴露疗法 — exposure therapy
- β 受体阻滞剂 — beta-blocker
- 苯二氮卓类 — benzodiazepines
- 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 — Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI)
- 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 — Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRI)
- 舍曲林 — sertraline
- 氟西汀 — fluoxetine
- 帕罗西汀 — paroxetine
- 文拉法辛 — venlafaxine
- 哌唑嗪 — prazosin
- 曲唑酮 — trazodone
- 米氮平 — mirtazapine
- 奎硫平 — quetiapine
- 氯氮平 — clozapine
- 阿立哌唑 — aripiprazole (Abilify)
- 阿普唑仑 — alprazolam (Xanax)
- 生物反馈治疗 — biofeedback
- 无抽搐电休克治疗 — modified electroconvulsive therapy (MECT)
- 重复经颅磁刺激 — repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)
- 惊恐发作 — panic attack
- 双相障碍 — bipolar disorder
- 精神分裂症 — schizophrenia
- 命令性幻听 — command hallucination
- 心境稳定剂 — mood stabilizer
- 酒依赖 — alcohol dependence
- 物质滥用 — substance abuse
- 应激-易感模型 — stress-diathesis model
- 适应障碍 — adjustment disorder
- 蓝斑 — locus coeruleus
- 去甲肾上腺素 — norepinephrine (NE)
- 酪氨酸羟化酶 — tyrosine hydroxylase
- 5-羟色胺 — serotonin (5-HT)
- 5-羟吲哚乙酸 — 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA)
- 帕金森病 — Parkinson disease
- 血气胸 — hemopneumothorax

如果你愿意，我下一步可以把这份笔记再压缩成一版“考前速记版”。

第4讲：预防、依恋与危机干预

一、课程导入：什么是心理危机，为什么要讲“预防”

老师先说明：本节课重点不是单纯重复“什么是心理危机”，而是从**预防（prevention）**的角度来理解心理危机。

- 所谓**心理危机（psychological crisis）**，本质上是一种**心理失衡状态**：
 - 正常状态下，人能较好处理学习、人际关系和日常任务。
 - 危机状态下，原有的内在平衡和生活秩序被打破。
- 【举例】老师用大学生日常情境说明危机如何被触发：
- 考试挂科、多门不及格，学业亮红灯。
- 面临分流、四六级不过。
- 就业压力大，反复面试却不断被刷。
- 对多数同学来说，这些可能只是“人生的一道坎”，经过短期调整后可以重新恢复平衡。
- 但对少部分同学而言，这些事件会被体验为**重大挫折**，进而引发：
 - 对自我能力的怀疑；
 - 对未来发展的悲观；
 - 对自我价值的否定；
 - 甚至出现抑郁倾向，或已达到**抑郁症（depression）**诊断标准；
 - 严重时可能无法上课、无法与他人建立关系。

老师强调：

- 如果一个人能把危机事件处理好，重新恢复平衡，这一过程也可能带来成长：
 - 重新思考“我是谁”；
 - 重新思考“我适合做什么”；
 - 重新发现“我在哪些方面有价值”。
- 但如果：
 - 缺乏有效应对方式；
 - 缺乏朋友、家庭等支持系统；
 - 周围人不能理解、支持和关怀；
 - 仅靠自己又无法解决眼前困难；就更容易发展为真正的心理危机。

二、心理危机的影响因素：先看哪些人风险更高

老师提出：要做预防，首先要知道**哪些人更容易陷入心理危机**。

1. 生物学因素（biological factors）

老师指出，心理危机并不完全是后天造成的，**先天差异**也很重要。

- 有调查显示：**30%~50% 的自杀风险与遗传因素有关**。
- 人与人之间本来就有差异，包括：
 - **神经冲动水平**不同；
 - **敏感性（sensitivity）**不同；
 - 有些人属于**高敏感人群**。

【举例】同样被人批评，有的人“脸皮厚一点”就过去了；但高敏感个体会：

- 当场感觉崩溃；
- 事后反复回想；
- 一直纠结“是不是我哪里不好”。

老师进一步指出：

- 有的人天生对刺激更敏感；
- 有的人天生“神经比较大条”，对刺激不太敏感；
- 有的人先天更容易**冲动（impulsivity）**；
- 有的人则更稳重，遇事能先让自己平复。

【举例】同样是被老师批评、或与室友争吵：

- 有的人会先稳住自己；
- 有的人则容易在高唤起状态下做出**不计后果**的行为。

结论：这些差异并不只是后天教养造成，也与**遗传和生物学基础**有关。

三、心理因素：哪些人格与认知模式容易把人推向危机

老师接着从心理层面分析心理危机的高危因素。

1. 易损人格特质：完美主义（perfectionism）

老师指出，**完美主义人格**是重要的风险因素。

- 一般来说，越是高成就群体，越容易出现较高比例的完美主义特质。
- 这也解释了为什么一些“看起来很优秀”的人，心理危机发生率反而不低。

老师强调，完美主义有两个维度：

(1) 积极维度：高标准、高期待

- 希望自己做得很好；
- 对自己有要求；
- 这一面能够促进成就。

(2) 消极维度：高批评（self-criticism）

- 一旦做不好，就强烈批评自己：
 - “我怎么可以做不好？”
 - “我怎么这么差劲？”
- 如果这一维度高，就更容易出现：
 - 心理压力；
 - 焦虑（anxiety）；
 - 抑郁（depression）；
 - 自杀倾向（suicidal tendency）风险升高。

【举例】同样是挂科或分数不理想：

- 一般人可能会想“这次没发挥好”“我没准备好”；
- 高批评型完美主义者会想：
 - “我怎么能允许自己考这么差？”
 - “别人会怎么看我？”
 - “我是不是根本不行？”

老师总结：完美主义，尤其是其中**高自我批评**的部分，与抑郁、焦虑、自杀倾向都呈**高相关**。

2. 冲动性 (impulsivity) 与情绪调节失调

老师说明，危机与**冲动性**也高度相关。

冲动性有两层来源：

(1) 先天神经冲动性差异

- 有的人本来就更容易冲动。

(2) 情绪调节功能失调

- 正常成年人在面对刺激时，通常有一定**情绪调节（emotion regulation）**能力：
 - 能换个角度思考；
 - 能自我安抚；
 - 不至于陷入持续自责。
- 但冲动特质明显的人，往往缺乏这种调节能力。

老师提到一个重要概念：

- **反刍性思维（rumination）**：反复陷在负性思维循环里，持续自责、自我否定。

这类个体常见特点：

- 思维容易钻牛角尖；
- 看问题僵化；
- 觉得“事情就是这样，没法改变”；
- 很难从辩证、发展的角度理解问题。

【老师概括危机中常见状态】

很多陷入危机的同学会说：

- “没有希望了。”
- “未来没有希望了。”
- “这件事没办法解决了。”

老师认为，很多危机并非因为“真的毫无出路”，而是因为：

- 思维僵化；
 - 只看到唯一的狭窄出口；
 - 看不到其他可能性。
-

3. 失调的认知图式 (cognitive schema)

老师接着引入“**认知图式（schema）**”概念。

所谓认知图式，是指一个人：

- 如何看待自己；

- 如何看待他人；
 - 如何看待世界。
- 这些图式来自成长过程中的长期经验积累。

(1) 关于自我的图式

老师说明：

- 早期我们往往是通过别人的反馈来认识自己。
- 如果经常被表扬，就更容易觉得：
 - 自己是好的；
 - 自己是可爱的。
- 如果长期被批评、被否定，就可能形成：
 - “我很差劲”；
 - “我连小事都做不好”；
 - “我不值得被肯定”。

(2) 关于他人的图式

- 别人是否可靠？
- 我能不能信任别人？
- 别人靠近我是安全的还是危险的？

(3) 关于世界的图式

- 外界是安全的还是危险的？
 - 他人是可依靠的还是伤害我的？
- 老师强调，如果一个人形成了**负性认知图式**，那么在接受外界信息时，就更容易：
- 选择性关注负面信息；
 - 用原有模板解释世界；
 - 反复验证自己的负性假设。

【举例】

如果一个人内心已有“我不可爱”“我不值得被爱”的图式，那么：

- 别人聚会没叫自己，就会自动解读为：
 - “他们是不是不喜欢我？”
 - “我是不是不值得被关注？”
- 这会进一步强化其负性自我认识，形成**恶性循环**。

老师总结：

- 容易抑郁的人，更容易用抑郁的方式解读世界；
- 容易焦虑的人，更容易用焦虑的方式解读世界；
- 问题不一定在外界，而可能在于**加工外界信息的方式存在偏差**。

4. 问题解决不足 (poor problem solving)

老师强调，很多危机个体还有一个共同点：**问题解决策略不足**。

- 他们看不到外界资源；
- 看不到帮助；
- 觉得别人不会理解自己；
- 也不相信别人能帮到自己。

【举例：考试焦虑】

老师提到，有些大学生在考试前焦虑到：

- 根本无法去考试；
- 觉得“天塌了”；
- 因为从小到大，自己一直依靠考试来获得认可；
- 到大学发现自己不再有明显优势时，就开始严重怀疑自我价值。

但老师举例说，其实这类问题也可以有解决策略，例如：

- 申请**缓考**；
- 暂时回家休息；
- 调整心态后再回来考试。

老师指出：

- 虽然这种做法带有一定回避色彩，但它依然是一种**问题解决策略**；
- 许多同学陷入危机，不是因为绝对没有办法，而是因为**看不到办法**。

老师的核心观点是：

- 在任何糟糕的状态下，都仍然存在某种解决问题的方法；
- 危机中最可怕的，不是困难本身，而是**看不到出路**。

5. 对自身问题解决能力缺乏信心

老师进一步指出，有些人即使已经看到策略，仍然会怀疑自己：

- “这样行吗？”
- “我能做到吗？”
- “这个办法靠谱吗？”

【举例】初中、高中拒学的孩子会认为：

- 不上学，别的路也走不通；
- 上学这条路又被自己堵死了；
- 其他事自己也做不成；
- 好像每一条路都没有出口。

老师在这里强调一个重要观点：

- 每个人都有个体差异；
 - 不是每个人都擅长学习；
 - 但每个人都一定有自己擅长的领域；
 - 只是在危机中，人往往看不到自己的价值和可能性。
-

四、应激事件：危机的“扳机点” (trigger)

老师指出：

- 生物学因素、心理因素是**易感因素**；
- **应激事件 (stressful event)** 则像一个“**扳机点 (trigger)**”，会把这些潜在风险激活。

【举例：失恋】

- 对大多数人来说，失恋虽痛苦，但经过两三个月、半年，通常可以逐渐恢复；
- 但有些人会因为失恋出现：

- 跑去对方学校或单位大吵大闹；
- 寻死觅活；
- 做出极端行为。

老师用比喻说明：

- 同样一块石头扔进水里，每个人激起的涟漪不一样。
- 不同反应，和一个人的人格特质、心理状态、神经冲动性、依恋状况等都有关。

【举例：四级没过】

老师提到一个真实类型案例：

- 某同学因为**英语四级没过**，最终做出极端行为。
- 问题不只是“四级没过”本身，而是这个同学把：
 - 自我价值；
 - 能力感；
 - 未来前途；

全都和四级绑定在一起。

因此，某个具体事件就成了危机的启动按钮。

五、应激事件的常见类型

老师继续列举多种可能激发危机的应激事件。

1. 突发事件

包括：

- 家庭重大变故；
- 失恋；
- 自然灾害；
- 社会公共意外事件；
- 火灾、地震等；
- 疫情等公共卫生事件。

【举例】老师提到：

- 地震、火灾、社会公共事件；
- 疫情最初阶段，特别是身处疫区或一线的医护人员，也会面临较大的心理危机。

2. 严重身体疾病

老师强调：

- 身体健康与心理健康密切相关；
- 如果一个人身患重病，尤其是绝症，其心理状态通常会受到重大影响。

并指出，这类人往往会经历一个过程：

- 最开始难以置信、难以接受；
- 之后逐渐接受；
- 再慢慢修复。

3. 环境适应不良

老师特别强调了“适应”本身就是危机因素。

【复习/延伸】老师提到一项经验性观察：

- 高中、初中毕业班学生的心理健康状况，反而可能好于刚入学的新生。
 - 即：
 - 高一、初一等刚进入新环境的学生，
 - 有时比高三、初三更需要关注。
- 原因在于：适应压力。

六、大学适应问题：宿舍、学习、人际、自律都可能成为危机来源

老师把重点落在大学生常见危机情境上。

1. 第一次住校、过集体生活的适应

老师提醒大家不要小看“住校”这件事。

- 有人喜欢热闹，适应得很好；
 - 有人却觉得非常折磨。
- 主要冲突包括：
- 熄灯时间与作息不同；
 - 室友夜间活跃、讲话、听音乐、打游戏；
 - 自己想睡觉却被影响；
 - 宿舍文化和个人习惯冲突。

2. 私人边界与宿舍摩擦

【举例】老师提到常见矛盾：

- 室友未经同意使用自己的肥皂、盆、耳机、充电器等。
- 有的人会觉得：
 - “都这么熟了，用一下还要打招呼吗？”
- 但另一些同学真正介意的不是“东西本身”，而是：
 - 自己的私人空间是否被尊重；
 - 自己作为个体是否被尊重。

老师指出：

- 看似“鸡毛蒜皮”的小事，
- 往往正是宿舍关系破裂、冲突升级的根源。

3. 大学生活的自由与空虚

老师指出，从高中进入大学后，许多外部管束突然减少：

- 没有人天天催你学习；
 - 老师上完课就不再紧盯；
 - 家长也不在身边时时管着。
- 短期看会觉得很自由，但长期可能出现：
- 空虚；
 - 缺乏规划；
 - 自律不足。

【举例】老师说，有同学大学四年一直打游戏，直到找工作时突然觉醒，发现自己：

- 好像一无所获；
- 没学到什么；
- 成长很慢；

于是开始出现抑郁和焦虑。

4. 学业压力与学习困难

老师再次提到：

- 多门不及格；
- 学业压力大；
- 学习困难；
- 学习不再是自己优势时的自我怀疑。

5. 家庭贫困与经济负担

- 担心家庭经济压力；
- 想通过兼职减轻父母负担；
- 又难以平衡学业与打工之间的关系。

6. 人际关系失调、就业困难、考研失败

包括：

- 投简历石沉大海；
- 毕业求职困难；
- 考研失败；
- 对未来极度焦虑。

7. 同伴危机的“传染性”影响

老师指出，身边同学出现危机，也会影响自己。

【举例】

- 有同学长期接触一个抑郁状态很重的朋友；
- 对方天天发大量负面、抑郁图片；
- 时间久了，自己的情绪也被明显拖低。

老师借此说明：同龄人对同龄人的影响是非常大的。

七、创伤（trauma）：心理危机背后的深层因素

老师继续分析心理危机的另一个重要来源：创伤（trauma）。

1. 创伤的基本含义

老师给出的核心理解是：

- 创伤不是单纯“遇到困难”；
- 而是个体处于**威胁性环境**中，且其防御和应对能力不足，导致一种：
 - 无助感；
 - 无法防备感；
 - 内在理解被撼动的经历。

创伤会长期影响一个人对以下内容的理解：

- 对自己的理解；
- 对他人的理解；
- 对世界的理解。

2. 创伤会动摇人的基本信念

老师指出，人在正常状态下通常有一些基本信念，例如：

- 生活是可预测的；
- 我对生活有一定掌控感；
- 世界基本是公平的；
- 我是有价值的；
- 危险离我很远。

而在创伤状态下，这些信念会被动摇：

- 生活变得不可预测；
- 世界不再公平；
- 自我价值感下降；
- 危险感显著上升。

【举例】

- 发生地震的人，会觉得世界突然失控；
- 得绝症的人，会觉得“为什么这种事会落到我头上”；
- 经历战争的人，不会再觉得“危险离我很远”。

八、依恋（attachment）与依恋创伤：危机的关键背景

在第一段末尾，老师引出“**依恋（attachment）**”概念，第二段接着重点展开。

1. 为什么要讲依恋创伤

老师说明：

- 很多创伤、很多心理危机，和**依恋创伤（attachment trauma）**密切相关；
- 在各种创伤中，依恋创伤占有很大比重。

2. 依恋的定义

依恋是指：

- 人在出生后与**重要抚养者（primary caregiver）**建立起来的一种情感连接。
老师强调，依恋对整个人的发展都很重要，因为它是：
 - 安全感（sense of security）的基础；
 - 基本信任（basic trust）的基础。

3. 零到一岁的核心心理任务：建立信任感

老师指出，在心理发展中：

- 0~1岁的重要任务就是建立**信任感（trust）**。
 - 原因是：
 - 婴儿无法独立生存；
 - 需要喂养、保暖、安抚；
 - 如果其需要能够被及时、稳定地回应，就会逐渐形成：
 - 世界是可信的；
 - 世界是安全的；
 - 我是可爱的；
 - 我是有能力的。
 - 也就是说，早期被如何对待，会逐渐沉淀为：
 - 我怎么看自己；
 - 我怎么看别人；
 - 我怎么看这个世界。
-

九、依恋实验：小猴子更需要“情感抚慰”而不只是喂养

【举例】老师讲到经典心理学实验：

- 把刚出生的小猴子放在两个“模拟母猴”前面：
 - 一个是**有奶瓶的铁丝母猴**；
 - 一个是**包着柔软毛巾的母猴**。
 - 结果是：
 - 小猴子只有在饿得不行时，才去有奶瓶的铁丝母猴那里吃奶；
 - 其余大部分时间，都待在柔软的“毛巾母猴”身边。
 - 老师借此说明：
 - 婴儿需要的并不仅仅是食物，
 - 还需要**情感上的依附、安全与安抚**。
-

十、依恋的形成：生命早期“跟谁长大”非常重要

老师指出：

- 在生命最早期，尤其**0~3岁**，
 - 跟谁一起长大，对后续人格和关系模式影响很大。
 - 可能是：
 - 母亲；
 - 父亲；
 - 姥姥姥爷；
 - 爷爷奶奶；
 - 或其他主要照顾者。
 - 通常：
 - 早期长期陪伴、照顾自己的人，
 - 往往就是日后自己最亲近、最有情感连接的人。
 - 老师把这概括为：这是人生命早期形成的、与重要他人的情感连接。
-

十一、依恋如何影响成人后的恋爱与人际关系

老师指出：

- 婴儿期的依恋经历，会成为儿童期乃至**成人期关系模式的模板**；
- 包括恋爱关系，也是一种依恋关系。
- 【举例】老师说，很多人会发现：
 - 自己谈恋爱时，总在想“同一类人”；
 - 即使换了对象，某些人格特质、心理特征还是很相似。
- 这说明：
 - 人在关系中有自己的**内在模板（internal working model）**；
 - 会反复被某类关系吸引。
- 【举例】
 - 有些人在亲密关系中会觉得：

- “太近了我就想跑。”
 - “关系一靠近，我就觉得不安全。”
 - “我会觉得被吞没、被控制。”
- 老师认为，这类表现常与早期依恋经验有关。
-

十二、四种依恋类型 (attachment styles)

老师接着系统讲了依恋类型。

1. 安全型依恋 (secure attachment)

在儿童期的表现：

- 母亲离开时会难过；
- 重新相聚后很快恢复开心。

在成人后的表现：

- 在浪漫关系中较自由、自主；
- 进入婚姻或家庭关系后，距离感较灵活；
- 既能享受亲密，也能享受独处；
- 人际关系总体更适应性。

老师指出：

- 安全型依恋在人群中比例最高。
-

2. 回避型依恋 (avoidant attachment)

在儿童期的表现：

- 照顾者离开或回来，表面上都“无所谓”；
- 不是内心真的不在乎，而是表现出退缩、忽视和拒绝依恋需求。

在成人后的表现：

- 关系中容易疏远、退缩；
 - 情感回避；
 - 不愿谈内心感受；
 - 较回避身体和情感上的接近。
-

3. 焦虑型 / 抵抗型依恋 (anxious / resistant attachment)

在儿童期的表现：

- 对照顾者离开非常敏感、警觉；
- 强烈黏着照顾者；
- 特别害怕分离。

在成人后的表现：

- 亲密关系中容易过度接近；
 - 纠缠；
 - 侵入性强；
 - 边界不清；
 - 非常害怕被抛弃。
-

4. 紊乱型依恋 (disorganized attachment)

特点是：

- 同时带有回避型和焦虑型的特征；
 - 人际边界更混乱；
 - 关系模式更不稳定。
-

十三、依恋创伤如何在危机中被激活

老师强调：

- 创伤，尤其是依恋创伤，常常会在后来的关系事件中被重新激活。

【举例：失恋】

有些人失恋后反应极端，不只是因为“分手”本身，而是因为：

- 分手激活了早年被拒绝、被抛弃的体验；
 - 再次唤起了那种原始的崩溃感。
- 老师指出：
- 很多危机看起来只是“危机事件”，
 - 其实背后是**旧创伤被点燃了**。
- 并进一步强调：
- 依恋不仅影响正常心理发展，
 - 也会调节一个人的**生理唤醒水平**和对刺激的反应；
 - 同样的应激事件，之所以有人反应更大，往往与早年依恋创伤被触发有关。
-

十四、创伤会让人更渴求关系，但又可能不信任关系

老师在这里提出一个关键判断：

- **任何创伤都会激活人的依恋系统。**
- 因为当一个人陷入创伤时，他会感到：
- 生活失衡；
 - 内心失控；
 - 安全感被破坏。
- 而在这种情况下，人最本能的需要就是：
- 抓住一个关系；
 - 寻找支持。
- 但问题在于：
- 如果此人拥有充足社会支持，
 - 大概率不至于陷入严重危机；
 - 如果其过去依恋经历不安全，
 - 会觉得关系靠不住；
 - 会觉得关系具有侵入性；
 - 最终还是陷入危机和孤立。
- 老师总结一句很重的话：
- **基于人际关系的创伤最难以忍受，关系越亲密，伤害越重。**
- 【举例】
- 有些人一分手就寻死觅活；
 - 有些人会伤害自己，或者通过服药等激进行为表达痛苦；
 - 本质上是依恋系统被强烈破坏了。
-

十五、强迫性重复 (repetition compulsion)：为什么总是找“同一类人”

老师提到一个重要心理现象：**强迫性重复 (repetition compulsion)**。

表现为：

- 明明上一段关系很痛苦；
- 但下一段仍会被类似的人吸引；
- 关系模式不断重演。

老师解释：

- 熟悉的关系模式会带来一种“可掌控感”；
- 哪怕这种熟悉未必健康，它仍会让人感觉安全；
- 甚至对于一些人而言，**糟糕的关系也胜过没有关系**。

【举例】

有些同学明明觉得当前恋爱关系并不满意，却还是不愿离开，因为：

- 大家都在谈恋爱；
 - 自己害怕孤单；
 - 哪怕关系不好，也比完全没有关系更容易承受。
-

十六、依恋创伤的后果：基本信任被破坏，情绪与认同都会受影响

老师总结依恋创伤的影响时提到：

- 会破坏**基本信任感 (basic trust)**；
- 包括对世界、对重要他人的信任。

当个体受到刺激时，创伤还可能带来：

- 情绪紊乱；
 - 自我认同下降；
 - 知觉障碍；
 - 记忆损害等。
-

十七、创伤不一定只发生在童年，成年后的重大创伤同样深重

老师特别澄清一个常见误解：

- 不是说只有童年创伤才重要；
- 成年后的重大创伤，同样可能深刻改变一个人。

【举例：战争与 PTSD】

老师举例说：

- 很多经历过战争的老兵，即使战争结束后已经回归平静生活，
- 仍会长期受创伤影响，
- 出现**创伤后应激障碍（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）**表现，如：
 - 做噩梦；
 - 闪回（flashback）；
 - 好像再次回到战场。

老师借此说明：

- 创伤可以贯穿整个人的生命周期；
 - 只是生命早期因应对能力弱，更容易形成深层影响。
-

十八、创伤如何在后来事件中被重新唤醒

【举例】老师举了两个非常典型的例子：

1. 童年羞耻创伤被研究生阶段激活

- 一个孩子8岁时，在比赛中罚丢了关键球；
- 教练在队友和父母面前大吼大叫；
- 这个羞耻体验未被处理好，埋在心里。
- 到了读研后，导师在课题组公开说其研究“是一团垃圾”，
- 就可能再次激活当年的羞耻创伤，
- 让人回到当年被当众羞辱的情境中。

2. 失恋激活早年被抛弃经历

- 表面上只是“男朋友/女朋友提出分手”；
 - 但对有些人而言，真正被唤起的是：
 - 早年被抛弃；
 - 被送人；
 - 被拒绝；那种深层体验。
- 老师想强调的是：
- 很多危机表面上是“现在发生的事”，
 - 实际上背后连着“很早以前没处理完的事”。
-

十九、如何预防心理危机：从可改变的部分入手

老师进入本节核心的“预防”部分，指出：

- 生物学因素改变不了；
 - 但很多心理与行为层面的因素，是可以逐渐调整的。
-

二十、【学习建议】调整完美主义：允许自己做不到“样样都好”

老师先谈完美主义的调整。

1. 人格会逐渐固化，但大学阶段仍很有可塑性

老师指出：

- 人格到成年后会逐渐固化；
- 老年人的人格更难改变；
- 但大学生还处在很有可塑性的阶段。

2. 不能要求自己所有维度都完美

【举例】老师列举大学生常见“全都想做好”的状态：

- 学习要顶尖；
- 社团要活跃；
- 还想兼职赚钱；
- 还想当班干部；
- 还想做老师助手；
- 还想学才艺。

老师提醒：

- 每个人都只有 24 小时；
- 时间和精力并不会因为你要求高就自动增加；
- 如果什么都想做到很好，只会把自己累垮。

3. 允许自己在“不重要的方面”不那么优秀

老师的建议是：

- 不必在每个方面都做到最好；
- 在一些不重要的方面，可以允许自己犯错、允许自己没那么好；
- 适度的不完美，反而更容易被人接纳。

【学习建议】老师原话核心意思可整理为：

- 允许自己犯错；
- 承认自己有不足；
- 不必处处苛求；
- 一个人适当不完美，往往更可爱，也更轻松。

二十一、【学习建议】减少冲动性：先给自己一个“缓冲地带”

对于冲动性较高的人，老师提出非常具体的建议：

- 在情绪高唤起的时候，不要立刻行动；
- 给自己几秒钟缓冲；
- 深呼吸；
- 先冷静下来；
- 再考虑怎么解决问题。

【举例】

如果自己特别容易：

- 和别人冲突；
- 一激动就想动手；
- 一生气就想把对方狠狠干一顿；

那么更要训练自己：

- 暂停；
- 冷静；
- 延迟反应。

老师指出：

- 两个人吵架，往往是越吵越凶；
- 如果先分开，各自找空间冷静，很多架其实是吵不起来的。

二十二、【学习建议】修正失调认知图式：重新看待自己、他人和世界

老师强调：

- 图式虽然早年形成，但不是永远不能变。

1. 重新看待自己

如果你总觉得自己很差劲，就要反思：

- 我真的一无是处吗？
- 我身上真的没有任何闪光点吗？

老师指出：

- 一个人能够一路活到现在、走到现在，
- 一定有一些地方是做得好的；
- 只是很多人看不到自己身上的“资源”和“宝藏”。

2. 重新看待别人

如果一个人曾被霸凌、被欺骗，就可能形成：

- 人不可靠；

- 人让人害怕；
 - 我要远离人群；
 - 我要用盔甲把自己包起来。
老师承认：
 - 这种模式曾经可能是保护自己的方式；
但老师也提醒：
 - 当你未来想建立亲密关系时，这种高度防御就会变成障碍；
 - 别人走不进你，你也无法真正走向别人。
【学习建议】老师给出的方向是：
 - 选择相对安全的人际关系；
 - 在安全的基础上，一点点“松绑”；
 - 逐渐放下一部分防御；
 - 学会在关系中感受安全，而非一直封闭自己。
-

二十三、【学习建议】提高问题解决能力：不要只靠自己死扛

老师强调，很多危机其实和“不会求助”有关。

1. 要看到其他人的视角

【举例】老师讲了“多级火箭”灵感故事：

- 发明者苦思冥想，想不出怎样靠足够燃料把卫星送上轨道；
- 后来受到“吹笛子合奏”的启发，想到多级装置逐步脱落的办法。

老师用这个故事想说明：

- 很多问题靠一个人是想不到突破口的；
- 别人未必是你这个专业的同行；
- 但他可能正好能看到你看不到角度。

老师借用古诗意思说明：

- 身在局中，反而容易看不清；
- 换个视角，可能就能看到新的出路。

【学习建议】

- 遇到困难要学会求助；
 - 不要只困在自己的视角里；
 - 可以向同学、朋友、老师、学长学姐请教；
 - 通过“多视角”寻找解决策略。
-

二十四、【学习建议】理解创伤对自己的影响，并尝试疗愈

老师指出：

- 如果一个人曾经历过创伤，就要逐渐学会觉察：
 - 过去的经历是如何影响现在的；
 - 自己是否在重复旧模式；
 - 是否总在进入类似的关系和困境。

【学习建议】

- 识别自己是否在重复过去的关系模式；
 - 一点点从旧创伤里走出来；
 - 尝试建立更健康的关系；
 - 允许自己被修复，而不是一直被旧创伤牵着走。
-

二十五、【学习建议】必要时寻求心理咨询 (psychological counseling)

老师明确提到：

- 心理咨询是疗愈心理创伤的一种方式。
因为：

- 很多创伤是人不愿轻易让别人看到的；
- 但它们又确实在影响：
 - 危机发生；
 - 亲密关系建立；
 - 当下生活功能。

老师认为，在一个安全的咨询关系中，可以逐渐做到：

- 看见过往经历对自己的影响；
 - 理解自己当前关系模式的问题；
 - 学会改善现有关系与应对方式。
-

二十六、【学习建议】同辈互助：同学、室友、学长学姐都是重要资源

老师转到大学校园现实场景，指出：

- 每个班通常都有心理委员、生活委员；
- 但更普遍、更容易用到的其实是：
 - 室友；
 - 同伴；
 - 学姐学长；
 - 学弟学妹；
 - 朋友。

老师认为：

- 对大学生来说，遇到困难时最常见的求助对象就是同龄人；
- 因为他们更有类似的生活经历，也更容易理解你的处境。

【学习建议】

遇到心理危机时，要学会求助于：

- 同伴；
 - 室友；
 - 朋友；
 - 学长学姐；
 - 学弟学妹等现实支持系统。
-

二十七、【考点/提醒】作为同伴，也要学会识别危险信号并及时转介

老师特别提醒：

- 如果我们自己是被求助对象，
 - 尤其当发现对方出现**自杀相关危险征兆**时，
 - 要有警觉意识。
- 关键原则是：
- 识别危险信号；
 - 及时转介；
 - 面对紧急情况不能只靠“陪聊”，要升级处理。
-

二十八、危机干预（crisis intervention）的基本技巧

老师随后从“预防”过渡到“危机干预”。

1. 倾听（listening）

【举例】如果一个失恋、情绪极差，甚至有轻生念头的同学来找你：

首先要做的是：**做一个好的倾听者**。

老师强调：

- 不急着评判；
- 不抢着讲大道理；
- 不在对方没说完时就打断和否定。

并指出，倾听不仅适用于危机情境，也适用于日常关系。

倾听包括两部分：

（1）言语倾听

- 用语言鼓励对方继续表达。

（2）非言语倾听

- 你的身体在场，心也要在场；
 - 不是一边玩手机一边敷衍听；
 - 而是真正面对着对方，认真听他说。
-

2. 共情 (empathy)

老师强调：**共情 (empathy)** 是非常重要的心理学概念。

共情的意思是：

- 设身处地理解对方的想法和感受。

老师特别区分了：

- **共情 ≠ 同情 (sympathy)**

区别在于：

- 同情往往带有一点“我高你低、我觉得你很惨”的意味；
- 共情则是站到对方的位置上去感受他的处境。

3. 情感反应 (emotional reflection)

老师说，在共情基础上，还要做出适当情感回应，例如：

- “我知道你现在很不容易。”
- “我知道你现在很难。”
- “我知道你现在很委屈。”
- “我知道你现在很愤怒。”
- “我猜你现在可能会觉得很绝望。”

这类回应能让对方感到：

- 自己被理解；
 - 情绪被看见；
 - 不是孤立无援的。
-

4. 具体化 (concretization)

老师提出：要对对方保持**好奇**，并帮助其把问题说清楚。

例如：

- “你这两天看起来情绪很低落，是发生什么事情了吗？”
- “可以跟我讲一讲吗？”
- “你现在最难受的是什么？”

具体化的作用是：

- 澄清事件；
 - 澄清情绪；
 - 让问题更可被理解和处理。
-

5. 帮助寻找资源 (resources)

老师强调：

- 危机中的人常常只看到绝境；
- 旁人可以帮他看到资源。

这些资源可能包括：

- 同学；
 - 室友；
 - 老师；
 - 家人；
 - 学长学姐；
 - 制度性安排；
 - 现实中的替代方案。
-

6. 拓宽可能性 (expand possibilities)

老师反复强调一个核心思想：

- 到达罗马不止一条路；
- 当事人看不到的路，别人也许能看到。

可以通过：

- 多找几个人商量；
 - 头脑风暴；
 - 重新评估还有哪些出口。
-

7. 灌注希望 (instill hope)

老师认为，任何危机干预里都不能缺少“希望”。

核心观点包括：

- 不要轻易放弃自己；
- 山重水复疑无路，柳暗花明又一村；
- 任何时候都有对应时候的解决办法；
- 危机不是绝对死局，而是需要“见招拆招”。

【学习建议】老师这里延伸出一种对生活的态度：

- 不要过度追求一切都可控；
 - 接受未知；
 - 接受不确定性；
 - 用开放心态面对生活的意外；
 - 学会“见招拆招”，焦虑水平反而会下降。
-

二十九、什么时候做危机干预：不是越早越好

老师特别讲了危机干预的时机问题。

【举例：地震、火灾】

老师说：

- 危机事件刚发生时，最紧急的不是心理干预；
- 而是先满足生存和安全需要，例如：
 - 食物；
 - 水；
 - 帐篷；
 - 绷带；
 - 救援队；
 - 搜索与医疗支持。

因此：

- 心理援助/危机干预不是第一秒就上去做；
- 一般在事件发生后 **24~48 小时** 左右就可以开始介入；
- 一周后、一个月后也可以；
- 甚至一年后仍可能需要介入。

老师解释：

- 因为有些人会出现 **PTSD**；
 - 创伤反应不一定立即出现，
 - 可能延后很久才显现。
-

三十、危机/创伤干预的三个阶段

老师最后讲到心理创伤和心理危机干预的**三阶段模型**。

第一阶段：稳定化 (stabilization)

这是最先要做的。

目标是：

- 让一个人先安定下来；
- 建立安全感；
- 防止情绪完全崩溃。

老师提到，心理学里会用一些技巧帮助稳定，例如：

- 放松训练；
- 稳定化技术；
- 让恐惧记忆暂时被“放进保险箱”之类的意象技术。

老师特别强调：

- 在个体尚未稳定前，不能急着“拉开伤口”处理创伤；
 - 就像受伤先要**止血**，而不是马上深挖伤口。
-

第二阶段：创伤暴露与处理 (trauma exposure / processing)

当个体已有足够安全感和稳定度后，才可以：

- 非常温和地；
- 一点一点地；

- 慢慢接触和处理创伤内容。
- 老师强调：
- 创伤终究需要被处理；
- 但处理必须有时机、有节奏，不能粗暴推进。

第三阶段：重建意义 (meaning reconstruction)

老师指出：

- 创伤不只是“忘掉”就结束了；
 - 还需要被整合、被重新理解。
 - 也就是说：
 - 创伤确实会带来负面影响；
 - 但在整合过程中，也可能产生新的意义。
 - 【举例】老师提到疫情等重大公共事件，虽然是负性的，但也会促使人：
 - 重新思考生活；
 - 重新理解自己和世界；
 - 重新安排人生。
- 本段录音到此处结束，老师关于“重建意义”的展开应当还未完全讲完。

本节英文术语索引

- 心理危机 — psychological crisis
- 预防 — prevention
- 生物学因素 — biological factors
- 遗传因素 — genetic factors / hereditary factors
- 高敏感人群 — highly sensitive person / high sensitivity group
- 冲动性 — impulsivity
- 情绪调节 — emotion regulation
- 反刍性思维 — rumination
- 认知图式 — cognitive schema
- 完美主义 — perfectionism
- 自我批评 — self-criticism
- 焦虑 — anxiety
- 抑郁 / 抑郁症 — depression
- 自杀倾向 — suicidal tendency
- 应激事件 — stressful event
- 扳机点 — trigger
- 创伤 — trauma
- 依恋 — attachment
- 依恋创伤 — attachment trauma
- 重要抚养者 / 主要照顾者 — primary caregiver
- 安全感 — sense of security
- 基本信任 — basic trust
- 安全型依恋 — secure attachment
- 回避型依恋 — avoidant attachment
- 焦虑型依恋 — anxious attachment
- 抵抗型依恋 — resistant attachment
- 紊乱型依恋 — disorganized attachment
- 亲密关系 — intimate relationship
- 基本信任感 — basic trust
- 创伤后应激障碍 — Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
- 闪回 — flashback
- 心理咨询 — psychological counseling
- 危机干预 — crisis intervention
- 倾听 — listening
- 共情 — empathy
- 同情 — sympathy
- 情感反应 — emotional reflection
- 具体化 — concretization
- 资源 — resources
- 稳定化 — stabilization
- 创伤暴露 — trauma exposure
- 意义重建 — meaning reconstruction

如果你愿意，我下一步可以把这份笔记再压缩成一版适合期末背诵的“考前提纲版”。

第5讲：法律伦理、系统视角、树理论与自杀识别

一、上节课回顾与本节课导入

【复习】上节课主要讲了心理危机的预防（prevention of psychological crisis），老师回顾了影响心理危机产生的因素，包括：

- 生物学因素（biological factors）
- 心理因素（psychological factors）
- 后天创伤（trauma）
- 其他会影响个体心理危机形成的因素

本节课转入心理危机干预（psychological crisis intervention），重点讨论：当危机事件已经发生时，如何进行有效干预。

二、心理危机干预中的法律与伦理问题

老师首先强调：心理危机干预工作不是“想怎么做就怎么做”，而是始终受到：

- 法律（law）
 - 伦理（ethics）
- 的双重约束。

1. 保密原则不是绝对的

老师通过几个典型情境说明：心理咨询中的保密原则（confidentiality）并非在任何情况下都必须绝对遵守。

情境一：来访者明确表达自杀计划

如果一位同学告诉咨询老师：

- 自己已有明确的自杀计划（suicide plan）
 - 或经评估属于高自杀风险（suicide risk）
- 那么此时需要突破保密原则。原因是：
- 生命安全第一（safety first / life safety first）
 - 心理工作者首先要保证来访者有机会被保护、被帮助

此时通常会告知：

- 监护人（guardian）
- 临时监护人

老师特别说明，在学校环境中，同学们的临时监护人通常是：

- 辅导员
- 学院分管学生工作的副书记

而正式监护人通常是父母。

情境二：来访者表达伤害他人的计划

如果来访者明确告诉咨询老师，自己准备以某种方式对他人实施报复、危及对方生命安全，那么咨询老师同样需要突破保密原则，及时通知可能受害的人并采取保护措施。

情境三：涉及违法犯罪

如果来访者触犯法律，例如属于在逃人员，则咨询工作也必须受到法律条款约束，此时也可能需要突破保密。

情境四：未成年人正在遭受侵害

如果未成年人正在遭受：

- 家庭暴力（domestic violence）
 - 或其他危及人身安全的侵害
- 同样可能需要突破保密原则。

2. 心理咨询受哪些法律约束

老师提到，心理咨询与危机干预是在一个更大的法律框架下展开的，例如：

- 宪法
- 未成年人保护法
- 精神卫生法（Mental Health Law）

这些法律共同规定了咨询工作可以如何开展、能与哪些对象工作、在何种情况下必须采取行动。

3. 心理咨询还受到伦理守则约束

除法律外，咨询师还要遵循伦理守则（ethical code）。老师提到的重点包括：

(1) 信息保密

咨询师需要保护当事人的信息，哪怕在：

- 个案报告中
 - 课堂讲述案例时
- 也必须尽量隐去能够暴露身份的信息。

(2) 披露最小化

在必须突破保密原则时，也要做到：

- **最小披露 (minimal disclosure)**
- 只披露必要的信息
- 尽量保护当事人隐私

(3) 避免双重关系

老师特别解释了**双重关系 (dual relationship)**：

在中国文化中常有“找熟人好办事”的倾向，但心理咨询中通常**应避免和熟人建立咨询关系**。例如：

- 父母认识某位咨询师
- 便直接让孩子去找这位认识的咨询师

在专业伦理上通常并不合适，因为双重关系会影响咨询的边界与专业性。

三、危机干预的核心前提：生命安全第一

老师反复强调，心理危机干预最根本的原则是：

生命安全第一位

这也是为什么在必要时突破保密原则。

老师将其和医学生熟悉的职业使命作了类比：

- 医生强调**救死扶伤**
- 心理工作者同样强调**生命至上 (life first)**

因此，在来访者出现危机时，首要任务不是深层分析人格，而是先判断：

- 有没有生命危险
 - 危险等级多高
 - 是否需要立刻保护起来
-

四、从系统视角理解心理危机

【复习】老师再次回到上节课内容，指出心理危机不能只从个体内部去理解，不能简单归因为“这个人自己有问题”。

1. 个体因素只是其中一部分

个体层面的影响因素包括：

- 遗传因素 (genetic factors)
 - 气质特点 (temperament)
 - 神经冲动水平
 - 人格特质 (personality traits)
 - 当前遭遇的情境事件 (situational events)
-

2. 更大的社会与文化系统同样重要

老师强调，心理危机还受到更宏观系统的影响。

(1) 经济环境

经济环境的变化会显著影响个体和家庭的危机风险。

【举例】老师以疫情后部分行业受冲击为例，指出：

- 一些行业赚钱变难
- 某些从业者可能从原本经济条件很好，突然陷入破产或重大财务危机
- 对个人和家庭来说，这不仅是经济危机，也是心理危机

老师举到房地产行业的例子：行业在不同时期经历大起大落，对从业者造成巨大心理冲击。

（2）文化环境

不同文化背景下，人面对灾难后的恢复方式不同。

【举例】老师提到**斯里兰卡海啸（Sri Lanka tsunami）**后的现象：

- 一些欧美心理工作者到当地救援
- 但他们惊讶地发现，当地民众在彼此帮助的社会氛围中，恢复得很快

【举例】老师又提到**汶川地震（Wenchuan earthquake）**：

- 许多心理救援工作者进入灾区
- 但部分当地群众并不那么依赖专业心理援助
- 四川人民通过聚在一起打麻将等方式，反而慢慢恢复了秩序感与支持感

老师的解释是：

- **文化会影响人如何理解灾难、如何恢复、如何互相支持**
- 像打麻将这种活动，在心理学视角下不仅是娱乐，也有：
 - 团体合作
 - 相互支持
 - 重建秩序感

（3）中国传统文化的影响

老师认为，中国传统文化中有许多与心理韧性有关的智慧，例如：

- 中庸
- 辩证看待问题
- “塞翁失马，焉知非福”

这些文化资源会影响人们如何理解人生轨迹、如何应对灾难与变化。

3. 家庭与成长环境的重要性

老师强调：

家庭和成长环境对人的影响极大

并提出一个核心观点：

- 家庭是一个人的“**根**”
- 很多性格、创伤、应对方式，存在**代际传递（intergenerational transmission）**
 - 也就是说：
- 一代影响一代
- 某些创伤与性格模式，会在家族中不断重复

4. 成长环境塑造社交能力与人格

老师指出，不同成长环境对人格塑造差异很大。例如：

- 多子女家庭 vs 独自成长
- 农村/人口密集、邻里互动多的环境 vs 城市中邻里关系淡薄的环境
- 从小社交训练多 vs 社交训练匮乏

老师借此解释为何现在很多同学会觉得自己“不会社交”：

- 并不一定只是个人能力差
- 很可能和成长环境中缺乏社交训练有关

5. 每一代人所处的大时代不同，心理议题也不同

老师引导大家从代际角度看问题：

- 祖辈可能经历过战争、饥荒，因此更节俭
- 父母一代经历改革开放，更强调“知识改变命运”
- 当代年轻人物质相对不匮乏，但可能更常感到：
 - 缺少玩伴
 - 缺少理解
 - 竞争激烈
 - 未来不确定

因此，每一代人面临的心理冲突并不相同。

6. 人是“系统中的人”

老师总结：

一个人出现心理问题或心理危机，绝不是只看他自己。

要把人放回完整系统中理解，包括：

- 大的社会环境
 - 家庭
 - 学校
 - 社区
 - 亲朋好友
 - 个体的生理与心理因素
 - 所经历的事件
-

7. 心理危机干预也必须是系统性的

危机干预不能只干预个人，而要同时考虑：

- 个体解决问题的能力
- 个体看待世界与看待自己的方式
- 家庭系统
- 学校系统
- 社区支持
- 辅导员、老师、周围同学等资源

老师提到，心理工作中常会使用：

- **家庭治疗（family therapy）**

正是因为干预常常需要进入系统层面，而不是只盯着一个人。

五、心理危机的“树理论”

老师接下来讲到一个非常重要的比喻：**树理论**。原转写中“数理论”应为“**树理论**”。

1. 根：家庭与依恋关系

老师认为，一个人想成长得好，首先要有发达的“根系”。

这里的“根”在心理学上主要指：

- **家庭（family）**
- **依恋关系（attachment / attachment relationship）**

意义在于：

- 人生一定会有风吹雨打
- 如果有稳固的家庭和依恋关系
- 遭遇挫折时，知道背后有人托举自己
- 知道有避风港和爱的港湾

这能带来：

- 对自己和他人的基础信任感（basic trust）
-

2. 树干：信仰、价值观、社会支持

树要长得好，还需要粗壮的树干。

老师把树干对应为：

- **信仰（belief / faith）**
- **价值观（values）**
- **社会支持（social support）**

（1）信仰

老师提醒大家思考：

- 你是否真正相信自己在做的事
- 你是否相信学习能给你带来意义和幸福

如果没有信仰，就容易动摇、容易被外界影响。

（2）价值观

不同的价值观会影响一个人面对困难时的应对方式。例如：

- 想让世界变得更好
- 想为自己而活

这些都是价值观。

(3) 社会支持

社会支持包括：

- 朋友
- 家人
- 老师
- 亲朋好友
- 困难时可以求助的人

老师引用一句中国话说明社会支持的重要性：

平时肯帮人，急时有人帮。

3. 枝叶与外部环境：社会环境也决定成长状态

一棵树能否枝繁叶茂，还取决于它长在什么环境里：

- 是在阳光、水分、土壤充足的地方
- 还是在悬崖缝隙中、资源稀缺的地方

同样，一个人的发展也受到外部社会环境的影响，例如：

- 国家政策
- 行业发展
- 经济背景
- 社会机遇

【举例】老师再次以改革开放后的社会机会为例，说明：

- 有些人的发展并不只是个人努力，也与时代机会密切相关
-

4. 树理论与危机承受力

老师用树理论解释危机的后果：

如果一个人拥有：

- 发达的根系
- 粗壮的树干
- 较好的外部环境

那么即使遭遇“狂风暴雨”般的危机，也可能只是：

- 折断一些枝条
- 掉落一些叶子

但整棵树仍能活下来，并继续生长。

如果一个人缺乏：

- 家庭支持
- 稳定依恋
- 信仰与意义感
- 社会支持

那么一场危机就可能动摇他的生存根基。

【举例】老师举到求职失败的情境：如果一个人没有信仰、没有支持系统、家庭关系也差，那么“找不到工作”不只是现实挫折，还会立刻演变成：

- 我活着的意义是什么？
- 没有人会帮助我
- 我不能信任任何人

这就是危机迅速加深的过程。

六、危机干预的三个阶段

在树理论之后，老师顺势讲到危机干预的三个阶段。

1. 第一阶段：危机评估 (crisis assessment)

首先要评估：

- 自杀风险
- 攻击他人的风险

老师强调，不同风险等级差异很大：

- 只有一闪而过的自杀念头

- 已经形成明确计划
 - 已购买工具
 - 已踩点准备实施
- 这些不是一回事。
-

2. 第二阶段：行动干预 (action intervention)

如果风险已经较高，例如已经有明确自杀计划，就必须立即采取现实层面的保护行动，例如：

- 突破保密原则
 - 通知父母
 - 让辅导员或其他人员进行 24 小时看护
 - 先把人保护起来
-

3. 第三阶段：心理干预与后续心理治疗

(1) 心理干预

心理干预的直接目标是：

- **稳定情绪 (stabilization)**
- **处理当前问题**
- **帮助问题解决**

【举例】老师举了“研究生选导师落空”的例子：

- 原以为导师会收自己
- 但政策变化，导师能带的人数减少
- 导致该同学研究生阶段安排受阻，产生危机

此时心理干预要做的，就是帮助当事人讨论还有哪些替代路径和现实解决方案。

(2) 后续心理治疗 (psychotherapy)

如果危机已经解除，后续咨询工作的重点就转向：

- 帮助来访者成长
 - 发展应对技巧 (coping skills)
 - 为今后遇到类似情景做准备
-

七、什么是危机，以及危机常见反应

老师给出危机的定义：

危机是人在紧急状态下，原有心理平衡被打破，继而出现情感、认知、行为等功能失调。

1. 认知反应 (cognitive reactions)

危机中的常见认知表现包括：

- 否认 (denial)
- 注意力不集中
- 危机场景反复再现
- 失去信心
- 内疚自责
- 丧失安全感

老师特别强调：危机中的人，最突出的认知特点是：

认知变窄 (narrowed cognition)

也就是：

- 眼里只有问题和困难
- 看不到其他可能性、资源和希望

【举例】例如重大疾病或绝症诊断刚出现时，人的第一反应常常是否认：

- 是不是搞错了？
 - 怎么会发生在我身上？
-

2. 情感/情绪反应 (emotional reactions)

常见情绪表现包括：

- 混乱
- 害怕
- 恐惧
- 沮丧
- 麻木
- 怀疑
- 悲伤
- 绝望
- 无助
- 羞耻
- 易怒
- 情绪难以平静
- 情绪失调

老师以地震、火灾等情景说明，人会明显体验到：

- 环境失控
 - 内在失控
 - 对危险的强烈反应
-

3. 行为反应 (behavioral reactions)

危机中的行为表现可能有：

- 攻击
- 社交退缩
- 逃避
- 食欲异常
- 哭泣
- 饮酒增加
- 药物使用增加
- 坐立不安
- 过度警觉 (hypervigilance)

老师强调：危机中的行为特点常表现为：

- 反常
- 易失控

【临床关联】老师举了父亲脑梗后的变化：

- 不愿意见人
- 容易易怒

说明疾病本身也可能构成一个人的心理危机。

老师提醒大家，将来进入医院后面对重病患者时，也应理解：

- 这些情绪和行为往往是正常危机反应的一部分
-

八、危机干预的基本原则

老师总结了几条危机干预的原则：

1. 保障安全

首要目的是保证被干预者的人身安全。

2. 聚焦问题

危机干预主要聚焦于：

- 当前的情绪冲突
- 当前的问题解决
- 当前的情绪调节困难

而不是去深挖人格深层问题。

3. 激活资源 (resource activation)

危机干预要帮助来访者看见并调动：

- 自身资源
- 家庭资源
- 学校资源
- 社交资源

老师再次强调：

危机既是危险，也是机会。

“机会”在于：如果一个人走过危机，他会习得新的能力，例如：

- 生存技能
- 应对挫折的能力
- 自我重新定义的能力
- 社交求助能力

【举例】老师提到：

- 有的同学以前在高中一直是佼佼者
- 进入大学后学习优势消失
- 自我价值严重受挫

这时危机的意义在于：要学会重新审视自己——除了学习，我还有什么价值？

【举例】老师还提到研究生与导师相处的问题，说明危机也可能倒逼一个人学习：

- 主动沟通
 - 求助
 - 寻找资源
 - 发展社交能力
-

九、后半节：危机干预前的准备与工作状态

第二个片段开始，老师进一步讲危机干预的流程。

1. 干预前必须有充分准备

老师把危机干预类比为外科手术：

- 外科医生上手术台前需要做好身心准备
- 危机干预者同样需要进入专业状态

要求包括：

- 心理上准备充分
 - 生理状态到位
 - 能把注意力真正放在当事人身上
 - 而不是被自己当天的私人事务占据
-

2. 危机干预必须依靠团队

老师再次强调：

心理危机干预不是一个人能完成的

需要团队合作，例如在学校场景中，需要：

- 心理健康老师
 - 辅导员
 - 任课老师
 - 班主任
 - 父母
 - 其他支持者
-

3. 干预者要保持松弛而稳定的状态

面对一个说“我没有活下去勇气、想结束生命”的人，干预者自己也会紧张、害怕、担心。但老师强调：

- 不能先被吓倒
 - 要能陪在这个人身边
 - 当事人能感受到你的状态
-

4. 干预中的态度要求

老师强调危机干预者应具备：

- 真诚（genuineness）
- 关心（care）
- 热爱/善意
- 温和而坚定（gentle but firm）
- 专业高效

- 依法依规
尤其重要的是：
你关心的是“这个人好不好”，而不是只关心他的行为是否符合社会规范。
-

十、人的基本需要与危机的关系

老师接着从人的需要谈危机形成机制，提到**马斯洛需要层次理论**（Maslow's hierarchy of needs）。

人有许多基本需要，包括：

- 生理需要（physiological needs）
 - 安全需要（safety needs）
 - 尊重需要（esteem needs）
 - 自我实现需要（self-actualization）
- 当某些重要需要长期得不到满足时，人就容易产生心理痛苦。
-

1. 关系的需要（need for relationship）

老师认为：

- 人需要建立关系
 - 如果在环境中无法建立关系，就容易出问题
【举例】大学宿舍、班级环境里能否建立关系非常重要。如果一个人长期：
 - 独来独往
 - 感到孤立无援
 - 感受不到支持、认可、帮助就更容易陷入无助。
-

2. 自尊的需要（need for self-esteem）

每个人都希望被尊重。老师举到学校资助工作的例子：

【举例】如果对经济困难学生的支持能够通过大数据识别、无声无息地给予，而不必让学生反复公开申请、暴露贫困身份，这本身就是一种尊重。

老师还讲到社交和教育中的具体技巧：

- 表扬尽量在人前
 - 批评尽量一对一、私下进行
- 将来无论是：
- 为人父母
 - 做老师
 - 与人交往
- 都应注意这一点，因为每个人都有“面子”和尊严需求。
-

3. 安全感的需要（need for security）

安全感既来自外部，也来自内部。

外部包括：

- 社会是否稳定
- 是否有战争
- 环境是否可预期

内部则包括：

- 我能否通过努力达到想要的生活状态
- 我是否对未来有掌控感

老师指出，很多同学之所以特别努力，某种程度上也是在争取自己的安全感。

4. 亲密关系的需要（need for intimacy）

即便有些人嘴上说不需要恋爱、不需要结婚，但从人的心理深处看，大多数人都仍然渴望：

- 亲密感
 - 被走近
 - 被理解
 - 被连接
-

5. 成就感与自我认同 (achievement and self-identity)

老师强调：

- 每个人都需要在某个方面感到“我能做成点事”
- 每个人的自我认同方式不同

例如：

- 学习好
- 口才好
- 社交强
- 钢琴弹得好

因此，自我价值不能只压缩在一个非常狭窄的维度里。

6. 情绪与感受幸福的能力

老师讲到一个重要观点：

- 有些人更容易感受到快乐
- 有些人即便客观上已很成功，也感受不到意义

【举例】老师讲了一个案例：一个已经“在别人眼里很有成就”的人，却非常不快乐，甚至觉得活着没有意义。后来有人建议他：

- 给街头乞讨者、吃不上饭的人送盒饭

结果他持续做这件事后，逐渐感到自己的人生重新有了意义，甚至后来还组织更多人去灾区送饭。

老师借此说明：

真正持久地让人快乐的，不一定是功成名就，而是做自己觉得有意义、有价值的事。

十一、不同需要受挫后的心理表现

老师接着从不同心理需要受挫的角度，分析危机的表现。

1. 关系受挫

例如被抛弃后，可能遭受强烈心理冲击。成年后可能会拼命寻找“不被抛弃的关系”。

2. 自尊受挫

如果一个人自尊很脆弱，被老师当众批评，可能立刻陷入强烈羞耻感，甚至转而攻击对方。

3. 安全感不足

安全感低的人，容易长期焦虑，通过不停做事来获得控制感。老师提到这类人可能表现为“工作狂 (workaholic)”。

4. 亲密关系不足

容易体验到孤独，严重时感到这个世界没人支持自己，从而出现绝望。

5. 成就感受挫

权力、掌控、成就受挫时，也可能带来强烈内在挣扎。

6. 自我认同受挫

容易陷入迷茫，不知道自己是谁、价值何在。

7. 针对不同受挫类型的干预方向

老师概括提到：

- 对关系受挫者：帮助其在关系中获得安全感、稳定关系
 - 对自尊受挫者：处理羞耻感 (shame)
 - 对缺乏尊重者：深入共情、给予安全与抱持 (holding)
 - 对焦虑和缺乏安全感者：容纳其焦虑
 - 对特别需要权力和控制者：赋权 (empowerment)、理解、稳定关系
- 老师也提示，这些原则比较概括，大家一时未必都能完全理解。
-

十二、危机干预的具体步骤

老师再次把危机干预归纳为三个步骤：

1. 明确问题和目标

先弄清问题是什么、目标是什么，不能在问题未明时就开始盲目干预。

老师特别提醒：

- 学业问题往往只是表层问题
 - 更深层可能是自我价值、自我人生意义受到挑战
 - 亲密关系破裂也不只是“分手”本身，而常激活被抛弃感等更深层需求
-

2. 快速而准确地评估 (rapid and accurate assessment)

评估贯穿干预全过程，尤其包括：

- 自杀风险
- 自伤风险
- 攻击他人风险
- 现实压力
- 支持资源
- 是否存在临床诊断

老师举到风险评估中可能会参考的因素：

- 自杀计划高低
 - 既往是否有自杀史
 - 次数、频率
 - 现实压力程度
 - 资源多少
 - 是否有抑郁症、精神分裂症、躁狂、双相情感障碍等诊断
-

3. 给予希望与问题解决

危机中的人认知狭窄，容易认为：

- 没路可走了
- 只能这样了

因此干预者要做的是：

- 帮助其看见被忽略的其他路径
- 扩展人生选择视野
- 发现周围资源
- 一步一步找到问题解决方法

老师还提到有时会签订：

• 不伤害协议 (no-harm agreement / safety contract)

即要求当事人承诺：

- 不实施自伤/自杀行为
 - 若出现冲动，先联系咨询师或院系老师
-

十三、危机干预中的安全措施

老师反复强调，整个干预前后都必须：

- 持续评估风险
- 足够重视安全问题
- 制定行动策略

对于有自杀风险的人，要尽可能使其远离：

- 药品
- 刀具
- 其他危险器械
- 危险地点

必要时：

- 实施监护
- 在法律允许范围内送医治疗

【举例】如果学生已经购买了可能危及生命的药品、器械，就应让他人暂时代为保管，使工具变得“不可获得”。

十四、建立关系：危机干预有效的前提

老师特别强调，危机干预能否有效，第一步不是技巧，而是：

关系 (therapeutic relationship)

来访者必须感到：

- 你愿意听
- 你真诚接纳
- 你尊重他
- 你能理解他的核心困难

如果当事人根本不相信你，那后续干预就很难真正有效。

十五、学校心理健康资源与心理咨询的意义

接近课程后段时，老师开始介绍学校资源。

1. 课程资源

学校里获取心理学知识的便捷方式包括：

- 《大学生心理健康》
- 《心理危机干预》
- 《压力与健康》
- 其他相关通识课程

老师认为，这类课程是最简单快捷的心理学知识入口。

2. 心理社团与活动资源

如果参加心理社团，也有机会更近距离接触：

- 心理活动
 - 学校心理健康资源
-

3. 心理咨询的作用：像一根拐杖

老师用一个非常形象的比喻说明心理咨询 (psychological counseling)：

心理咨询就像人生中的一根拐杖。

意思是：

- 每个人在人生路上都可能“崴脚”“摔跟头”
 - 当自己暂时走不动时，需要一个外在支撑
 - 在支撑下，人一边往前走，一边慢慢恢复
- 当伤好了，拐杖就可以放下。
-

4. 心理咨询不是“立竿见影”的药

老师提醒大家不要对心理咨询抱有不切实际的期待：

- 不是一次咨询就能解决多年积累的问题
- 不是像吃感冒药一样立刻见效
- 它是一个缓慢渗透的过程

它的作用在于：

- 帮助你更全面、深刻地理解自己
 - 看见既往经历如何塑造了现在的自己
 - 调整思维方式
 - 逐渐把新理念、新方法渗透到生活、学习、工作中
-

十六、自杀识别：课程最后的重要补充

老师说，这部分在危机干预中非常重要，因为：

- 自杀相关问题风险等级最高
 - 是咨询老师经常处理的重点内容
-

1. 自杀的语言征兆 (verbal warning signs)

如果一个人经常说：

- 我不想活了
- 活着特别没劲
- 太累了
- 活着没有意义

这些都不是随便说说，而是重要的**求助信号 (help-seeking signal / SOS)**，需要高度警觉。

老师特别强调：

- 很多自杀成功案例，在事后回看时，前期其实有很多可以被识别、被救援的机会
 - 只是周围人没有意识到严重性
-

2. 自杀的行为征兆 (behavioral warning signs)

老师提到的行为信号包括：

- 频繁搜索与自杀相关的信息
- 浏览自杀相关网站
- 搜索致命方式
- 准备自杀工具
- 进行踩点
- 物品整理与分发
- 出现道别、告别行为

【举例】如果一个人开始把自己珍视的东西分给别人，并说“以后我也用不着了”，这就是很危险的信号。

3. 自杀过程中的情绪变化

老师指出，自杀风险并不是“越激动越危险”，真正要警惕的是一个阶段性的变化：

前期：

- 易怒
- 烦躁
- 情绪剧烈波动

后期：

- 突然进入“冷静期”
这个“冷静期”非常危险，因为这往往意味着：
 - 当事人已经做了决定
 - 不再纠结
 - 风险反而升高
- 老师特别提醒大家：

不要误以为“突然冷静下来”就是好了。

4. 社交媒体与失联信号

老师提到，一些外在线索也要引起警觉，例如：

- 朋友圈背景或内容突然全部变黑
- 发布异常字眼
- 明显失联

这些都可能是危险信号。

十七、关于自杀的几个常见误解

1. 误解一：有过自杀尝试的人，之后风险会降低

老师明确指出：**错。**

既往有自杀史 (history of suicide attempt) 的人，之后的自杀风险反而**更高**。原因是：

- 既往尝试让其获得了某种“自杀能力”
 - 包括对死亡、疼痛的恐惧降低
-

2. 误解二：和有自杀风险的人谈论自杀，会诱发他去做

老师明确指出：**通常不是这样。**

如果你是以一种：

- 真正关心他
- 很在意他生命安全
- 严肃而真诚

的态度去讨论，他反而可能会感到：

- 如释重负
- 终于可以把无法说出口的压力讲出来

老师认为，这样的讨论常常有助于减轻其内在包袱，而不是增加风险。

3. 误解三：说“我不想活了”的人只是说说而已

老师明确反对这种看法。

她认为，这通常是一个：

- **SOS 求救信号**
 - 说明此人至少已经认真考虑过这件事
 - 也可能正在观察：周围是否有人愿意帮助自己
- 因此，周围人的态度至关重要。
-

十八、普通同学遇到有自杀倾向的人时该怎么做

老师最后专门讲了“非专业人员能做什么”。

1. 不要承诺保密

这是老师反复强调的重点。

如果对方说：

- 我很信任你
- 但你一定要替我保密

这时不能答应。老师提醒：

- 一旦你承诺保密，而对方后来真的实施了严重行为
- 你可能会背负长期的内疚与自责

更合适的说法是：

- 我非常担心你
 - 我非常在意你
 - 正因为我不希望失去你，所以我不能答应完全保密
 - 我需要让更多人参与进来，先保证你的安全
-

2. 立刻调动身边资源

老师强调，不要一个人硬扛。普通同学做不到：

- 24 小时盯护
- 独自承担全部风险

因此要第一时间告诉：

- **辅导员**
- 必要时由老师进一步通知：
 - 家长
 - 学校心理健康教育中心
 - 宿舍同学
 - 好朋友
 - 男女朋友
 - 其他支持者

核心原则是：

先救人，先让他活下来

活下来，才有后续帮助的可能。

3. 后续可能的走向

老师指出，危机之后不一定都要长期心理咨询：

- 有些同学是“一过性”的，危机过去就好了
 - 有些同学则需要长期跟进、持续支持、心理帮扶
- 这取决于问题性质、人格基础和支持情况。

十九、老师对“危机”的总体态度

课程最后，老师再次总结自己对危机的看法：

1. 危机是危险

因为它是人生的一道坎，可能直接威胁安全。

2. 危机也是机会

如果一个人顺利走过危机，他常常会获得：

- 更强的问题解决能力
- 对自我的重新定义
- 更深的自我觉察（self-awareness）
- 更成熟的应对方式

【举例】老师再次回到前面“送饭后重新找到生命意义”的案例，说明：

- 危机可能迫使一个人重新寻找生命意义
- 重新建立和世界、和他人的连接

因此，老师鼓励大家：

- 不要只用悲观态度看待危机
- 要看到其中“学习与成长”的可能性

二十、课堂结尾与随堂任务

【课堂说明】老师最后提醒：

- 本节课内容到此结束
- 有一个**随堂测试**
- 截止时间为**今晚 12 点**
- 需要在**雨课堂**完成
- 题目数量为**5 道**

本节英文术语索引

- 心理危机 —— psychological crisis
- 心理危机预防 —— prevention of psychological crisis
- 心理危机干预 —— psychological crisis intervention
- 法律 —— law
- 伦理 —— ethics
- 保密原则 —— confidentiality
- 保密例外 / 突破保密 —— breach of confidentiality / exception to confidentiality
- 最小披露 —— minimal disclosure
- 双重关系 —— dual relationship
- 监护人 —— guardian
- 生命安全第一 —— safety first / life safety first
- 生物学因素 —— biological factors
- 心理因素 —— psychological factors
- 创伤 —— trauma
- 家庭治疗 —— family therapy
- 依恋 / 依恋关系 —— attachment / attachment relationship
- 社会支持 —— social support
- 信仰 —— belief / faith
- 价值观 —— values
- 危机评估 —— crisis assessment
- 自杀风险 —— suicide risk
- 自杀计划 —— suicide plan
- 行动干预 —— action intervention
- 心理治疗 —— psychotherapy

- 认知反应 —— cognitive reactions
- 情绪反应 —— emotional reactions
- 行为反应 —— behavioral reactions
- 否认 —— denial
- 过度警觉 —— hypervigilance
- 资源激活 —— resource activation
- 应对技巧 —— coping skills
- 马斯洛需要层次理论 —— Maslow's hierarchy of needs
- 生理需要 —— physiological needs
- 安全需要 —— safety needs
- 尊重需要 —— esteem needs
- 自我实现需要 —— self-actualization
- 自尊 —— self-esteem
- 亲密关系 —— intimacy / intimate relationship
- 自我认同 —— self-identity
- 羞耻感 —— shame
- 抱持 —— holding
- 赋权 —— empowerment
- 不伤害协议 —— no-harm agreement / safety contract
- 治疗关系 / 咨询关系 —— therapeutic relationship
- 心理咨询 —— psychological counseling
- 求助信号 —— help-seeking signal / SOS
- 自杀尝试史 —— history of suicide attempt
- 自我觉察 —— self-awareness
- 双相情感障碍 —— bipolar disorder
- 精神分裂症 —— schizophrenia
- 躁狂 —— mania
- 家庭暴力 —— domestic violence

你要是愿意，我下一条可以继续把这份笔记再压缩成一版“考试复习提纲版”，专门提炼成更适合临考背诵的版本。

第6讲：学生心理危机三级预防

课程：心理危机干预与预防 老师：毛富强 日期：2026-04-07

一、课前说明与本节导入

- 老师先说明：这次上课通知存在混乱，课表与现场通知不一致，因此**本次不点名**，但仍按教学任务继续讲课。
- 老师提到，单讲抽象理论往往“不容易抓住要领”，因此本节改用**案例分析**的方式来讲**学生心理危机（psychological crisis in students）**。
- 老师说明案例选择的原因：
 - 身边学校的真实案例通常涉及保密，不能直接讲。
 - 因此只能讲已经被网络公开、社会高度关注的案例。
- 老师强调：**不同个体、不同事件背后的心理学原因，往往具有相似性**，所以个案分析有助于理解一般规律。

二、案例引入：胡鑫宇事件的基本经过

【案例】本节以**胡鑫宇事件**为例分析学生心理危机。

- 胡鑫宇，江西省上饶市铅山县致远中学高一男生。
- 老师用“阳光大男孩”来形容其外在形象，指出这类学生放在日常校园环境中“并不违和”，因此**心理危机并不总是从外表上能看出来**。
- 事件时间线：
 - 2022年9月1日入学。
 - 入学一个多月后，10月14日在校内失踪。
- 学校背景：
 - 为寄宿制学校。
 - 校内有教学楼、围墙、小山包、人工湖等区域。
 - 监控并非全覆盖，只覆盖部分楼道、教室、食堂等区域。
- 失踪前最后轨迹：
 - 监控显示其在17:49仍出现在宿舍门口。
 - 18:00应上晚自习，但没有到教室。
- 班主任发现其未到课后，及时向学校报告；学校组织校内寻找，但未找到。
- 当晚约23:00，班主任联系家长，告知孩子失踪。

三、家属介入、学校搜索与网络舆情发酵

- 胡鑫宇母亲次日早晨赶到学校，在宿舍中发现线索：
 - 家里此前为其购买过**录音笔（voice recorder）**，原本用于学英语；
 - 这支录音笔后来被发现不在原处。
- 学校扩大搜索范围：
 - 地下室、阁楼、水池、人工湖、化粪池等区域都进行了寻找。
- 之后报警，警方介入，通过走访与调取监控展开调查，但初期仍无结果。
- 家属随后开始在网络上持续发声，悬赏寻人金额从**10万**不断增加，最终到**50万**。
- 随着时间推移，网络上出现大量谣言，包括但不限于：
 - 被藏于车辆中带离学校；
 - 被人抽血、贩卖器官；
 - 被教师杀害并处理尸体；
 - 校内曾发生多起类似失踪事件等。
- 老师强调：**事后证明上述传言大多为谣言**，其中有人借机蹭热度、博眼球，造成了恶劣社会影响。
【提示】这里老师实际上借案例提醒：
 - 心理危机事件不仅有个体层面的伤害，
 - 还会伴随**舆论失真、社会恐慌、次生伤害**等问题。

四、案件结果：警方结论与录音证据

- 失踪两个多月后，2023年1月28日，有人报警称在树林中发现一具尸体。
- 经**DNA（deoxyribonucleic acid）**比对确认，死者即为胡鑫宇。
- 现场还发现了重要物证：**录音笔**。
- 该录音笔被送往专业机构进行**声音鉴定（voice identification / forensic audio analysis）**与音频恢复。
- 公安部门最终公布结论：
 - 胡鑫宇系**自缢身亡（death by suicide by hanging）**；
 - 现场为**第一现场（primary scene）**；
 - 无搏斗、拖拽痕迹；
 - 录音内容未被剪辑、未被篡改。
- 录音时间覆盖**2022年10月14日17:40至23:08**之间的多个时段。

- 其中有两段录音较清晰地表达了**自杀意愿（suicidal intent）**。
- 老师据此归纳：胡鑫宇在失踪前已做出明确的自杀准备，并在临死前经历了较长时间的犹豫与挣扎。

五、案例的心理学分析：胡鑫宇身上的危险特征

1. 性格特征：典型内向、孤僻、压抑

【考点】老师明确把“内向性格”视为该案例的重要风险因素。

- 胡鑫宇被描述为**典型内向型人格（introverted personality）**：
 - 有事不愿交流；
 - 不愿倾诉；
 - 不会主动求助；
 - 更倾向于“自己憋着”。
- 老师认为，这类学生表面看“不显山不露水”，但**风险在于外界不容易及时发现其内心危机**。
- 其情绪宣泄方式较为隐蔽，只能在作业本边角写一些文字表达情绪。

2. 对新环境的不适应

【复习】老师借此回到心理危机发生机制：**环境变化 + 个体脆弱特征**容易触发危机。

- 胡鑫宇在作业本上写过类似内容，反映：
 - 对新环境难以适应；
 - 对自己内向的性格感到烦恼；
 - 只能通过写字来缓解情绪。
- 老师由此判断：
 - 他在进入高中后，对**学习环境、人际关系**等均不适应；
 - 性格特点加重了这种不适应。

3. 睡眠与节律问题

【考点】老师把**睡眠障碍（sleep disturbance）**列为判断其抑郁状态的重要证据之一。

- 胡鑫宇写到：
 - 早晨很早醒来；
 - 醒来后又躺着，不敢起床，怕影响别人。
- 老师由此分析：
 - 已出现**早醒（early morning awakening）**；
 - 也存在**入睡困难（difficulty falling asleep / insomnia）**；
 - 形成**节律紊乱（circadian rhythm disturbance）**。
- 睡眠问题会进一步影响：
 - 白天清醒度；
 - 上课状态；
 - 学习效率。

4. 对学习成就的高期待与现实落差

- 胡鑫宇原本中考成绩较好，并获得学校**1500元奖学金**入学。
- 家庭和本人都对其高中阶段抱有较高期待，希望通过努力考上重点大学。
- 但入学后因各种不适应因素，学习状态明显下降。
- 老师认为，这种“**高期待—低适应—高挫败**”的落差，是其心理危机加剧的重要背景。

六、老师对其“重度抑郁”判断的六条依据

【考点】老师明确提出：胡鑫宇在自杀前已表现出**重度抑郁（major depression / severe depressive state）**的特征。

(1) 严重睡眠障碍

- 入睡困难；
- 早醒；
- 昼夜节律被破坏。

(2) 学习功能受损

- **注意力不集中（inattention）**；
- **记忆力下降（memory decline）**；
- **思维迟钝（slowed thinking）**；
- 理解力下降；
- 白天上课“听不进去”。

(3) 明显社交障碍

- 自卑；
- 在意他人评价；
- 害怕被嫌弃；

- 采取**回避（avoidance）**策略；
- 越回避越孤独，越孤独越回避，形成恶性循环。

(4) 负性认知与自我评价下降

- 出现明显的**自责（self-blame）**；
- **自我否定（self-denial）**；
- 觉得自己性格不行、学习能力不行、未来“没戏了”。
- 老师强调：负性认知越强，情绪越低落；情绪越低落，又会进一步强化负性认知。

(5) 心身症状

- 出现**厌食（loss of appetite / anorexia）**；
- **呕吐（vomiting）**；
- 老师将其视为抑郁相关的心身症状（**psychosomatic symptoms**）表现。

(6) 持续情绪低落与轻生念头

- 经常在无人时独自哭泣；
- 已出现“活着没意思”等想法；
- 说明已存在明确的**轻生观念（suicidal ideation）**。

【结论】老师认为：上述六条足以支持“胡鑫宇在自杀前已陷入严重抑郁状态”的判断。

七、谁本可以帮助他：家长、老师、同学与本人

老师接下来围绕“胡鑫宇能不能不死”展开讨论，重点不是追责本身，而是从中提炼**危机干预（crisis intervention）**与**预防（prevention）**的启示。

八、家长层面的责任与失误

【考点】老师认为：**家长是未成年学生心理危机中的第一道防线。**

- 胡鑫宇曾多次向家中求助，尤其多次联系母亲。
- **9月27日**，一天内与母亲通话三次，核心诉求是：
 - 想回家；
 - 学不进去；
 - 想休息一段时间。
- **10月5日**，又连续与母亲通话三次，总时长近40分钟，仍在表达：
 - 压力太大；
 - 希望回家休息；
 - 甚至提出休学、退学。
- 老师指出：
 - 母亲并未把这些求助理解为心理危机信号；
 - 而是将其理解为“娇气”“意志不坚定”。
- 老师进一步分析，母亲拒绝孩子回家的原因包括：
 1. **经济因素**：家庭经济紧张，休学意味着额外成本；
 2. **期待压力**：全家把“改变命运”的希望寄托在孩子身上；
 3. **学校光环**：认为进入“好学校”就意味着必须坚持到底，不能退出。
- 老师的核心判断是：
 - 家长缺乏心理危机识别知识；
 - 在孩子明确求助时未能提供支持；
 - 若当时能带孩子就医、休息、接受治疗，结局可能不同。
- 【学习建议】老师借此提醒：
 - 当青少年连续、多次、情绪明显地表达“撑不住了”“想回家”“学不进去”时，不能只按“娇气”处理；
 - 应把它当作**危机求助信号（help-seeking signal）**看待。

九、老师层面的责任与失误

【考点】寄宿制学校中的老师，某种程度上承担了**代行监护（in loco parentis）**的职责。

- 老师指出，学校教师的关注点往往被成绩、升学率、刷题压力占据。
- 对于胡鑫宇，班主任虽曾找他谈话，但重点放在：
 - 成绩下滑；
 - 排名下降；
 - 学习状态不对。
- 而没有真正深入关心：
 - 他为什么难受；

- 他是否存在情绪问题；
 - 他是否需要帮助。
 - 有教师甚至曾劝其“转学”，这可能进一步加重其挫败感与排斥感。
 - 老师特别提到：
 - 胡鑫宇在**10月10日至13日**之间，曾**7次**到宿舍楼三楼阳台“踩点”；
 - 但这些异常行为没有引起足够警觉。
 - 老师据此认为，这是学校在危机识别方面的明显缺失。
【易错】只关注成绩，不关注状态，是学校心理危机管理中的典型误区。
-

十、同学层面的责任与失误

- 胡鑫宇在生前最后几天也曾向同学表达痛苦。
 - 但同学们大多处于“自顾不暇”的学习状态，没有足够耐心或能力去承接这些信息。
 - 他生前有很多异常表现，例如：
 - 最后一天在教室坐了一整天；
 - 几乎不抬头；
 - 书也没有打开。
 - 但这些异常并未引起同伴、老师的有效反应。
 - 老师强调：
 - 只要其中某位同学、老师及时上报、反馈、干预，都可能改变结局。
 - 因此同伴系统也是学生危机预防中的重要环节。
-

十一、本人层面的因素：退避型应对与缺乏主动求助

【考点】老师认为，个体自身的**应对方式（coping style）**也是危机发展的关键因素。

- 胡鑫宇在面对压力时，采用的是**退避（avoidant coping）**方式：
 - 回避问题；
 - 假装没事；
 - 不愿麻烦别人；
 - 缺乏主动求医和主动求助。
 - 老师指出：
 - 他其实有手机；
 - 理论上仍存在对外求助的机会；
 - 但他最终没有把求助真正推进到行动层面。
 - 老师借此说明：
 - 个体不是完全被动的；
 - 每个人都需要学习在危机中主动寻求帮助。
- 【学习建议】不要把“不给别人添麻烦”当成美德。
- 在心理危机中，**主动求助（help-seeking）**本身就是一种能力。
-

十二、由案例引出的生命意义教育

【学习建议】老师由此转向“生命意义（meaning of life）”教育。

- 老师认为，我们从小较少被系统地教育“人为什么活着”。
 - 常见的单一逻辑是：
 - 学习为了成绩，
 - 成绩为了大学，
 - 大学为了工作，
 - 但最终“活着为了什么”反而不清楚。
 - 老师提到社会上对人生意义有不同理解，例如：
 - 感受生活；
 - 创造价值；
 - 为社会做贡献；
 - 活得精彩。
 - 他强调：**人生意义没有标准答案**，它应当来自个体自己的体会。
-

十三、卡伦·霍尼与“被爱的渴求”

【考点】老师在这里引入卡伦·霍尼（Karen Horney）的观点。

- 卡伦·霍尼是**新精神分析学派**（Neo-Freudian / neo-psychoanalytic school）的重要代表人物。
- 老师引用她的思想来解释：
 - 人的心理健康不仅需要物质营养，还需要**精神营养**（emotional nourishment）；
 - 其中最关键的是**真挚、温暖、持续的母爱**（maternal love）。
- 老师特别强调“**被爱的渴求**（need to be loved）”：
 - 一个人若从小缺乏稳定、无条件的爱，
 - 可能在成长中形成不安全感、自卑感、人际困难，
 - 更容易在受挫时把失败理解为“没人爱我”“我被抛弃了”。
- 老师把这一理论应用到胡鑫宇案例中：
 - 胡鑫宇在困境中向家长求助却被拒绝，
 - 可能进一步强化了“只有我学习好，家人才爱我”的条件性信念，
 - 最终发展成绝望感。
- 老师据此判断：
 - 胡鑫宇的社交障碍不只是单纯内向，
 - 也可能与成长中情感支持不足有关。

【学习建议】缺乏被爱体验的人，更需要通过后天学习来培养：

- 主动爱人的能力；
- 建立关系的能力；
- 感受支持、接受支持的能力。

十四、第二节：学生心理危机的三级预防

【考点】本节后半部分正式转入**三级预防**（three levels of prevention）。

1. 一级预防（primary prevention）

- 含义：**消除病因或减少致病因素**；
- 核心：在危机发生前进行预防，防患于未然；
- 目标：尽量不让心理危机发生。

2. 二级预防（secondary prevention）

- 核心是“三早”：
 - **早发现**（early detection）
 - **早诊断**（early diagnosis）
 - **早治疗**（early treatment）
- 含义：危机已经出现苗头或已经发生，此时要及时识别、及时干预，争取快速缓解、改善预后（prognosis）。

3. 三级预防（tertiary prevention）

- 核心：**康复**（rehabilitation）与**防复发**（relapse prevention）；
- 目标：
 - 减少再次发生；
 - 减少心理残疾或长期功能损害；
 - 帮助个体尽快恢复社会功能。

【可能考简答】学生心理危机三级预防的定义与区别。

十五、老师提到的社会层面防自杀共识

老师提到，世界卫生组织认为并非所有自杀都能完全避免，但可通过公共策略降低风险。

1. 减少获取自杀手段的机会

- 例如限制高致死性农药的使用；
- 强调管制枪文、危险器具的重要性。
- 老师借中美差异举例，说明**高致死性工具的可得性**（access to lethal means）会显著影响非正常死亡风险。

2. 积极治疗精神障碍患者

- **精神分裂症**（schizophrenia）、**抑郁症**（depression）等患者是高风险人群；
- 因此要做到及时诊断、及时治疗；
- 老师提到我国对**六类重症性精神疾病**（severe mental disorders）进行登记管理。

3. 对自杀未遂者进行随访

- **自杀未遂**（suicide attempt）者后续再自杀风险较高；
- 因此不能把“救回来”当作问题终点，而应持续随访与干预。

4. 负责任的媒体报道

【考点】老师强调：自杀具有一定“传染性”或模仿效应（contagion / imitation effect）。

- 媒体过度渲染具体事件、地点、方式，可能引发模仿；
- 但完全不报道也会带来隐患，因为公众可能缺乏警觉和重视。
- 这体现出危机传播中的平衡问题。

5. 培训基层卫生保健人员

- 需要建立心理危机识别和干预队伍；
 - 基层人员是学生心理问题早期识别的重要力量。
-

十六、学生心理危机重点人群：七类高风险对象

【考点】老师明确列出学生中的七类重点人群（high-risk groups）。

1. 有家族史者（family history）

- 直系亲属中有精神疾病者，个体心理脆弱性可能更高。

2. 有既往史者（past history / previous psychiatric history）

- 过去曾发生过精神疾病或严重心理问题者，再次失衡风险更高。

3. 单亲家庭学生（single-parent family）

- 可能面临：
 - 经济压力；
 - 家庭角色功能不足；
 - 教养支持不完整。

4. 经济困难学生（financial hardship）

- 容易自卑、压力大，物质支持不足会放大心理困境。

5. 存在人格缺陷者（personality vulnerabilities）

- 老师列举：
 - 内向；
 - 敏感；
 - 脆弱；
 - 完美主义（perfectionism）；
 - 高自尊；
 - 孤僻；
 - 执着、死心眼等。

6. 遭遇应激事件者（stressful life events）

- 如：
 - 重大考试失败；
 - 失恋；
 - 财产损失；
 - 慢性疾病；
 - 其他重大挫折与丧失。

7. 已出现精神症状者

- 如：
 - 焦虑（anxiety）；
 - 抑郁（depression）；
 - 幻觉（hallucination）；
 - 妄想（delusion）等。

【可能考简答】学生心理危机重点人群有哪些。

十七、心理危机的高发时间、年级与场所

1. 高发时间

- 春夏之交（4—5月）
- 秋冬之交
- 老师认为换季时部分敏感个体更容易出问题。

2. 高发年级

- 新生入学阶段问题较多，因为适应困难；
- 但总体上，临近毕业年级问题更严重。
- 原因在于：

- 毕业压力；
- 毕不了业；
- 考研失败；
- 就业困难；
- 异地恋与未来选择冲突等多种矛盾交织。

3. 高发场所

- 老师引用调查资料指出，大学生校内自杀中：
 - 以**跳楼**最常见；
 - 主要发生在**宿舍楼、教学楼**等场所；
 - 许多事件发生在校内高层建筑。
- 老师强调：
 - 六楼以上高层建筑应加强管理；
 - 楼道、窗户等处应做好安全防护。

【考点】危机防控不仅要关注“人”，也要关注“地点”和“环境”。

十八、学校层面的一级预防：课程与活动

1. 心理健康教育课程的重要性

【学习建议】老师强调：

- 大学课堂教育仍是心理健康知识传播的**主渠道（main channel）**；
- 应用学生喜闻乐见的方式进行宣讲；
- 要树立“**健康第一，学业第二**”的观念。

老师传达的核心价值包括：

- 热爱生命；
- 热爱生活；
- 了解自己；
- 接纳困难；
- 明白“办法总比困难多”。

2. 参与心理健康教育活动

- 老师认为，单靠理论课印象往往不深；
- 还需要通过体验式活动提升认知与自我察觉能力。

十九、学校特色活动之一：内观认知疗法训练班

【考点】老师重点介绍了学校的**内观认知疗法（Naikan-based cognitive training / introspective cognitive therapy）**培训班。

1. 基本情况

- 已举办**60多期**；
- 截至去年，完成学员**2600多人**；
- 今年学校“525心理健康月”仍将继续推广。

2. 理论来源与形式

- 老师认为其源于**佛教禅修（Buddhist meditation / Zen-inspired introspection）**；
- 主要形式是**选择性回忆（selective recollection）**；
- 采用体验式训练；
- 一般持续**一周**。

3. 组织方式

- 通过简易屏风等形式营造体验环境；
- 每天集中数小时进行体验；
- 让学生通过回顾自身经历，察觉自身问题并促进成长。

4. 效果统计

老师给出了对300多名学生的统计结果：

- 三个问题中解决**两个**的占**63.4%**；
- 解决**一个**的占**19.1%**；
- **一个都没解决**的占**17.5%**；
- 总有效率约**82.5%**。

【考点】这里可能涉及对活动效果的理解与记忆。

5. 老师举的适用问题例子

- 自卑；
- 疑病倾向 / 过度担心自己患病；

- 人际关系问题；
- 情绪导致的身体不适。

6. 老师总结其核心作用

- 学习感恩（gratitude）
- 学会体谅（empathy / understanding others）
- 改变认知方式，学会珍惜已有、理解他人、减少怨恨与冲突。
【举例】老师用“追求异性成功或失败”举例，说明：
 - 得到后容易不珍惜；
 - 得不到时容易怨恨；
 - 通过内观训练，应学会珍惜拥有、尊重他人选择、减少执念与伤害性反应。

二十、学校特色活动之二：中国森田疗法研修班

【考点】老师重点介绍了森田疗法（Morita therapy）。

1. 创立者与地位

- 创立者：日本学者森田正马（Shoma Morita）
- 创立时间：1919年
- 老师称其为东方心理疗法的重要代表，可与精神分析并列讨论。

2. 理论来源

- 老师认为其思想本质上与中国道家哲学（Taoist philosophy）密切相关。
- 核心理念可概括为：
 - 接纳客观（accept reality）
 - 为所当为（do what should be done）
 - 顺其自然（let feelings be, act with purpose）

3. 适应范围

- 神经症（neurosis）
- 酒依赖（alcohol dependence）
- 失眠（insomnia）
- 适应障碍（adjustment disorder）
- 应激障碍（stress-related disorder）
- 抑郁症等

4. 老师对森田疗法原理的解释

- 人出现心理问题，本质上往往是主观与客观不一致；
- 个体总想用主观去强行改变客观，结果失败；
- 森田疗法的作用是让主观逐渐适应客观，从而减轻痛苦。

5. 老师的学术活动与案例

- 老师提到自己曾赴日本参加相关会议；
- 介绍了与糖尿病视网膜病变（diabetic retinopathy）患者合作开展森田疗法干预的研究：
 - 该类患者常伴有抑郁、焦虑；
 - 情绪差会降低治疗依从性（adherence/compliance）；
 - 接受森田疗法后，患者依从性及病情控制优于对照组。

6. 学校近期活动安排

- 老师计划在525心理健康月期间开办免费森田疗法体验班；
- 形式包括：
 - 线下讲座；
 - 线上40天体验；
 - 每天推送短课；
 - 研究生担任指导老师；
 - 每天约体验1小时；
 - 结业后发证书。

7. 老师概括的森田疗法最终目标

- 自我管理（self-management）
- 规律生活；
- 吃好、睡好；
- 接纳情绪；
- 顺其自然；
- 为所当为；
- 改善人际关系；
- 获得社会支持；
- 及时识别症状并主动求助。

二十一、三级预防的落脚点：接纳困难，及时求助

【学习建议】结尾部分，老师把三级预防落到现实生活中的态度和行动上。

- 每个人都不是“神仙”，都会遇到暂时过不去的困难。
- 关键在于“永远没问题”，而在于：
 - 能否接纳自己的困难；
 - 能否及时求助；
 - 能否在问题早期进行处理。
- 老师明确反对：
 - 好面子；
 - 打肿脸充胖子；
 - 讳疾忌医（hide illness and avoid treatment）。
- 他强调：
 - 有些问题不是“硬扛”就能过去；
 - 及时求助并不丢人，反而是成熟和负责的表现。

本节英文术语索引

- 心理危机 — psychological crisis
- 危机干预 — crisis intervention
- 预防 — prevention
- 一级预防 — primary prevention
- 二级预防 — secondary prevention
- 三级预防 — tertiary prevention
- 早发现、早诊断、早治疗 — early detection, early diagnosis, early treatment
- 康复 — rehabilitation
- 预后 — prognosis
- 防复发 — relapse prevention
- 内向型人格 — introverted personality
- 睡眠障碍 — sleep disturbance
- 早醒 — early morning awakening
- 入睡困难 / 失眠 — difficulty falling asleep / insomnia
- 节律紊乱 — circadian rhythm disturbance
- 重度抑郁 — major depression / severe depressive state
- 社交障碍 — social impairment / social dysfunction
- 回避 — avoidance
- 自责 — self-blame
- 自我否定 — self-denial
- 心身症状 — psychosomatic symptoms
- 厌食 / 食欲下降 — loss of appetite / anorexia
- 情绪低落 — depressed mood
- 轻生观念 / 自杀意念 — suicidal ideation
- 自杀意愿 — suicidal intent
- 自杀未遂 — suicide attempt
- 家族史 — family history
- 既往史 — past history / previous psychiatric history
- 应激事件 — stressful life events
- 焦虑 — anxiety
- 抑郁 — depression
- 幻觉 — hallucination
- 妄想 — delusion
- 负性认知 — negative cognition
- 主动求助 — help-seeking
- 生命意义 — meaning of life
- 被爱的渴求 — need to be loved
- 母爱 — maternal love
- 新精神分析学派 — neo-psychoanalytic school
- 卡伦·霍尼 — Karen Horney
- 声音鉴定 — forensic audio analysis / voice identification
- DNA 比对 — DNA matching
- 录音笔 — voice recorder
- 内观认知疗法 — Naikan-based cognitive training / introspective cognitive therapy
- 选择性回忆 — selective recollection

- 感恩 — gratitude
- 体谅 / 共情理解 — empathy / understanding others
- 森田疗法 — Morita therapy
- 森田正马 — Shoma Morita
- 神经症 — neurosis
- 酒依赖 — alcohol dependence
- 适应障碍 — adjustment disorder
- 应激障碍 — stress-related disorder
- 自我管理 — self-management
- 社会支持 — social support
- 糖尿病视网膜病变 — diabetic retinopathy
- 依从性 — adherence / compliance

这节课如果你还要的话，我也可以继续给你补一个“**极简背诵版**”，专门提炼出老师最可能考、最值得期末前速看的内容。

第7讲：心理问题的客观存在、主观加工与应对思路

- 课程：心理危机干预与预防
- 老师：李建伟
- 日期：2026-04-14

一、课前说明：下次考试与本节课程安排

【考务】老师一开始先说明下次课是**考试**，要求如下：

- 下次课一定要**准时到达**。
- 考试形式是**开卷考试（open-book exam）**。
- 但不允许带电子设备，只能带**纸质资料**。
- 参加考试时带**学生证**即可。
- 没来的同学要互相通知，下周记得来参加考试。
- 老师强调：只要认真作答，**一般不会故意为难大家，但不能缺考**。

【课后任务】每次课后会有几道题，这次课后也会布置**两道非常简单的题**，提醒大家不要忘记完成。

【课程安排】本来这节课计划是本课程最后一次课的**电影赏析**，但因为播放器出了问题，影片无法播放，所以改为继续讲课。老师顺便推荐了一个比较符合心理学口味的电影系列：

【举例】《头脑特工队》（*Inside Out*）

- 老师认为，这类作品体现了西方思维的一种特点：喜欢把人的情绪拆分、分析其构成与原因。
- 这种思维方式有其优势：能够把问题描述得比较清楚。
- 但它也有局限：**把问题说清楚了，不等于就有办法解决问题**。
- 老师借此引到医学中的类似现象：病因、机制可能讲得很清楚，但真正可用的治疗办法并不一定很多。

二、导入：心理问题“看不见、摸不着”，但客观存在

老师指出，心理学要帮助大家换一个角度理解心理问题的产生与存在方式。

1. 每个人都在散发不同的“心理状态”

老师让大家体会：虽然大家都坐在教室里，但每个人其实都带着不同的信息、状态或“气场”：

- 有些人焦虑；
- 有些人没有动力；
- 有些人静不下来，必须不断干点别的事。

【举例】老师提到一个来访者：

- 一会儿看电视，一会儿刷手机；
- 很难专注于做一件事情；
- 自己怀疑是不是 **ADHD（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder，注意缺陷多动障碍）**。

老师的判断是：

- 这人高中以前学习还不错，因此**未必真的是 ADHD**；
- 更重要的问题在于：**无法和自己独处**，一旦独处就受不了，像要“发疯”一样；
- 所以他不是单纯“坐不住”，而是**难以承受与自己相处时的内在状态**。

老师借这个例子强调：心理困扰不是一句“你坐那儿看书不就行了吗”就能解决的，因为当事人**不是不想，而是做不到**。

2. 心理问题的第一个核心认识

【重点】心理问题有一个非常重要的特点：

- **看不见**
- **摸不着**
- 但它在每个人内在都是一种**客观存在（objective existence）**

老师进一步解释：

- 对于看得见、摸得着的东西，人容易找到调控对象、找到“靶点”。
- 但如果一个对象既看不见又摸不着，你还要去调控它，就会变得特别困难。
- 这正是心理学面临的特点：它明明存在，却不易直接把握。

3. 每个人都不一样

老师再次强调个体差异：

- 有人喜欢孤独；
- 有人无法忍受孤独；
- 有人渴望被赞许；
- 有人一接触他人就紧张。

这些都说明：心理状态确实存在，而且**个体之间差异极大**。

三、为什么这个时代心理问题更多

老师提出一个问题：为什么现在这个时代心理问题特别多？并追问大家：

- 你们现在还高兴吗？
- 还快乐吗？

老师的判断是：现在这个时代，敢明确说自己很高兴、很快乐的人，其实很少。

1. 外部信息不断侵入精神世界

老师认为，现在每个人基本都有：

- 手机
- 电脑

而我们的精神世界不断被外部信息占据。这些信息往往带有：

- 情绪化
- 不安稳
- 焦灼
- 刺激性

【重点】任何信息都会在大脑中留下痕迹。长期如此，人的整体精神状态就会变得：

- 不平稳
- 更容易情绪化
- 更容易焦虑和不安

四、案例一：不会做题就崩溃——内在批评声音的发现

【举例】老师讲了一个高中生的案例。

1. 表面表现

这个学生的特点是：

- 一道题不会做，就会崩溃
- 所谓崩溃，就是必须大哭一场

家人会劝他：

- 不会做题很正常；
- 哭也解决不了问题。

但老师强调：这恰恰说明一个事实——**心理问题是客观存在的**，不是靠讲道理就能立刻改变。

2. 崩溃后的反应链

这个学生的典型反应是：

1. 题不会做；
2. 崩溃大哭；
3. 哭完以后头晕；
4. 倒头睡觉，睡很久；
5. 睡完以后才稍微缓过来。

3. 心理咨询中的分析路径

老师借此说明心理咨询的思路：

- 不是只看外在行为；
- 而是顺着“当时你是什么感觉”这个线索往下找。
老师指出，心理学某种意义上就是帮助人**认识自己**。
于是继续往下追问：
- 当题不会做的时候，你内心到底发生了什么？

4. 找到“内在批评者”

在咨询中，这个孩子逐渐意识到：

- 当题不会做的时候，
- 他总感觉旁边有一个**强烈的声音在批评他**。

这个声音像什么？

- 像一个一直盯着自己的“第三只眼”；
- 像一个不断审视、指责自己的存在。

老师借此和同学们建立共鸣：

【提示】如果你自律性特别强，常常感觉总有一个声音在盯着自己、批评自己、要求自己，那说明你活得并不轻松，你的内在是被掌控住的。

5. 这个声音具体在说什么

在进一步还原时，这个学生感受到那个声音像在说：

- “你这个题又不会做。”
- “你这个题都不会做。”

问题在于：

- 这个声音一来，他**没法反驳**；
- 也**没法对抗**；
- 所以会一下子崩溃。

6. 双椅技术 (empty-chair / two-chair technique)

老师在这里提到心理咨询中的一个技术：

【术语】双椅技术 (two-chair technique / empty-chair technique)

大意是：

- 把内在那个批评自己的部分“具象化”出来；
- 让来访者尝试和那个声音、那个“人”对话；
- 例如对它说：“你别总这样批评我。”

但在实际操作中，这个学生一旦被要求去“面对”那个内在批评者时，立刻表现出强烈恐惧：

- 整个人一下子转过去；
- 明明没有外人；
- 但他就是**不敢看“它”**。

老师借此再次强调：

【重点】心理问题是真实不虚的。虽然你看不见、摸不着它，但你可能**根本控制不了它**。

五、精神世界像“心田”：长什么，决定你活成什么样

老师随后引入一个比喻：

- 人的内在精神世界，像一块**田地（心田）**。

1. 心田里如果是石头和杂草，就长不出好庄稼

如果一块田里有很多：

- 石头
- 杂草

那么它自然长不出好的庄稼。

老师将其类比到人的内在：

- 一个人很痛苦时，心里长出来的常常是：
 - 痛苦
 - 抱怨
 - 不满
- 一个人若内在能长出：
 - 感恩
 - 快乐
 - 高兴

那他活得就会轻松自在。

2. 抱怨型人格的理解

老师指出：

- 如果一个人总在抱怨别人哪里不对、哪里不好，
- 可以高度怀疑：他的“心田”里长不出丰盛的庄稼，只能长出“杂草”。

3. “我必须……”带来的僵化

老师还提到一种常见的内在状态：

- “我必须怎么样”
- “我一定要怎么样”

【易错理解】这类念头表面看像上进、自律，实际上会让人的精神世界变得：

- 固定
- 僵硬
- 不灵活

而这恰恰会带来更大的痛苦。

4. 一个颠覆性的观点：痛苦未必主要来自外在环境

老师特别强调一个他认为很重要的观点：

- 很多人以为自己的痛苦都是外在环境造成的；
- 但实际上，**即使没有这个事情，也会有别的事情冒出来困扰你**。

也就是说：

【重点】现在的痛苦，不一定主要取决于当前的外在环境；更核心的是，你的内在本身就有让你痛苦的“种子”或模式。

六、案例二：强迫症的迁移——困扰会不断换对象

【举例】老师讲了一个强迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）患者的经历，用来说明痛苦背后是同一种内在焦虑在不断“发芽”。

1. 小时候：担心脚卷入自行车后轮

- 父亲骑自行车送他上学；
- 他坐在后面，总想：
 - 如果自己的脚塞进后车轮、车辐条，会怎样？
- 因此非常痛苦，还埋怨父亲不要骑车送他。

后来：

- 住校了；
- 不骑车了；
- 这个问题暂时没了。

2. 上高中：开始被物理“受力分析”困住

高中物理后，他又开始出现新困扰：

- 走路时不停分析脚受了哪些力；
- 这个力是怎么产生的；
- 脑子停不下来。

他当时以为：

- 只要不学物理了，
- 自己就自由了。

3. 上大学：又被马克思主义原理困住

后来不学物理了，又进入大学。结果又出现新的强迫性困扰：

- 为什么第一章讲这个？
- 为什么第二章讲那个？
- 为什么这个内容要放在最后一章？

他会反复琢磨：

- 必须把这个逻辑彻底搞明白；
- 搞不明白，别的内容都看不进去。

而且偏偏考研还会考这部分，于是他和这个问题较劲了四五年。

4. 工作后：困扰再次换壳

后来工作了，不考这些理论了，但他当了老师以后，新的困扰又冒出来：

- 物理力学该怎么给学生讲？
- 这个力学关系到底怎么来？

【结论】老师借这个案例说明：

- 表面看，人的困扰对象一直在变；
- 但核心不在这些具体对象本身；
- 核心在于你内在有一个**焦虑、痛苦的种子**，它会不断寻找新的载体发芽。

所以：

【备考/理解重点】不要以为“等十年后离开这个环境我就好了”。老师的意思是：如果根本模式不变，换了环境也可能继续痛苦。

七、情绪幸福感相对稳定：心理状态具有持续性

老师提到一个调查研究，大意是连续测量人的情绪幸福指数，结果发现：

- 假设满分 10 分；
 - 有的人长期大约在 3 分；
 - 有的人长期大约在 10 分；
- 即便过了很多年，这种总体倾向也相对稳定。

老师借此说明：

- 如果你现在总觉得活得痛苦，
- 十年以后可能仍然容易有类似感觉；
- 如果你现在比较愉快、关系也好，
- 十年以后也可能保持这种倾向。

他借此再次说明：

【重点】心理问题有其**客观实在性**，不是别人说一句“想开点”就能马上改变。

八、老师对心理问题的总结：主观性、必然性、主导性

老师说，这三个特点是他自己的总结。

（一）主观性 (subjectivity)

- 每个人的痛苦程度和痛苦方式都不一样；
- 没有两个人的痛苦是完全相同的。

【举例】社交恐惧 / 社交焦虑障碍 (Social Anxiety Disorder, SAD)

1. 女生常见表现

- 一说话就脸红；
- 脸红后觉得很丢人；
- 越觉得丢人越紧张；
- 脑子一片空白；
- 更说不出话；
- 最终形成闭环。

2. 男生常见表现

老师举了一个门诊案例：

- 这个男生不敢出去开会；
- 起初老师以为可能是广场恐惧症 (agoraphobia)，因为有些人会不敢坐火车、不敢去公共场所；
- 但对方说不是，他敢坐火车，问题在于：
 - 开会休息时大家会去厕所；
 - 他不敢去公共厕所。

老师指出：

- 男性的社交焦虑障碍，有时会表现为不敢去公共厕所；
- 这可以是其典型表现之一。

3. 另一位社交焦虑来访者：上班像“上坟”

这个来访者每天上班非常痛苦，原因不是工作本身，而是怎么和人相处让他极度焦虑：

- 坐地铁时担心遇到同事：
 - 要不要打招呼？
 - 遇到领导怎么打？
 - 遇到普通同事怎么打？
 - 拿着豆浆和领导打招呼合不合适？
 - 干脆不坐电梯，去爬楼梯；
 - 到工位还要经过几排桌子，又开始纠结：
 - 要不要和同事打招呼？
 - 如果对方没看我，我要不要主动打？
- 白天好不容易熬过去了，下班后还不轻松，还要不断复盘 (rumination)：
- 我早上说的话妥不妥当？
 - 别人会不会觉得我蠢？

结果每天筋疲力尽。

老师借此说明：

【重点】对有些人来说，和人交往根本不是“小事”，而是一个巨大的痛苦来源。这就是心理问题的主观性。

（二）必然性

老师接着举了疑病症 / 疾病焦虑障碍这一类例子（按语境应为疑病相关表现）。

【举例】一个高中女生担心自己得了狂犬病：

- 她常去喂小区里的流浪猫；
- 有一天发现原来5只猫，现在只剩4只；
- 她立刻联想到：
 - 少的那只是不是得狂犬病死了？
 - 那会不会传染给我？

结果：

- 一夜没睡；
- 恐惧袭来以后，怎么劝都不行。

父母带她去查：

- 调监控；
- 去防疫站咨询；
- 医生说没有抓伤、没有外伤，问题不大；
- 她仍然不放心。

然后她使出焦虑者的“必杀技”：

- “万一呢？”

因为医生也不可能绝对担保，她就继续陷在恐惧里。

即使后来去做抗原抗体检测、结果没事，她还是会在网上继续查资料。结果又看到一些信息，说某些阶段可能检测也未必能完全排除，于是焦虑仍然存在。

她每次见老师都很绝望，甚至说：

- 狂犬病潜伏期大概多久；
- 过几天可能你就见不着我了。

老师借此说明“必然性”的意思：

- 家长会觉得：如果她不去喂流浪猫，就不会有这个问题；
- 但老师的判断是：**即使不是这件事，她也会被别的事情困住；**
- 因为她身体里、内在里本来就存在一个等待爆发的恐惧模式。

也就是说：

【重点】心理问题不是单纯偶然被某件事“制造”出来的，而是内在模式遇到机会后**必然会寻找出口**。

另一个例子：收入问题并不是焦虑真正原因

另一个来访者曾说：

- 我的问题你解决不了；
 - 因为我现在焦虑，是因为工作不好、没有收入；
 - 只要收入好了，我就会好多了。
- 但后来他真的收入变好了，焦虑反而更大。于是他才意识到：
- 自己过去以为的“原因”，并不是真正原因；
 - 心理问题更像是身体内部早就存在的东西。

（三）主导性

老师用强迫症继续解释“主导性”。

【举例】一个大货车司机：

1. 诱发事件

- 开大货车拐弯时，把旁边一辆电动车挂倒了；
- 从那以后，他开始反复担心：
 - 我会不会又挂到别人？

2. 问题扩展

- 开车时别人往前看，他总忍不住往后看；
- 后来家人和别人觉得这样不行，干脆别开大货车了。

3. 症状迁移

- 不开大货车后，改骑电动车；
- 骑电动车到了人多的地方，又担心会不会碰到别人；
- 于是电动车也不敢骑了。

4. 徒步时继续检查

- 家里劝他要“克服困难”，去人多的地方；
- 他每次咬牙去，但总是不断检查：
 - 我是不是撞到别人了？
 - 我是不是碰到别人了？

老师强调：

【重点】真正让他越来越严重的，不只是最初那个念头，而是后面不断发生的：

- 反复检查
- 不断对抗
- 不断卷入

这就是心理问题的“主导性”：

- 问题一旦发生，
- 你越和它缠斗、越对抗它，
- 它往往越厉害。

九、痛苦与“增容”：老师对苦难的理解

接下来老师从更宏观、更价值性的角度谈“痛苦”。

1. 不要只盯着“我有多痛苦”

【举例】有来访者问老师：

- 你见过比我遭受更严重痛苦的人吗？

老师后来用**郑和**做例子来回应：

- 郑和原本是官宦家庭出身；
- 后来家破人亡，又遭到极大的人生创伤；
- 从处境上看，其痛苦远超一般人。

老师用这个例子想说明：

- 不要一直沉浸在“我最痛苦”里；
- 更重要的是：**你如何把痛苦转化成力量，走出来。**

2. 历史上能成事的人，往往都经历过磨难

老师的观点是：

- 历史上凡是对社会有积极贡献的人，
- 往往都经历过许多痛苦和磨难。

因为：

- 人只有经历事，能力才会被锻炼出来；
- 如果一直顺利，容量就不会被扩大。

3. 心理健康与“包容力”

老师提出：

【重点】心理健康，某种意义上就是你能**包容一切**的时候最健康。

- 当你包容不了某些东西时，就会非常痛苦。
- 所以磨难可以理解作为一种“扩容”“增容”。

老师的说法是：

- 过得去，容量变大，层次升高；
- 过不去，就容易被打落下去。

4. 换个角度看“难相处的人”

当来访者总说：

- “我有没有道理？”
- “明明就是对方不对。”

老师往往会回答：

- 你说得有道理；
- 但换个角度，那个人其实是来帮你**增容**的。

也就是说：

- 你连这样一个人人都包容不下，
- 那将来更复杂的人和事你怎么面对？

老师最后把这个观点总结成一句话：

【观点】人生不是按“道理”活的，而是按“心量”活的。

十、续讲：对心理问题的宏观理解与对自媒体的提醒

下半节课开始，老师希望大家形成对心理问题的宏观印象。

1. 少看自媒体

【学习建议】老师明确提醒：

- 尽量少看自媒体。

理由包括：

- 做自媒体的人为了生存，需要不断输出；
- 会非常消耗精气神；
- 平台内容里有大量情绪宣泄，不一定真正有助于解决问题。

老师观察到：

- 如果网上发积极、阳光的内容，未必有多少人点赞；
- 但如果发抱怨、不公平、受委屈的内容，点赞会非常多。

这说明：

- 自媒体平台上很多内容迎合的是**情绪宣泄**；
- 而对于负面情绪，老师主张：

– **别和它纠缠**

– 越纠缠，越出不来

【举例】老师曾有一个学生在网上反复抱怨父母以前怎么对待自己，下面点赞很多。老师对他说：

- 别再发这些东西了；

- 发完之后，你的问题并不会真正解决。

十一、对“原生家庭决定论”的批评

1. 网络上常见说法：所有心理问题都来自原生家庭

老师特别点名这个流行观点：

【易错】“所有心理问题都是原生家庭（family of origin）的问题。”

老师对此持明显反对态度。

2. 老师的理由

他举了一个历史社会层面的观察：

- 50年前，中国很多家庭有五六个、七八个孩子；
- 如果真的是原生家庭决定一切，
- 那同一个家庭里所有孩子都应普遍出问题；
- 但现实并非如此。

因此老师认为：

- 原生家庭可能有影响；
- 但不能简单建立直接必然因果关系。

3. 为什么这样说仍然不够

老师说，仅仅这么讲没有说服力，因为当事人自己会觉得：

- “你看我父母就是这样对我的。”
- “我的痛苦就是他们导致的。”

于是老师继续用案例来说明：有时真正的问题，是个体自己的内在加工方式。

十二、案例三：同样一件事，不同的人加工完全不同

1. 关门声被体验成“暴力”

有位来访者从老师诊室离开后，老师像平常一样关门。下次对方来时却问：

- “你怎么这么暴力？”

老师很惊讶，对方解释说：

- 你关门声音那么大。

老师借此说明：

- 对他来说，普通关门声都能被体验成极大的冲击；
- 那么他平时如何体验父母的一声咳嗽、一次语气变化，就可想而知。

【重点】问题不只是外界发生了什么，更在于他的内在以什么方式加工这一切。

2. 同样的母亲行为，不同叙述方向完全相反

另一个例子：

例子 A：负向加工

有来访者回忆小时候和母亲去旅游：

- 到旅馆后，床上的被子不够；
- 母亲想去别的床上拿被子，结果和别人发生争执；
- 这个来访者由此把母亲加工成“有问题”“令人厌恶”的形象。

例子 B：正向加工

同样地，还有人说：

- 大学快毕业时，火车上有人挤了自己一下；
- 父亲五十多岁了，还要为自己冲上去和别人打架；
- 于是得出结论：父亲对我多好。

老师借这两个例子说明：

【重点】同样是“父母做了一件事”，不同的人内在加工出来的意义可以完全不同。而且最关键的是：每个人都觉得自己的加工是对的。

十三、再次总结：心理问题与原生家庭“有关”，但不能锁死成因果

老师在这里再次强调一遍：

- 心理问题和原生家庭可以有关系；
- 但绝不能简单归结为：
 - “我的问题全是父母造成的。”

因为一旦你这样归结：

- 你会把自己的人生解释权完全交给过去；
- 也就更难走出来。

老师认为，这类说法之所以“害人不浅”，是因为：

- 它符合人的痛苦模式；
 - 但不符合让人真正从痛苦中解脱出来的方法。
-

十四、人与世界如何互动，世界就如何回应你

老师把心理问题进一步提升到“精神世界”的层面来理解。

1. 你的方式，会塑造你得到的回应

老师提出一个命题：

- 你用什么样的方式和世界互动，
- 世界就会以什么样的方式回应你。

2. 如果你总觉得自己忙、累，你就不容易快乐

老师问大家：

- 你们是不是总觉得自己很忙、很累？
然后直接指出：
 - 如果你一直以“忙、累”的方式和世界接触，
 - 那么这种模式本身就会让你更难快乐。
-

十五、案例四：小熊一家——“心想事成”的负向验证模式

老师讲了一个小故事来说明“负向加工”如何把现实一步步导向自己最害怕的结果。

1. 故事背景

- 小熊以前没有和父母一起生活；
- 后来到了上学年纪，才被接到父母身边；
- 因为缺乏长期相处，小熊总有一种感觉：
– 父母不爱我。
父母也感到：
- 和孩子之间总有隔阂；
- 相处起来不轻松、不自在。

2. 一家人去野餐

熊爸爸为了改善关系，提议周末一家人去野餐。一开始大家都很开心。

3. 关键事件：让小熊回家拿起子

到中午吃饭时，罐头打不开，起子忘带了。熊爸爸就让小熊跑回家拿起子。

这一刻，小熊立刻冒出一个念头：

- 父母是不是故意把我支开？
- 我走了，他们是不是要背着我吃别的好吃的？
于是他说：
- 我不去；
- 我去了你们把别的东西吃了怎么办？
父母向他保证：
- 你不回来，我们不吃。

4. 结局

按理说来回最多一个小时，但：

- 一个小时过去了，小熊没回来；
- 两个小时过去了，小熊还没回来；
- 天快黑了，父母也饿了；
- 最后父母一人吃了一口面包，准备回家。
这时候，小熊从远处的树后哭着出来，质问：
- “你们说过什么？你们说过什么？”

5. 老师要说明的核心

这个故事不是在说谁“客观上”绝对错，而是在说明：

【重点】一个人如果内心先有了“他们不爱我”的预设，那么一遇到事情，就会往那个方向加工；一旦这么加工，就容易把事情一步步推成自己最害怕的样子。

老师把这种现象概括为：

【概念】“心想事成”也就是：你心里害怕什么，往往就更容易发生什么。

十六、恋爱中的“验证”会制造痛苦闭环

【举例】一个学生谈恋爱，刚开始很好，后来心里的“心魔”出来了：

- 总怀疑：对方到底爱不爱我？

于是开始验证。

1. 验证方式：发消息看是否秒回

- 如果秒回，就暂时安心；
- 如果对方没秒回，尤其在晚上睡觉时没有回，
- 她就开始焦虑，彻夜不安。

2. 反复验证

即便对方解释、安慰，过一段时间她又会想到：

- “万一他变心了呢？”

于是继续验证、继续试探。

3. 结果

最终对方被折腾得受不了，说了一句：

- “你这是无理取闹。”

她立刻崩溃，进一步确认：

- 你看，你都对我发火了；
- 这说明你就是不爱我。

老师借此说明：

【重点】如果你总去“验证”别人是不是爱你、在乎你、认可你，你很可能已经进入了痛苦的自动循环。

4. 老师给出的建议

【学习建议】如果有这种担心，不要一味验证，而要练习：

- 让自己平静下来；
- 和那个痛苦共处（coexist with distress）。

老师认为：

- 和痛苦共处，是人成长的必由之路；
- 如果一直追求一种“绝对安全”，那反而是最不安全的事。

并进一步总结：

【观点】人生很多痛苦，都是“太认真”造成的。“既来之，则安之。”

十七、为什么人天然更容易往负面加工：老师所谓的“魔”

老师接着追问：

- 为什么小熊总往负面想？
- 为什么大家一闲下来，很难自动加工出积极的内容？

老师的观点是：

- 人的头脑天然更容易往“危险”“不安全”“会出事”的方向加工；
- 很难自发稳定地产生积极、安稳的内容。

他把这种倾向称为：

【概念】“魔”

也就是：

- 头脑会自动加工：
 - 我不这么做会不会危险？
 - 我不这么做会不会出问题？
 - 我不这样努力将来会不会糟糕？

老师的意思是：这种倾向不是个别人有，而是人普遍存在的。

十八、借《西游记》谈“磨炼”与精神内核

老师引用《西游记》来说明：

- 人生中的种种困难、折磨，本身也可以视作一种“炼”。

他提到几个意象：

- 孙悟空为什么要在八卦炉里炼？
- 为什么会经历那么多磨难？
- 为什么经历关键冲突之后，团队反而更稳固？

老师把大家的现实生活比作也在“八卦炉”里被炼：

- 就像烤串一样，翻过来烤、调过去烤；
 - 有人能熬过去，有人会“烤糊”。
- 他的核心意思是：
- 若能在磨炼中练出“火眼金睛”，
 - 就能识破生活中很多看似重要、其实并不那么重要的东西；
 - 真正重要的是培养自己内在的精神品质。

1. 老师强调“精神内核”

他认为：

- 一个社会、一个国家、一个家庭，真正重要的是人有没有精神内核；
- 遇到困难时，是选择抱怨，还是选择承担、建设。

2. 家庭为什么会过不好

老师认为很多家庭的问题都在于：

- 每个人都理直气壮地抱怨别人不对；
- 但很少有人想着：
 - 我能为这个家付出什么？

他的结论是：

【重点】一个家庭若人人都想着付出、建设它，就不容易过不好；如果人人都盯着别人不对，这个家庭就会一直鸡飞狗跳。

十九、修身齐家：少责备，多承担

老师把这一层上升到中国传统文化的表达：

- 修身
- 齐家
- 治国
- 平天下

1. “齐家”不是要求别人，而是先承担自己那部分责任

老师认为：

- 在家庭中应先承担责任，而不是先责怪别人；
- 在集体中应先想着如何让集体更好，而不是总挑别人毛病。

2. “仁义礼智信”不是僵化教条

老师认为，传统文化中很多内容并不是死板教条，而是帮助人：

- 找到自己的位置；
- 承担自己的角色；
- 让社会按合理规则运转。

他以“君君臣臣，父父子子”为例解释说：

- 不是在强调盲目服从；
- 而是在强调：
 - 处在什么位置，就承担什么位置的责任。

3. “礼崩乐坏”的理解

老师的解释是：

- 当人心完全被负面、抱怨、挑剔、私欲所控制时，
- 社会就不能按合理规则运转，
- 就会出现秩序紊乱。

二十、识人之术：远离持续抱怨外界的人

【学习建议】老师提醒大家：

- 对于那种整天抱怨：
 - 这个人不好
 - 那个事不对
 - 外界全错
 - 的人，要尽量远离。
- 老师的理由是：
- 一个人心里装着什么，就更容易看到外界什么。

1. 苏东坡与佛印的故事

老师讲了两个与苏东坡、佛印有关的故事。

故事一：八风吹不动，一屁打过江

苏东坡自觉修养很好，觉得自己“八风吹不动”，写给佛印看。佛印只回了一个“屁”字。苏东坡顿时生气，跑去理论。

佛印借此指出：

- 你不是说自己不动心吗？
- 怎么一个“屁”字就把你打过江来了？

老师用这个故事说明：

- 表面上的“看开”不算真功夫；
- 真正的心量，是能不能经得起刺激。

故事二：心里有什么，就看别人像什么

苏东坡说：

- 我看自己像佛；
- 看别人像狗屎。

佛印说：

- 我看你像佛；
- 我看自己像狗屎。

后来苏东坡妹妹提醒他：

- 你心里有什么，才会看到别人像什么；
- 佛印心里有佛，所以看你像佛；
- 你心里装着“狗屎”，才会看别人像狗屎。

老师借此总结：

【重点】如果你总觉得这个世界到处都不对、别人都不行，往往也说明你自己的内在加工层次出了问题。

二十一、关于目标、努力与放松

老师最后又谈到“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”。

1. 太执着于目标，反而容易痛苦

老师提醒大家：

- 如果你特别执着于某个目标，
- 到了“我必须得到它”的程度，
- 那往往会让自己很痛苦。

因此他建议：

【学习建议】对自己宽容一点，目标放一放，别总和自己过不去。

二十二、临下课前的两道题提示

【考点/课后题提示】老师提醒大家，课后有两道选择题，大约10分，而且都很简单，实际上课上已经讲到答案方向了：

1. 第一题

- 当事情涉及危机时，
- 生命最重要。

2. 第二题

- 当困难超出自己能力范围时，
- 不要自己硬扛；
- 可以：
 - 听课学习
 - 做心理咨询
 - 和朋友倾诉

二十三、人生建议：千里马常有，而伯乐不常有

临下课前，老师又讲了关于人生发展的一些思考。

1. 大家都是“千里马”

老师认为：

- 在座各位都可以是“千里马”；
- 但问题在于，未必总能遇到真正识别和使用人才的环境，也就是“伯乐”。

2. 人生中三个“好”很重要

老师认为，一个人若有下面三个条件，人生会顺很多：

1. **好的父母**：给予基础支持；
2. **好的老师**：帮助你找到适合自己的方向；
3. **好的团队/好的老板**：给你发挥能力的舞台。

3. 因材施教 (teaching students in accordance with their aptitude)

老师谈到“好的老师”时，提到了孔子的一个重要观念：

【术语】因材施教

老师的理解是：

- 真正好的老师，不是让所有人都走同一条路；
- 而是帮助你发现：
 - 你的天命在哪里
 - 你的天赋在哪里
 - 你真正适合做什么

4. 良心拷问：你真的喜欢自己学的专业吗？

老师最后问大家：

- 你真的喜欢现在学的专业吗？
- 如果实在不喜欢，就不要只是机械地逼迫自己。

他的意思是：

- 若天赋、兴趣根本不在这里，
- 一味苦撑，可能是在浪费生命。

5. 如何判断什么是你真正适合的事

老师给了一个标准：

【判断标准】如果有一件事情：

- 没有外在报酬；
 - 没有人肯定你；
 - 暂时也没有结果；
- 但你做起来依然：

- 开心
- 快乐
- 愿意一直做

那它很可能就是你真正擅长、真正适合的方向。

老师鼓励大家：

- 不要放弃这种事情；
- 继续坚持下去，
- 你会更轻松地向自己的目标 and 成绩。

本节英文术语索引

- 心理危机干预 – psychological crisis intervention
- 开卷考试 – open-book exam
- 注意缺陷多动障碍 – Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
- 心理咨询 – psychological counseling / psychotherapy
- 双椅技术 – two-chair technique / empty-chair technique
- 精神世界 – mental world / inner psychic world
- 社交恐惧症 / 社交焦虑障碍 – Social Anxiety Disorder (SAD)
- 广场恐惧症 – agoraphobia
- 强迫症 – Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)
- 疑病症 / 疾病焦虑障碍 – illness anxiety disorder / hypochondriasis
- 主观性 – subjectivity
- 客观存在 – objective existence
- 因材施教 – teaching students in accordance with their aptitude

如果你愿意，我下一条可以继续把这份笔记再压缩成一版更适合考前速看的“提纲版”。